

CÉSAR¹

COMUNICAÇÃO VERBAL E SAÚDE PSICOLÓGICA

Um manual de psicossanitarismo

¹ Psicólogo (PUC-RJ, 1970), Mestre em Psicologia Clínica (PUC-RJ, 1976), Ex-Professor de Psicanálise e Diagnóstico Psicopatológico (PUC-RJ), Ex-Professor de Psicanálise (Associação Universitária Santa Úrsula), Diretor do Instituto de Psicologia Clínica Ltda, exerce atividade psicoterápica desde 1978 (e-mail: loganalise@gmail.com)

INTRODUÇÃO

O Big Bang da Atividade Psicoterápica

Tudo começou assim:

Bertha Pappenheim,

que entrou para a história da Psicologia sob o pseudônimo de Anna O., apresentava um impressionante leque de sintomas: alucinações, parestesias (distúrbios da sensibilidade), parafasias (distúrbios da fala – esquecia, por exemplo, determinadas palavras de sua língua materna, o alemão, tendo que recorrer a palavras de outra língua, mormente o inglês, para preencher essas lacunas), estrabismo convergente, diplopia (visão dupla), macropsia (visão aumentada dos objetos), micropsia (visão diminuída dos objetos), paralisias etc.. Mas, dentre todos seus sintomas, um se presta particularmente a nossas atuais investigações: em suas crises, ao tentar sair de seu quarto, fazia-o sempre por um mesmo lugar, diferente daquele onde estava a porta. Seu médico, um vienense chamado Josef Breuer descobriu a razão disso. Bertha mudara, havia um ano, de residência. Nas palavras do próprio Breuer, a paciente, durante essas crises, “era levada para o ano anterior com tal intensidade que, na nova casa, ela alucinava seu antigo quarto, de forma que, quando desejava se dirigir à porta, batia contra o aquecedor que ficava na mesma relação com a janela que tinha a porta em seu quarto anterior.”²

Josef Breuer (1842-1925) era renomado médico vienense, com importantes descobertas na área da Neurofisiologia. Breuer tornou-se mentor de Sigmund Freud (1856-1939), formando de medicina, ajudando-o a estabelecer-se na prática médica. O pupilo se interessou grandemente em acompanhar os relatos de seu mentor sobre a evolução do caso em pauta, sendo levado, durante o restante de sua longa vida, a desenvolver o que terminou por denominar de técnica psicanalítica, embora tenha reconhecido, ter sido Breuer “o primeiro a fazer uso desse tipo de procedimento”³.

Dos entusiasmados debates travados por ambos sobre a matéria⁴, nasceu artigo escrito a quatro mãos e publicado em 1883⁵, onde afirmam:

“Os histéricos sofrem principalmente de reminiscências”⁶

² Bertha Pappenheim que, embora, de fato, neurótica, seria diagnosticada na época como apresentando uma “psicose histérica”, foi tratada por Josef Breuer, durante os anos de 1880 a 1882, inicialmente com auxílio da hipnose. O relato completo de Breuer sobre o caso pode ser encontrado em BREUER, J. *Fräulein Anna O.*, in: STRACHEY, J. (Ed.). *The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud*. Londres: Hogarth, 1971, vol. 2.

³ Freud, S. *Cinco Estudos de Psicanálise* (1909). Os dois antigos colaboradores terminaram por afastar-se dado a desentendimentos relativos à importância da sexualidade na causalidade da neurose.

⁴ Bertha Pappenheim recuperou-se, vivendo longa vida (1859/1936) e encabeçando movimentos sociais, mormente feministas, sendo fundadora da Associação Feminina Judaica (*Jüdischer Frauenbund*).

⁵ BREUER, J. & FREUD, S. “O Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos” (*„Über den Psychischen Mechanismus Hysterischer Phänomene“*). Berlin: Neurologisches Zentralblatt, Janeiro, 1893, vol. 12 (1)).

⁶ Essa afirmação de Breuer e Freud e já aventada por outros autores de que “os histéricos sofrem principalmente de reminiscências” (“*der Hysterische leiden grösstenteils an Reminiszenzen*”) está enfaticamente explicitada no artigo que citamos na nota anterior, sendo tal afirmação posteriormente generalizada para a muito mais abrangente de que todos neuróticos sofrem de reminiscências.

Ou seja, de memórias, mas de um especial tipo de memórias. Para bem compreendê-las vale, antes de tudo, falarmos um pouco sobre as relações funcionais e disfuncionais entre percepção e memória.

Percepção e Memória

Para que nos comportemos de forma a concretizar satisfatoriamente nossas intenções, uma harmoniosa interação entre percepção e memória é essencial. Essa interação, contudo, é parte tão corriqueira de nossas vidas que mal nos damos conta de que ela existe. Se percebo que estou com sede,

(1) minha memória me diz que devo ingerir líquidos para satisfazê-la;

(2) olho em torno e percebo que estou em um quarto residencial;

(3) minha memória me diz que em quartos residenciais não costuma haver líquidos, mas que eles possuem portas que dão acesso a outros cômodos, onde tais líquidos costumam ser encontrados;

(4) percebo, então, que a porta do quarto está a minha esquerda e assim por diante. Aparentemente simples e banal.

Tão simples e banal que é necessário que essa interação harmônica se rompa de maneira tão espetacular quanto ocorreu no caso de Bertha para que avaliemos sua relevância. E quando se rompe essa relação?

As Memórias Hiperestésicas

Como logo veremos, essas disfunções são causadas por memórias disfuncionais – que Freud e Breuer batizaram de “hiperestésicas”⁷ – as quais, visto o excesso de emoção que são capazes de provocar quando estimuladas, em vez de trabalhar harmonicamente não só com as percepções, mas com todas as demais partes do psiquismo, competem entre si, interferindo negativamente em suas operações.

O que o caso de Bertha pela primeira vez trouxe à luz foi que, para esvaziar definitivamente essas memórias de tal disfuncionalidade, a estratégia capaz de fazê-lo é

**PERMITIR QUE O ENFERMO DÊ, DA MANEIRA MAIS
DETALHADA POSSÍVEL, PALAVRAS
A SUAS EMOÇÕES.**

Mas, para podermos avançar no combate à neurose, algo essencial deve ser considerado.

⁷ “*Hyperaesthetish Erinnerung*”, no original (BREUER, J. & FREUD, S. Id., ibid.).

Transtorno, Neurose e Psicose

Em pouco tempo ficou demonstrado que esse tipo de estratégia não era só capaz de curar sintomas histéricos, mas sintomas de todo e qualquer tipo de neurose.

Mas sabemos, de fato, o que é neurose? Bem, a depender do atual Código Internacional de Doenças, estamos cada vez mais distantes de sabê-lo.

A décima edição do Código Internacional de Doenças (CID-10), publicada, em 1992, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), fez o desfavor de esconder a diferença entre neurose e psicose sob o rótulo comum de “transtorno” – “neurose obsessivo-compulsiva” e “psicose maníaco-depressiva” viraram, respectivamente, “transtorno obsessivo-compulsivo” e “transtorno bipolar” – passando a desagradável impressão de que o catálogo mais importante de classificação das doenças está escondendo debaixo do tapete da palavra “transtorno” o fato de que, na verdade, seus doutos redatores não sabem a diferença entre neurose e psicose.

Vamos ajudá-los. Ora, se a experiência clínica mostra a sobejas que as memórias hipersensíveis se esvaziam de sua força excessiva quando o paciente dá, da maneira mais detalhada possível, palavras a suas emoções, nada mais cristalino e funcional do que brindar a neurose com a seguinte definição:

NEUROSE É O TIPO DE DISFUNÇÃO PSICOLÓGICA CUJOS SINTOMAS TÊM ORIGEM EM BLOQUEIOS REVERSÍVEIS DA FALA.

Mas resta um ponto a ser considerado.

Psicossanitarismo

A neurose é um fenômeno pandêmico⁸ e cumpre ouvir Moura Castro:

"Hoje não duvidam mais os epidemiólogos: a incidência de doenças e a expectativa de vida são pouco influenciadas pelos hospitais, seus médicos e por tudo que se passa lá dentro. Historicamente, a mortalidade e a morbidade caíram quando melhoraram a qualidade da água, o tratamento dos esgotos, a disponibilidade permanente dos alimentos, o controle das endemias e a higiene em geral. ... Em outras palavras, os fatores que decidem entre a vida e a morte acontecem predominantemente fora de hospitais e clínicas. ... A saúde requer mudança de estilo de vida. ... Mas há muito comportamento nocivo à saúde devido à mera falta de informação." (grifos meus)⁹

⁸ Quando uma doença existe em dimensões não alarmantes e apenas em uma determinada região, toma o nome de **endemia**; quando é transmitida para outras regiões, de **epidemia**; quando espalha-se pelos continentes ou por todo o planeta, de **pandemia**.

⁹ Castro, Cláudio de Moura. “Bisturi ou Microfone”, in: *Veja*, 10/01/2001, ano 34, n. 1, p. 21.

Pois bem, no que diz respeito à saúde física, a divulgação para o grande público das informações sanitárias relevantes tem sido feita de maneira razoavelmente eficaz. Cerca de duzentos anos atrás, nem sequer médicos tinham conhecimento da existência dos micróbios, a ponto de, desavisados da existência deles, fazerem a autópsia de um paciente e, logo em seguida, sem nem ao menos lavar as mãos, dedicarem-se a um parto, infectando suas pacientes com as bactérias e vírus que traziam do necrotério, levando-as frequentemente à morte.

Em contraste, qualquer cidadão comum de nossos dias pode avaliar a nocividade de tal comportamento, pois a medicina física soube divulgar razoavelmente suas descobertas e hoje, não apenas os médicos, mas a maioria dos habitantes de nosso planeta sabe que há micróbios e que eles transmitem doenças, executando, portanto, operações de assepsia – lavar as mãos antes de comer, filtrar a água que bebe etc. – que desempenham papel seminal na prevenção de um sem-número de enfermidades.

Não sofremos, contudo, apenas de enfermidades de origem física. Na verdade, profissionais e não profissionais de saúde começam, cada vez mais, a se dar conta da enorme quantidade de sofrimento produzido por doenças de natureza psicológica.

Simplificadamente, existem cinco grandes grupos de doenças mentais:

1. Retardos mentais;
2. Demências;
3. Psicoses;
4. Psicopatias;
5. Neuroses;

Os quatro primeiros grupos de enfermos perfazem, no máximo, cerca de 20% da população mundial – hoje em dia, cerca de 1 bilhão e meio de pessoas – os restantes 80% – cerca de 6 bilhões de pessoas! – padecendo de neuroses com variado grau de severidade (os chamados “normais” apresentam neuroses de gravidade considerada pouco relevante).

Ou seja – má notícia! – a neurose¹⁰ é uma pandemia e – boa notícia! – pode ser debelada por um vasto projeto psicossanitário que coordene a ação de organizações governamentais, não governamentais, profissionais de saúde e pela população em geral,. Mas, para que isso seja possível, cumpre, antes de tudo, que todos esses agentes estejam bem informados sobre as causas, a prevenção e o tratamento das neuroses.

O objetivo deste livro é contribuir para isso.

¹⁰ Os demais grupos requerem direta assistência profissional.

PRIMEIRA PARTE

O PESSOAL

Memórias hiperestésicas (I): no contexto clínico

Seguem-se uma série de vinhetas clínicas onde você poderá constatar a ação das memórias hiperestésicas, anteriormente ocultas de quem as abriga por estarem associadas a um excesso disfuncional de emoção.

A mão e a cabeça

Marcos, em sua primeira semana de análise, chamou-me atenção para um fato a que eu não havia atribuído maior importância:

– Você já notou – perguntou-me ele – que, quando me deito no divã, ponho as costas de minha mão sobre a cabeça? Ou melhor – continuou – eu não ponho minha mão sobre minha cabeça: ela vem para minha cabeça!¹¹ Eu, aliás, quando me dou conta que isso aconteceu, insisto em tirá-la, mas, basta eu relaxar e, pum!, lá está ela de novo! Que inferno!

De fato, eu havia percebido que meu paciente, ao se deitar, regularmente punha sua mão direita sobre a cabeça, mas não me passara a idéia de que se estivesse perturbando com isso. Marcos falou-me, também, sobre outro fato que o incomodava: tendo já perdido ambos os pais, podia, quando quisesse, re-evocar a figura paterna, mas não, a figura da mãe. Pensei o de sempre: conforme o paciente for vencendo seus bloqueios verbais e libertando sua fala, memórias anteriormente inacessíveis passarão a ser acessadas e ele conseguirá lembrar-se da imagem materna.

E assim foi. Com um detalhe. Quando recuperou a imagem de sua mãe, lembrou-se de ela fazendo algo a que freqüentemente se dedicava: socar-lhe a cabeça, o que, pode-se imaginar, lhe produzia intenso e repetido amargor! Também de que – eis a origem de nosso sintoma! – nessas ocasiões, ele se protegia das pancadas maternas com um gesto idêntico ao que era compelido a fazer, até então sem saber por quê, sempre que se deitava com a cabeça próxima a mim, no divã da análise! A partir dessa lembrança, Marcos voltou a mandar em sua mão.

Marcos não estava, durante as sessões, revivendo seu passado de forma alucinatória, como fizera Bertha, mas estava, assim como ela, apresentando sintomas gerados pelo transporte automático e acrítico, para o presente, de comportamentos defensivos que, no passado, haviam sido usados de forma seletiva e racional¹².

Outro exemplo:

¹¹ Desse tipo de fenômeno é que provém a distinção freudiana entre o “eu” – não sou eu quem põe” - e o “isso” – é algo, que não sou “eu”, que põe!

¹² Esse é um belo exemplo do que a Psicanálise freudiana chama de “transferência”.

Malária

Quando Nereida chegou a mim, sua via crucis por consultórios médicos, clínicas e hospitais já contava seis anos. Os sintomas se superpunham e se alternavam sem que os médicos lhes encontrassem suporte orgânico. A crescente suspeita de que teriam origem psicológica fez que ela viesse até mim. Após cerca de três meses de tratamento, a paciente trovejou:

– Você não está vendo que eu só faço piorar!?

Era fato. Naquele momento de sua análise, a paciente apresentava muito mais sintomas do que quando começara a tratar-se comigo. Desse ponto de vista, seu estado, de fato, se agravara. Tal agravamento, na verdade, era gritante. Sua dúvida quanto a se eu estava sendo capaz de perceber isso foi, ademais, tão enfática, que resolvi perguntar:

– Por que não estaria? Será que eu não conseguiria agüentar a possibilidade de ser incapaz de ajudar você?

O efeito foi mais do que surpreendente. A paciente ficou paralisada por alguns instantes e, por fim, retrucou:

– Ah, você agüenta!? Meu Deus, pois eu não agüentei! – e, chorando, fez-me o seguinte relato – Quando eu tinha nove anos, morávamos só eu e meu pai, em um barraco no interior de X (um estado de nosso Nordeste), distante de tudo. Minha priminha era minha melhor amiga. Tinha dois anos a menos do que eu. Ela pegou malária. Uma noite, no meio da maior escuridão, estando conosco, ela começou a ter um ataque e meu pai, assustado, foi em busca de ajuda, deixando-me sozinha com ela. Ela me segurava, dizendo: – “Não me deixa morrer! Não me deixa morrer!” Eu estava desesperada, sem saber o que fazer. Ela faleceu em meus braços e eu fiquei sozinha, apavorada, no meio da noite, com ela, já sem vida, abraçada a mim...

Após esse relato, sua via crucis por consultórios, clínicas e hospitais cessou de existir.

É óbvio que, ao colocar inúmeros médicos numa posição de impotência, Nereida não estava fazendo mais do que tentar passar para eles a sensação de impotência que havia experimentado em relação a sua desafortunada priminha. E aqui já temos um nítido exemplo de quão variadas podem ser as técnicas que estimulam a ampliação da fala: quando minha intervenção aventou a possibilidade de eu ser capaz de me sentir impotente, eu legitimei a fala da impotência, o que libertou a fala da paciente.

Eis outro caso em que esse processo de legitimação ocorreu de maneira ainda mais dramática:

'Tá com medo de mim?:

Mônica chega à sessão visivelmente alterada. Começa a pular no meio de minha sala de atendimento, a puxar os próprios cabelos e, subitamente, arremete contra a parede, batendo a cabeça contra ela. De aí em diante, foi um pandemônio: virou uma cadeira no chão; arremeteu de novo contra a parede e, em seguida, pegou um cinzeiro de cobre que estava na mesinha a meu lado, começando a tentar cortar o pulso com ele. Para mim era óbvio que, enquanto não se insinuasse a ocorrência de algo realmente perigoso, eu deveria ficar quieto, sem intervir. Nesse caso, como achei que ela estava atravessando um limite que poderia implicar perigo, intervim:

– Mônica, eu não tenho aqui emergência médica. Se você achar importante fazer o que está fazendo agora, vou ter que transferi-la de volta para a clínica de onde você veio.

Minha intervenção não teve nada de inocente. Ela tinha sido extremamente mal tratada nessa clínica (aplicaram-lhe várias vezes aparentemente desnecessários eletrochoques, foi estuprada de camisa de força por um enfermeiro, induziram-lhe coma insulínico, algo já inimaginável àquela época etc.). Não era difícil concluir que a última coisa que Mônica desejaria seria retornar para lá. Com efeito, lançando-me um olhar cheio de ódio, pousou brutalmente o cinzeiro sobre a mesa, parando de cortar-se.

Após mais alguns minutos de agitação intensa, a paciente veio até o divã e ajoelhou-se sobre ele, bem próxima a mim, dedo apontado em riste para meu nariz, bradando:

– 'Tá com medo de mim!? Tá com medo de mim!?

– POSSO?! bradei, com o tom indignado de quem reivindica direito muito seu.

A paciente parou como por encanto. Sua postura pareceu relaxar-se e ela respondeu, desconcertada, gaguejante mesmo, num tom mais baixo do que o empregado até então:

– Ué... Bem... Pode. Né?

– Obrigado – respondi, recuperando direitos que pareciam haver sido contestados – Já sei, então, que, se, por acaso, eu sentir medo de você, não preciso ficar constrangido: posso sentir medo à vontade.

A paciente murchou como por milagre. Quieta, dirigiu-se a sua poltrona, sentou-se e permaneceu quieta, em silêncio, durante os cinco ou dez minutos que

faltavam para o término, quando se levantou, despediu-se e, educadamente, partiu.

Essa sessão foi um divisor-de-águas no tratamento de Mônica. Ela tinha quatro sessões por semana, de segunda a quinta. A sessão em que ocorreu o episódio relatado foi a última da semana. Segunda-feira seguinte, não estava agitada. Entrou, sentou-se em sua poltrona e quieta, olhando para mim com olhar sério e indagador, nada disse por alguns minutos. Saiu de seu silêncio com a frase seguinte, dita lentamente e em tom refletido:

– Sabe de uma coisa? Eu sempre tive medo de você!

A partir daí, as comunicações de Mônica passaram a ter um grau de autenticidade que foi o móvel principal de sua surpreendente recuperação posterior.

Mais uma vez, a legitimação, pela minha fala, de uma fala interdita na paciente, operou a liberação dessa última, com seus conseqüentes efeitos terapêuticos.

O tipo de libertação da fala passível de ocorrer em contextos terapêuticos não é, entretanto, para ser enfrentada por qualquer um. Vejamos:

*Seu Filha da Puta!*¹³

Eu atendia Renato quatro vezes por semana, de segunda a quinta, e ele fazia uso do divã (meu tipo de técnica atual, que chamo de loganalítica, não mais faz uso desse tipo de recurso). Numa quinta-feira, deitou-se e, de costas para mim, para minha surpresa, começou sua sessão assim:

– Seu filha da puta! Eu não sei nem se você é mesmo psicólogo, ou se você põe esses diplomas aí na parede só pra poder ficar sacaneando as pessoas! Eu botei um patuá em cada porta da minha casa pra você não entrar – seu filha da puta! – mas você entrou assim mesmo! Pera aí! Não foi você que entrou em minha casa, fui eu mesmo que entrei! Ah, mas não dá pra ter essa raiva toda de mim não, vai você mesmo, seu filha da puta! E você está pensando que vai ficar assim? Não vai, não! Eu estou vendo você correndo, apavorado, pelo meio de um vale – seu filha da puta! – porque tem uma represa atrás de você e ela vai arrebentar, seu filha da puta! E você pensa que é uma represa de água? Não é não – seu filha da puta! – é uma represa de merda e a merda vai enterrar você, seu filha da puta!

Após descarregar fartamente sua raiva sobre mim, Renato partiu para seus pais.

¹³ É curiosa a frequência – provavelmente por razões de assonância – em que, nesse tipo de xingamento, emprega-se “filha” em vez de “filho”, mesmo quando o destinatário da ofensa pertence ao sexo masculino.

– ‘Tô no alto de um edifício e meu pai está nos meus braços, apavorado porque sabe que eu vou jogar ele lá embaixo! E eu não vou só soltar ele não! Ah, não vou, não! Eu vou empurrar ele com força, assim [faz o gesto], pra ele já sair com velocidade do topo do edifício e se esborrachar mais ainda quando chegar lá embaixo! Agora eu desci. Meu pai está esborrachado, cheio de sangue, mortinho. Aí eu pego uma machadinha e começo a picar ele todinho. Todinho! Ele fica bem picadinho. Sabe como? Que nem “stake tartar”, conhece? Pois é, assim mesmo! Bem, bem, bem picadinho. Acabei! Mas não estou satisfeito, não! Ah, já sei! Cago em cima! Isso, cago em cima! Vou cobrindo ele de bosta! Mas minha bosta não dá pra cobrir! Não tem problema! Eu volto no dia seguinte e no outro e no outro, até ele ficar totalmente coberto de bosta! Ficou! Caramba! Sobrou um dedinho, inteiro, fora da bosta! Aí, eu pego o dedinho e – crack! – quebro o dedinho do filho da puta!

Depois do pai, dedicou um tempo a sua mãe.

– Pego a filha da puta pelos pés – estou no meio de uma praça redonda, cercada de postes – e rodo a filha da puta de forma que a cabeça dela vai batendo, com toda força, em cada um dos postes. Rodo muitas vezes, o pescoço dela quebra e a cabeça fica cheia de sangue! Bom! Muito bom! Entendeu bem, seu filho da puta?

Voltou-se ainda, durante alguns minutos para mim, dizendo, em sua linguagem de médico, que iria enfiar seus dedos em meu abdômen e, com suas próprias mãos, levantar meu gradil costal, enfiar a cabeça em minhas vísceras e chupar o meu sangue, experimentando o prazer de senti-lo morno, molhando suas bochechas.

Fiquei escutando, sem nada dizer, durante toda a sessão. E, convenhamos, nada havia a dizer que não fosse atrapalhar tal descarrego! Terminado nosso tempo, apenas comentei:

– Estamos na hora!

Levantou-se um pouco constrangido. Afinal, não é todo o dia que se faz picadinho do pai, se racha a cabeça da mãe, e se chupa o sangue morno do próprio analista! Fomos até a porta, onde nos despedimos com um educado aperto de mão, enquanto ele dizia:

– Olha, na segunda-feira, não vou poder vir, porque estarei de plantão no hospital (era formando de medicina).

– Combinado – respondi.!

Terça-feira, voltou. Deitou-se no divã e suas primeiras palavras foram, para meu renovado espanto:

– *Seu filha da puta!*

E continuou por aí afora. Foram mais quatro sessões seguidas da maior descarga verbal de ódio que jamais presenciei durante todas minhas cinco décadas de atividade como psicoterapeuta. Na primeira sessão da semana seguinte, parecia aliviado. Deitou-se no divã e suas primeiras palavras foram:

– *Porra, foi foda, né? E, cara, enquanto eu falava aquelas coisas todas, uma vozinha dentro da minha cabeça ficava repetindo, o tempo todo: “Levanta e enche esse filho da puta de porrada!” E vou lhe contar uma coisa: se isso tivesse acontecido há uns dois anos atrás, eu tinha levantado e lhe enchido de porrada!*

O que, aqui entre nós, pelo seu tamanho, treinamento (caratê e capoeira¹⁴) e força, poderia ter perfeitamente feito. Anos depois do término de sua terapia, que durou 5 anos, Renato tornou-se um clínico geral bem sucedido nos EUA.

Como se vê, dar espaço para situações de “psicossangria”, implicam razoáveis riscos; Com efeito, polícia nas ruas e segurança nos bailes é um *must* em festivais...Se eu já não estivesse suficientemente seguro – e um erro de cálculo, aqui, traria desagradáveis conseqüências – de que Renato não iria ultrapassar a fronteira que existe entre a palavra e a ação, eu teria intervindo de forma a abortar seu processo de catarse. Meu contínuo silêncio foi como que um aval para que ele fosse em frente na descarga de seus desejos de destruir. Fiz isso por estar acreditando que ele iria restringir-se à dimensão da fala. Felizmente, estava certo: caso não, poderia ter tido uns ossos quebrados.

A não interdição da fala do paciente, entretanto, não depende apenas do simples silêncio do terapeuta. Minha primeira sessão com Mônica deixa isso às claras:

Doutor, o senhor vai me matar?:

Mônica, paciente a que há pouco me referi, tinha cerca de 40 anos, quando chegou a meu consultório, tendo já sido submetida aos mais diversos tipos de tratamento, desde os 17. Primeiro, à Psicanálise em seus moldes clássicos, depois a medicações psiquiátricas, a várias internações e, inclusive, como há pouco me referi, a eletrochoques e, para meu absoluto espanto, até ao coma insulínico, tratamento absolutamente arcaico e em total desuso. Embora três décadas mais nova do que a mãe, que a acompanhava em sua primeira consulta, a paciente tinha um visual mais alquebrado do que o dela. De cabelos já grisalhos, sua postura, curvada, parecia indicar que tinha sobre os ombros o peso do mundo. Acomodaram-se a mãe, em uma poltrona, e Mônica, a seu lado, no

¹⁴ Que, após aquelas cinco inesquecíveis sessões, parou de treinar, com o cândido comentário: “Engraçado, parei de ter vontade de treinar tanto o caratê quanto a capoeira”. Pareceu-me ter estado, até então, se preparando para um possível desenlace mortal entre nós. Certo ou errado, preferi não comentar esse seu comentário.

divã. Enquanto, de costas para ambas, eu ajeitava a poltrona em frente para me sentar, ouvi, chegando por trás de mim, a voz cansada de minha futura paciente, que perguntava:

– Doutor, o senhor vai me matar?

Virei-me para ela e ouvi, para meu próprio espanto, a seguinte frase sair de minha boca:

– Não sei, filha. Quem sabe? Podemos conversar...

Minha frase teve um efeito mágico. O semblante de Mônica desanuviou-se, a postura endireitou-se e respirou fundo, indicando alívio, e pareceu pela primeira vez olhar em torno, dando-se real conta do ambiente em que se achava. Por incrível que a alguns pareça, eu ter aberto a possibilidade de falarmos sobre que talvez eu a matasse libertou-a. Na verdade, em todos seus tratamentos anteriores, Mônica tinha tentado fazer-se escutar relativamente a suas idéias de que queriam matá-la. Quase a mataram para convencê-la de que ninguém pretendia fazê-lo...

O fato de eu ter reagido de forma receptiva a sua pergunta, abrindo espaço para que falássemos sobre o assunto, insuflou-lhe ânimo e formou entre mim e ela um vínculo cuja solidez foi uma das fortes razões para o posterior sucesso de nossa relação.

Como se vê, uma frase que abre espaço para que todas as palavras e pensamentos sejam externados, sem privilegiar nenhum deles, pode ter um terapêutico poder libertador. Aliás, esta é boa oportunidade para mostrarmos as profundas associações entre as sensações de alívio, de liberdade e a respiração.

Oxigênio

Mônica entrou na sessão aos berros:

– Não adianta! Enquanto essa minha maldita família quiser me matar – e é isso que eles querem! – não há análise capaz de me fazer ficar boa!

E à sua invectiva seguiu-se um dos mais intensos ataques de angústia jamais por mim presenciados: taquicardia, sudorese, ânsia de respirar, faces exangues, lábios roxos etc. Fiz o que devia ser feito: não intervim.

Vinte minutos depois, tendo sido capaz de veicular com toda a intensidade sua indignação, Mônica recuperou-se: o batimento cardíaco normalizou-se, a cor voltou a seus lábios e a sua face, e ela acomodou-se, relaxada, no fundo da poltrona, respirando lenta, pausada e profundamente.

– Melhorou? – perguntei.

Acenou com a cabeça que sim.

- E sua família, mudou muito? – provoqueei.*
- Não deve ter mudado nada, seu f. d. p.! – esbravejou, saindo de seu torpor.*
- Mas sua respiração, em compensação, melhorou bastante... – insisti.*

Acenou, mais uma vez, afirmativamente, mostrando-se ainda visivelmente cansada.

- Sabe o que eu vendo aqui, Mônica? – perguntei, brincando.*
- Não.*
- Oxigênio... – respondi.*

Brincando? Nem tanto. Para o ser humano, liberdade de respiração tem estreito vínculo com liberdade de expressão verbal, pois bloqueios da fala acabam por cristalizar-se em significativos e estáveis distúrbios respiratórios, com todas suas íntimas relações com as sensações de angústia, de ansiedade, de estresse. Já a liberdade da fala – algo que deve ser feito com os cuidados que mais adiante iremos assinalar – implica liberdade de respiração, que, por sua vez, tem íntimas relações com as sensações de alívio, paz, calma, serenidade, leveza etc., as chamadas *eutimias*¹⁵.

Implica também o enriquecimento de nossa vida mental. Já perceberam como “ventilamos” um assunto, “aventamos” uma possibilidade, como dizemos terem mentes “arejadas” pessoas com liberdade de pensamento e como consideramos “inspiradas” as mentes que produzem ideias extraordinárias? E será que quando “in-ventamos” alguma coisa é porque deixamos um pouco mais de “vento” oxigenar nossas cabeças?

Mas voltemos à questão da serenidade e da paz interior. Nenhuma experiência, dentro ou fora de contexto clínico, deixou-me mais convencido da força apaziguadora da ampliação da fala do que a que vivi em minha relação com Alfredo

AIDS

Após o falecimento de Alfredo, ex-paciente meu, vitimado pela AIDS, encontrei sua irmã, Marta, de quem ouvi o seguinte relato:

- Caro doutor, o Alfredo, morrendo, ensinou a todos que o cercavam como viver. Foi simplesmente assombrosa a serenidade com que enfrentou sua dor. Serenidade maior do que a de qualquer um de nós que o assistíamos. Um episódio, particularmente, me impressionou. Um amigo foi visitá-lo em sua casa. Eu estava presente. O amigo estava visivelmente inquieto: levantava-se e sentava, mal completava suas próprias palavras, interrompendo também, por*

¹⁵ *Distimias*, por sua vez, abrangem essencialmente ansiedade (angústia, estresse), depressão e irritabilidade.

vezes, meu próprio irmão. Certa hora, Alfredo, sereno, colocou a mão no antebraço desse amigo, interpelando-o: – “Rubens, afinal, quem está para morrer, você ou eu?” E, frente ao silêncio atônito do amigo, continuou: – Nós dois sabemos que me resta pouco tempo de vida. Eu gostaria de aproveitar parte desse tempo conversando com amigos como você, mas sua ansiedade não está me deixando fazer isso. Gostaria que você se acalmasse um pouco. Só assim vou poder aproveitar o que, possivelmente, será nossa última conversa.

– Alguma coisa na voz e nas maneiras de meu irmão – continuou Marta – apaziguou Rubens e, de fato, pela última vez, usufruíram do prazer de conversar. Alfredo manteve-se o tempo todo assim: sofrendo serenamente sua dor e sendo, ao mesmo tempo, capaz de equilibrar a todos nós. Nunca mais vou me esquecer disso!

Quando Alfredo me procurou para atendimento analítico, já era portador do HIV, embora a doença ainda não se houvesse manifestado. Trabalhávamos, naturalmente, com a esperança de que, nele, o vírus não chegasse a produzir a doença ou de que algum novo tratamento fosse descoberto a tempo de impedir que a enfermidade o vitimasse. O ânimo de Alfredo para enfrentar os inevitáveis limites com que sua soropositividade o defrontava era, na verdade, superior. Mas, é claro, o fantasma da doença, por vezes, o acossava. Certa feita, desabafou:

– Sabe de uma coisa? Embora minha disposição para encarar o fantasma dessa maldita doença seja firme e, como já conversamos, eu mantenha em geral a esperança de que ela não vá se manifestar nunca ou de que o avanço da medicina ainda me livre dela, a idéia de que nada disso vai acontecer passa, por vezes, rapidinho, pela minha mente.

– Por que não a deixamos passar devagarzinho? - retruquei.

– Como!? Retrucou ele.

– Alfredo, essa idéia de que você vai morrer é capaz de fazer mais mal nos porões de sua mente do que se posta à luz. Vamos fazer isso. Proponho que você a examine, escrutine, faça que ela exponha todos os seus ângulos e facetas, deguste seu sabor amargo sob todas as formas que ela souber encontrar. Faça aquela “dolorosa dilatação da alma” de que fala Hesse¹⁶ e sobre a qual já falamos e, agindo assim, esvazie a força excessiva dessa idéia, para encontrar a paz. Estamos trabalhando com a esperança de que o HIV nunca se manifeste ou de que alguma nova droga apareça. Devemos continuar fazendo isso, mas, até para fazê-lo bem, é bom “cauterizarmos” toda idéia e pensamento que se opõe a essas esperanças. E a única forma de fazer isso é dar plena consciência a tais idéias e pensamentos, verbalizando-os. Lembra-se do Ariano

¹⁶ Referindo-se ao destino do ser humano, a quem chama de Lobo da Estepe, fala o autor: “pobre Lobo da Estepe ... tens de percorrer o caminho mais longo, mais penoso e mais difícil da humana encarnação; freqüentemente, terás de multiplicar a tua multiplicidade, complicar ainda mais a tua complexidade. Em vez de reduzir teu mundo ... terás de recolher cada vez mais mundo, de recolher, no futuro, o mundo inteiro, em tua alma dolorosamente dilatada, pra chegar, talvez, algum dia, ao fim, ao descanso.” (HESSE, H. O Lobo da Estepe. Rio: Record, sem data, p. 69. Grifo meu.).

Suassuna, que se descreve como um “realista esperançoso”? Pois bem: se somos realistas o suficiente para manter nossa esperança, malgrado tendo sempre em vista que ela talvez não se concretize, devemos também levar em conta que morte é um assunto muito doloroso para que nos ocupemos dela estando doentes. Deixe vir a sua mente mil vezes o pensamento de morrer agora, enquanto você, embora soropositivo, está bem vivo e são. Caso o que não esperamos nem desejamos ocorra e você piore, as penosas realidades dessa doença não vão estar multiplicadas por seu desespero.

E foi o que ele fez, acompanhado por minha respeitosa escuta. Enquanto o fazia, voltaram-lhe à mente penosíssimas lembranças do seu companheiro homossexuals cuja dolorosa viagem para a morte, também por AIDS, Alfredo presenciara e de que havia tentado anteriormente não lembrar. Degustou corajosamente todas. Quando, afinal, meu paciente me apareceu com o primeiro exame que de fato indicava significativa o início da doença, seu comentário foi a maior prova de que a serenidade é fruto assegurado da dilatação da alma.

– Cara, isso é muito, muito estranho... Estou recebendo, pela primeira vez, um exame que realmente mostra que estou pior. O resultado está muito ruim e eu estou muito triste! Mas, engraçado, eu ficava muito mais ansioso, muito mais desorganizado, antes, ao receber resultados incomparavelmente melhores do que estes. Parece que “não tem mais gás” (sic) pra sentir todo aquele desespero que tomava conta de mim...

No encontro de Alfredo com seu amigo, esse último, embora não fosse vítima da doença, estava totalmente dominado pelas angústias nele despertadas pelo espectro da morte, angústias que por completo o desorganizavam; meu paciente, ao contrário, mesmo antes de ser de fato vitimado pelo vírus, havia, sob análise, descarregado tão intensamente as suas, que, embora tendo sofrido com cada restrição e cada dor que a aquisição do vírus lhe trouxera, nunca, segundo sua irmã, se deixou levar pelo desespero. A serenidade com que, até o último momento, enfrentou a doença e a morte, foi o ganho – de valor inestimável – que, frente a circunstâncias tão adversas, nosso trabalho lhe pôde trazer!.

Sobrevive a crença popular de que, se pomos em palavra um pensamento, aumentamos o risco de que ele se torne real. Há grande mal-entendido em torno disso. Existe, tudo indica, a “força do pensamento”, uma capacidade desse último de se fazer real. Os achados da Parapsicologia parecem sustentar isso mesmo no que diz respeito ao mundo interno; no que diz respeito a alterações produzidas especificamente em nós mesmos, a hipnose, por exemplo, já cansou de demonstrá-lo.

Para que tal força do pensamento opere, entretanto – e, ainda assim, com vastas restrições – ela, esteja ou não esse “pensamento” expresso em palavras, depende do preenchimento de, pelo menos, a segunda destas duas seguintes condições: a primeira é a de que você deseje fortemente que esse pensamento se concretize; a

segunda, de que você acredite intensamente que tal concretização irá ocorrer. Obviamente, quando propus a Alfredo que deixasse vir à luz seus pensamentos de morte, não sugeri que os desejasse concretizados nem tampouco que acreditasse neles. A experiência clínica, aliás, demonstra que simplesmente “deixar vir” um pensamento – sem desejá-lo ou crer vivamente em sua ocorrência – é, bem ao contrário, uma das melhores garantias contra sua concretização. Marcos – o da mão amotinada – quando chegou para tratamento, já havia sofrido quatro graves acidentes ao dirigir. Em um deles, enfiou-se sob a carroceria de um caminhão, sendo gravemente atingido – adivinhem onde! – na cabeça. A partir do momento em que a Loganálise liberou seus pensamentos relativos a acidentes – incluídos, é claro, os relativos às “colisões” com a mão de sua mãe – tais acidentes deixaram, por completo, de ocorrer. E tenho mais de quinze anos de *follow-up*¹⁷!

Mas, com os exemplos que lhes ofereci até agora, posso ter-lhes passado a enganosa impressão de que as memórias hiperestésicas são sempre memórias de conteúdo desprazeroso. Não é assim. Basta, para que uma memória de uma experiência se torne nocivamente hiperestésica, que essa experiência, não obstante prazerosa, tenha ocorrido em circunstâncias que interditaram seu caminho para palavra.

Silêncio

Leonora, entre outros sintomas que a levaram a procurar análise, queixava-se de extrema dificuldade de sair à rua. Lentamente, o processo terapêutico foi revelando que seu medo não era, exatamente, o de sair à rua. Era mais específico: era o de, ao fazê-lo, despertar olhares de desejo nos homens. A exploração dessa fobia nos levou a perceber que, em nível ainda mais profundo, o medo era o de entrar em contato com o prazer que tais olhares lhe provocavam. Um pouco mais de análise foi suficiente para revelar que a fobia de admitir tal prazer tinha raízes em memórias hiperestésicas de alto impacto.

Minha paciente, dos 9 aos 15 anos, mantivera brincadeiras sexuais, não obstante sem penetração completa, com o pai. Não apenas isso: ela tivera orgasmo em algumas dessas brincadeiras. Na verdade, em um ambiente familiar emocionalmente seco, em que ninguém se beijava, abraçava ou sequer tocava, era o único momento em que experimentava a sensação de prazer físico com alguém. E, evidentemente, isso não era algo que pudesse comunicar verbalmente a seu entorno.

Mas o que nos importa particularmente aqui é o fato de que, a partir do momento em que pôde falar sobre isso em análise, sua fobia de sair à rua desapareceu, evidenciando – como fica evidenciado em inúmeros outros casos de mesma natureza – que não é a natureza do evento, mas o bloqueio de sua verbalização – a sensação de que não temos o direito de comunicá-lo – que produz memórias excessivamente capazes de produzir emoção e a série de sintomas psiconeuróticos que as acompanham.

¹⁷ Quinze anos de acompanhamento posterior do caso.

Em trinta em cinco anos de prática clínica, defrontei-me mais de uma vez com casos de mulheres cujos sintomas deviam-se ao fato de saberem que seu ambiente não aceitaria que comunicassem abertamente as emoções – incluída, entre as mais proibidas, as de prazer – que haviam experimentado em relações de natureza incestuosa. Sintomas que desapareceram, quando sua comunicação foi devidamente legitimada durante o processo de análise.

Deixadas à parte as restrições morais que pairam sobre o incesto, o fato clínico inegável é o de que, se as emoções – indiscutivelmente intensas e consoantemente passíveis de gerar memórias hiperestésicas – por ele provocadas puderem ser verbalmente expressas, pode haver desilusão, vergonha, culpa etc, mas, certamente, não haverá produção de sintomas psiconeuróticos associados àquelas memórias. E a prática clínica nos demonstra que o que acabei de ilustrar por meio do incesto pode ser generalizado para qualquer outro tipo de experiência humana.

O processo de esvaziar uma memória hiperestésica do excesso de emoção a que está associada pode levar seu portador a livrar-se de sintomas bem diversos daqueles que o fez buscar tratamento.

Conformismo:

A mãe de meu paciente Sidônio, relacionava-se com ele por meio de um comportamento que nós psicoterapeutas costumamos classificar como “superproteção ansiosa”. Lidava com seu filho como se ele fosse extremamente frágil e a consequência disso era a de que o menino, em seu dia-a-dia, tinha que defrontar-se com um número de proibições muito maior do que seus coleguinhas de mesma idade. Desde que começou a tomar consciência disso até por volta de quatorze anos de idade, Sidônio irritava-se profundamente contra o desproporcional controle da mãe, protestando verbalmente contra isso. Tanto ela quanto seu pai, entretanto, faziam ouvidos moucos a seus protestos e, a partir de quatorze anos, o comportamento de Sidônio sofreu uma súbita transformação: parou de irritar-se com o comportamento da mãe, tornou-se dócil e cordato ...e desenvolveu uma intensa rinite alérgica. Obviamente, os pequenos e seguidos “nãos” de sua mãe haviam, a essa altura, produzido memórias hiperestésicas que começaram a produzir sintomas.

Nada disso era de meu conhecimento quando Sidônio, aos 25 anos, chegou a mim, com a queixa de que, a despeito de sua indiscutível inteligência, não conseguia completar seus estudos universitários, estando à beira de ser jubilado. Sua rinite, entretanto, embora não se queixasse dela, era óbvia: chegava a borrifar suas narinas até meia dúzia de vezes durante uma sessão de quarenta e cinco minutos.

É curioso saber como cheguei a reconstruir o processo de formação dos sintomas que acabei de relatar. Logo durante as primeiras sessões foi-se tornando claro como meu paciente evitava qualquer situação em que sequer fantasiasse que poderia receber um não. Lembro de meu próprio espanto frente a seu relato de que, em restaurantes, evitava pedir aos garçons que embalassem para viagem o que sobrava de sua refeição porque temia que eles se recusassem a fazê-lo. Ao investigarmos por que uma tão improvável ocorrência devia ser tão cuidadosamente evitada, tornou-se claro que o que era temido não era a eventual negativa a ser enfrentada, mas, sim, a enorme quantidade de ódio que uma tal negativa, caso ocorresse, iria provocar em meu paciente.

A partir daí, foi vindo à tona toda a história dos pequenos mas repetidos “nãos” de sua mãe, da inicial revolta de Sidônio e seu posterior conformismo. A relação desse processo com sua alergia tornou-se patente quando, à medida que o conformismo de Sidônio foi regredindo e sua capacidade de expressar descontentamento frente a “nãos” reais e imaginários foi sendo recuperada, sua rinite simplesmente desapareceu, revelando que a irritabilidade psicológica que havia reprimido aos quatorze anos tinha sido, desde aquela época, deslocada para seu nariz!

Ah, em tempo: o paciente também normalizou seu desempenho acadêmico e obteve seu diploma universitário. Na verdade, quando fazia provas, sempre tirara notas altas. O problema era o de que, quando achava que iria tirar uma nota baixa – que associava com um “não” – simplesmente faltava à prova, com as óbvias consequências disso... Com a análise, parou de comportar-se dessa forma e obteve sua graduação.

No episódio que relato a seguir, o contexto era clínico, mas foi meu diálogo com um paciente de outro terapeuta que, aparentemente, evitou uma catástrofe.

Suicídio

Em uma época de insegurança aumentada no bairro em que se encontrava minha clínica, contratei Jaime, um segurança. O rapaz havia sido segurança de boates e, certamente, algumas mudanças – sobre as quais, inadvertidamente, não o instruí – deveriam ser operadas em seu comportamento para que se adaptasse a seu diferente contexto profissional.

Certo dia, Jaime, já em seu novo trabalho, começa a escutar, vindo de uma sala situada no andar térreo da clínica, um paciente afirmando aos berros para sua terapeuta, frágil moçoila, que iria matá-la.. Jaime se desespera. Algo lhe diz que não deveria, simplesmente, arrombar a porta do consultório a pontapés e, à maneira do que fazia nas boates, dominar fisicamente o potencial agressor, salvando a donzela. Mas algo lhe diz também – no que, por culpa minha, enganou-se – que não poderia deixar de fazer algo. Por detrás da sala, cuja janela costumava ficar aberta, encontrava-se um pátio. Ele tem uma ideia.

Passaria, como quem nada quer, por esse pátio, olhando para dentro da sala, de forma que Álvaro, o paciente, pudesse dar-se conta de que outros tinham conhecimento do que se estava passando ali. Faz isso. Pior a emenda do que o soneto. Ao ver passar Jaime, Álvaro, com raiva paroxística, explode:

– O quê? Então, nem privacidade se pode ter nesta maldita clínica! Vou denunciar vocês todos ao CRP¹⁸!

E, batendo ferozmente a porta, sai da sala em que se encontrava, deixando a clínica. Enquanto tal ocorria, estava eu, insciente de tudo, atendendo em minha sala. Psicóloga e segurança, logo após o ocorrido, procuraram-me, esbaforidos, preocupados, o segurança com ser despedido, a terapeuta com ser denunciada ao CRP.

Comentei, frente a ambos:

– Interessante, só estou vendo duas pessoas preocupadas com a própria pele; não estou vendo aqui ninguém preocupado com o que pode estar acontecendo com um paciente que saiu daqui enlouquecido pelas ruas desta não menos enlouquecida cidade!!!

A psicóloga, depois do ocorrido, tentou debalde contatar o paciente e acabou indo à Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP, para relatar o ocorrido, expondo suas apreensões. Tendo declinado o nome do paciente, ouviu como resposta o seguinte comentário:

– Ah, o Álvaro! Bem, podemos investigar um pouco mais. Mas, pelo que sabemos, não deve haver causa de maior cuidado. Faz algum tempo que ele, cada ano, denuncia uns dois ou três psicólogos a este Conselho! E, depois, desaparece. De qualquer forma, nunca conseguimos encontrar maior substância em suas acusações.

Ao saber disso, à parte divertido, fiquei também aliviado. Aparentemente, nada de maior gravidade havia acontecido com o paciente. Passada uma semana, Álvaro, após algumas tentativas, consegue alcançar-me por telefone, comunicando, com voz tensa e grave:

– Estou-lhe telefonando para dizer o que fizeram comigo em sua clínica e para avisá-lo de que vou denunciar seu estabelecimento ao CRP!

– Estou ciente, Álvaro, desses acontecimentos. Você está procedendo de forma correta, recorrendo ao Conselho. Mas, fora isso – e essa minha intervenção mostra tudo o que deveriam ter feito com ele e não fizeram – como você está se sentindo frente a tudo que lhe fizeram passar aqui?

¹⁸ Conselho Regional de Psicologia.

Álvaro, de imediato, rompeu em convulsivas lágrimas. Sua voz, barrada por sacudido pranto, conseguiu ainda articular:

– Doutor, eu nem sei se vou fazer nada do que lhe falei. Eu estou aqui com um revólver em cima de minha mesa e, quando desligar, não sei se dou ou não um tiro em minha cabeça!

– Álvaro, vou lhe dizer uma coisa que, provavelmente, irá chocá-lo – repliquei.

– O quê?

– Acho que isso de você dar ou não um tiro em sua cabeça não tem grande importância.

– Não?!

– Não. O que tem importância é você estar em dúvida. Não me parece que dar um tiro na cabeça seja algo que se faça quando se está em dúvida.

O tom de Álvaro mudou. Parece que se havia recomposto.

– Tem razão, doutor. Não vou dar um tiro na minha cabeça!

Como veem, eu não disse a Álvaro o que ele deveria fazer ou não: sugeri, apenas, que há certas coisas que não se fazem quando não estamos “em nós”. Não discuti o conteúdo de sua decisão; pus em dúvida se estava em condições de tomá-la. Ele reconheceu que não estava. Nada disso teria acontecido se, em vez de perguntar sobre o quanto ele ficara machucado, eu tivesse ficado preocupado com a imagem de minha clínica frente ao Conselho e me metido a justificar o comportamento de meu segurança e da psicóloga que o atendeu.

Memórias hiperestésicas (II): fora do contexto clínico

Aproveitemos minha anterior referência às memórias hiperestésicas de conteúdo prazeroso para relatar um episódio que, embora me tenha sido relatado em contexto clínico, ocorreu fora dele e que tem o mérito de expor o fato de que há situações em que o sintoma produzido por tais memórias pode ser de pouca gravidade e transitório.

Piano

Maria havia-se deslocado para fora do estado em que morava, para prestar um concurso. Após haver terminado algumas provas, sai a passeio e acaba adentrando os limites de uma faculdade de estudos ecológicos, toda construída, dentro de área densamente arborizada, a partir de considerações de respeito à harmonia da integração homem-natureza. Já o acesso ao local é impactante: uma estreita ponte, construída por lâminas de madeira, unidas por cordas, atravessada sobre as águas cristalinas de um riacho ágil. O caminho é tortuoso. O travesso rio avança mata adentro. O ar é puríssimo e fresco. Ouve-se o cantar de pássaros e não os sons invasivos que roubam a quietude das

grandes metrópoles. As construções são de madeira e algumas, pequenas salas de aula no topo de árvores. A estética do ambiente, por si só, é uma mensagem de paz... É um fim de tarde de abril. Os raios de sol atravessam, oblíquos, entre as árvores, cujos ramos balouçam ludicamente ao sabor da brisa outonal. Pouco antes de outra pequena ponte, semelhante à primeira, Maria começa a ouvir os acordes de uma sonata. Atravessada a nova ponte, abre-se uma clareira e, ao fundo, uma grande rocha, de forma côncava, como que esculpida a mão, debruça-se sobre um pequeno lago, formado pela nascente do riacho, onde flertam dois cisnes. Junto ao lago, sobre um gramado de verde claro e intenso, frente a um piano de cauda branco, em fraque igualmente branco, um esbelto jovem, de cabelos revoltos, toca Brahms... Transcrevo, em seguida, as palavras da própria paciente, a quem pedi que me descrevesse o episódio por escrito (De passagem, a inusitada cena era parte da gravação de um programa para uma estação de TV suíça):

"Havia muito não sentia tanta paz, não respirava ar tão puro, não ouvia sons tão encantadores, não sentia o perfume da mata fria, não via cenário tão esplendoroso... Meu coração doía de emoção e quase explodiu de dor, quando percebi que não havia ninguém para quem eu pudesse dizer: 'Veja que maravilha!!! Que coisa linda!!! Sinto-me privilegiada por ver algo tão belo!!!' Enfim, ninguém com quem dividir meus sentimentos. Sensações de contentamento pelo momento de rara beleza que eu desfrutava e de dor por não ter ninguém com quem as compartilhar mesclavam-se desordenadamente em mim. E essas emoções contraditórias eram tão intensas que, mais tarde, de novo no hotel, sentia-me sem forças e com um imenso buraco varando meu peito."

Sendo uma pessoa fechada e estando em um ambiente sem conhecidos, Maria não dividiu sua experiência com ninguém e, naquela noite, não dormiu. Mas o bloqueio de sua fala era meramente circunstancial e sua incômoda inquietude logo desapareceu.

Passo a relatar quatro episódios em que um dos protagonistas sou eu, em minha vida real, fora de contexto formalmente terapêutico. Em ambos a memória hiperestésica foi adquirida de um só golpe, não de maneira continuada como vimos ter ocorrido no caso de Marcos¹⁹ e de sua mãe, que teimava em se lhe grudar à cabeça.

Piscina:

Eu estava, certa vez, na fazenda de um amigo, tomando uma caipirinha, em pé, ao lado da piscina, conversando com alguns amigos. Chegaram novos convidados. Vieram até onde estávamos. Quando me apresentaram a Vítor, estranhamente, pensei: "Ele vai querer me jogar na piscina!" Tal comportamento, nas circunstâncias em que nos encontrávamos, seria mais do que improvável, seria absurdo. Achei engraçado e deixei meus pensamentos

¹⁹ Pág. 32.

fluírem, imaginando como reagiria se acontecesse o que, evidentemente, não iria acontecer.

Mais tarde, na varanda da fazenda, Vítor dirigiu-se a mim, dizendo que tinha a impressão de que nos conhecíamos. Nessa hora, tive a mesma impressão. Subitamente, Vítor exclamou:

– Agora me lembro! Há mais ou menos quinze anos, fomos adversários em uma competição de judô, no Clube Português!

O reparo de Vítor reativou minha memória: com efeito, a única vez em que eu estivera anteriormente com ele fora sobre um tatame, um querendo jogar o outro no chão. Minha sensação de que ele iria querer me jogar na piscina fora uma transferência, para as circunstâncias em que o reví, de uma “lembrança não lembrada”, que permanecera hiperestésica, daquela ocasião!

Outro episódio:

Carícia

Ninguém podia tocar a parte frontal da coxa direita de Isadora. Ninguém. Nem seus filhos, nem mesmo seu marido, ainda que durante uma relação sexual. A sensação de incômodo que um toque desses provocava era, segundo ela, insuportável.

Uma vez separada de seu marido, por quem nunca fora apaixonada, Isadora apaixonou-se por mim e eu por ela. Belo dia, estávamos em meu carro, parados, apreciando a paisagem quando ela irrompeu, excitada::

– Descobri! Descobri! – repetia.
 – Descobriu o quê, Isadora? – perguntei.
 – Descobri porque ninguém podia tocar na minha coxa!
 – E por quê?
 – De repente, dei-me conta de que você está, há um tempão, fazendo festa na minha coxa direita! E eu nem havia notado! Aí me lembrei!
 – Lembrou de quê, Isadora?
 – Quando eu tinha quatorze anos, fui completamente apaixonada por um cara! A gente queria casar e viver pra sempre junto um do outro! Mas nossas famílias se odiavam. Sabe? Que nem Romeu e Julieta! Ele era novo que nem eu e não pôde fazer nada quando a família resolveu mandar ele pro Norte, pra separá-lo de mim! Na última vez em que ficamos juntos, ele já sabia que ia embora e ficou todo o tempo, enquanto chorava e conversava comigo, fazendo festa na minha coxa direita! Ele foi embora e eu fiquei aqui, sofrendo, sofrendo, com aquela última lembrança de nossa história de amor... Um ano depois, passou tudo. Eu fiquei seca. Encontrei meu marido e casei. Mas ninguém mais pôde por a mão na minha coxa! Agora pode, agora pode outra vez!

Aquela não era uma coxa, era um altar; o altar de uma estória de amor e só alguém muito amado poderia fazer uso dele outra vez. Mais uma vez, a libertação de uma memória oculta decretava a morte de um sintoma. Como veem essas “curas” aparentemente milagrosas não só ocorrem dentro das quatro paredes de um consultório...

Outro exemplo:

Abandono:

Adelaide não conseguia chegar ao orgasmo durante suas relações sexuais comigo, tendo-me afirmado que tampouco conseguira com seu namorado anterior, de quem fora noiva e com quem, alegadamente, tivera sua primeira relação sexual. Minha postura de oferecer ampla escuta às comunicações de Adelaide deixava-a particularmente relaxada. Disse-me ter a impressão de que não haveria coisa neste mundo que ela pudesse me dizer e que fosse capaz de me escandalizar. Foi certamente isso que facilitou a ocorrência do que passo a relatar.

Estávamos, certa feita, em um motel e, num determinado momento, comecei a sentir que minha namorada estava querendo conduzir a relação sexual. Não me opus. Adelaide começou, então, a chamar-me para uma relação anal, ao que aquiesci, induzindo-me, posteriormente, a passar a relação para a vagina, ao que aquiesci também. Subitamente, Adelaide foi tomada por intenso gozo, durante o qual emitii forte jato de urina e começou a gritar “Inácio! Inácio!”, saindo, logo em seguida de seu transe, boquiaberta, confessando, talvez mais para si mesma do que para mim:

– Meu deus! Não foi com meu noivo, aos vinte anos, que eu tive minha primeira relação sexual! Eu me esqueci! Completamente! Quando eu tinha treze anos, um sujeito de cerca de trinta – eu era muito inocente! – me ofereceu, na saída de meu colégio, para me dar uma carona de carro para minha casa e, em vez disso, me levou para um motel. Eu já me sentia, como ainda me sinto agora, absolutamente abandonada pelos meus pais e, na verdade, adorei que ele tivesse feito isso e adorei o carinho com que ele me tratou e tudo que, no motel, ele me ofereceu. Começamos a ter relações sexuais. Anais (durante os quais eu tinha orgasmo), pois, como só mais tarde entendi, ele tinha receio de me engravidar. Eu tinha o telefone da casa onde ele morava com a mãe e deixava com ela recados para ele avisando as vezes em que não iria dar muito rolo ele me pegar na saída da escola. Assim foi, durante cerca de um ano, e me relacionar com ele me compensava grandemente da sensação de abandono que eu sentia em relação a meus pais. Acho que me sentia como que vingada, por estar obtendo, de uma forma que eles certamente desaprovavam, o carinho que eles se negavam a me dar. Não sei por quê – agora, juntando tudo, acabei de desconfiar

do porquê! – certo dia, ele decidiu que tivéssemos também relação na vagina, que, devido a todas as nossas estripulias, certamente não era mais virgem. E eu, que já gozava durante as relações anais, gozei também. Na vez seguinte em que liguei para a mãe dele, querendo deixar o recado de que poderíamos nos encontrar, ela, secamente, me informou que havia sido transferido para outro estado, por razões profissionais e que tão cedo não deveria estar no Rio novamente. Isso sem ter dito nenhuma palavra para mim! Quando pedi um telefone para comunicar-me com ele, ela respondeu que não tinha autorização para dar o telefone dele para ninguém. Eu era totalmente obcecada por ele! E certamente de todo viciada no prazer sexual que nossos encontros clandestinos me proporcionavam. Acho que, mais do que tristeza, minha reação foi de frustração e de ódio. Minha auto-estima ficou tão agredida que minha reação foi decidir que iria esquecer de que ele havia existido e de tudo que se passara entre nós. Agora me lembro de que, anos depois, eu o vi na Avenida Rio Branco e de que pensei “Engraçado, eu tenho a impressão de que conheço esse sujeito”. Depois, nunca mais, e, pelo que acabou de acontecer agora, parece que, quando decidi me separar das lembranças que tinha de minha relação com ele, eu estava, sem saber, decidindo também separar-me de minha capacidade de gozar durante uma relação sexual.

Em tempo: note-se que a expressão verbal de nossas emoções – a que acompanham naturalmente nossos desejos – não só nos liberam da onerosa carga das memórias hiperestésicas; ela tem, por vezes, assombroso efeito sobre o comportamento dos demais. Eis um episódio que bem o demonstra:

Brutus

Duas horas da madrugada. Avenida Brasil. Meu automóvel começa a ratear e, definitivamente, para. Um posto de gasolina. Consigo empurrá-lo, com ajuda de alguns passantes, até ele. Sem solução: não havia quem fizesse o automóvel pegar novamente. Gasolina? Não, tanque cheio. Bateria? Não, o arranque dá partida, mas o carro morre em seguida. Única saída: mandar rebocar. Duas e trinta. Chega o reboque. O operador era um baixinho, com cara de invocado. Fiquei a uns dez metros do carro, com um copo de chope na mão, tentando consolar-me. Nessa hora, o brutamente surgiu... Muito alto, massudo, com cabelos grandes e desgrehados, voz de trovão. Ligeiramente bêbado, logo passou a tratar o carro, como fosse seu, dando ordens ao baixinho, que, decerto, só não o mandava para o diabo por estar ameaçado pelo tamanho da monumental figura. Súbito, Brutus dirige-se a mim, no tom peremptório de um marechal:

– Vem cá!

Anos de prática clínica me socorreram. Olhei dentro de mim, vi como me estava sentindo e, aparentemente, dei a única resposta que meu interlocutor não parecia esperar:

– Não estou com vontade.

Brutus poderia esperar tudo: que eu o mandasse para algum lugar; que, impressionado por seu tamanho e sua voz de trovão, eu acudisse submisso a sua ordem... Não poderia esperar uma coisa: que eu simplesmente dissesse não estar com vontade. E, convenhamos, eu não estava...

– Não está com vontade?! – chocou-se, em dúvida sobre se aumentava ou diminuía de tamanho.

– Não – confirmei, convicto.

– Mas o carro é seu!

– Ah, o senhor sabia?! – redargui.

Diminuiu. Diminuiu de tamanho e resolveu, desconcertado e manso, vir até mim. Quando chegou, como eu estava atento a meus pathe²⁰, às minhas emoções, percebi súbita – e certamente marota! – vontade de ir até o automóvel.

– Agora, me deu vontade! – enunciei.

E ele me seguiu, domesticado, até o carro. A noite terminou bem e terminou mal. Acabamos os três, mecânico, brutamontes e eu, sentados à mesa de um bar, liquidando chopes. Havia-se localizado o defeito do carro: a culpa fora, insofismavelmente, minha. Brutus repetiu-me tantas vezes isso, que acabei por indagar:

– Você acha – já nos tuteávamos – que eu não ouço bem?

– Como assim, não ouve bem? – indagou.

– Você já disse uma meia dúzia de vezes que a culpa do que aconteceu com o carro era minha e continua repetindo... Talvez você pense que eu ainda não ouvi!

– Ouviu?

– Bem. Levando em conta o número de vezes que você falou, só não terei ouvido se for totalmente surdo! – retruquei.

Como eu me espantara com a afirmação de Pedro de que temia meu riso, espantei-me com a reação de Brutus. Seus olhos marejaram-se de lágrimas e suas palavras jorraram em cascata:

– Eu sinto uma culpa horrível em minha vida! Eu sou um boçal, um estúpido, um animal. Qualquer pessoa pode ver isso. Sempre atropeliei meu filho. Meu único filho! Quando ele tinha 21 anos e tirou umas notas ruins no vestibular, quebrei violão dele em pedaços, dizendo que a droga da música não iria permitir que ele fosse nada na vida. Eu já havia feito muitas desse tipo antes. Ele entrou

²⁰ Plural grego de “pathos”.

em seu quarto, pegou uma arma e se matou... Com um tiro no peito, com um tiro no coração! No coração que eu tantas vezes destrocei!

Difícilmente uma pessoa comum presta ouvidos adequados a tamanha dor. Brutus – compreensivelmente fixado ao dramático episódio da morte de seu filho – passava a vida tentando induzir nos outros a culpa que não tinha condições de, por si mesmo, processar²¹. Óbvio que não pude fazer muito, mas acho que minha silenciosa escuta permitiu-lhe, pelo menos, um temporário alívio.

Vejamos como, mesmo fora de contexto clínico, o trabalho terapêutico pode ser levado a efeito pelo próprio portador do sintoma neurótico, quando aparelhado para tal.

*Medice, cura te ipsum*²²:

Em dezembro de 1979, comprei o então carro de meus sonhos: um MP-Lafer, réplica do MG, antigo conversível inglês. Passados quatro anos, embora bem tratado, ele foi apresentando as deficiências normais de um carro que envelhece, mas, em vez de trocá-lo por outro, como eu sempre fizera com carros anteriores, preferi mantê-lo comigo e comprar mais um automóvel, de outra marca. Cerca de oito anos após a compra desse novo carro – que, por sua vez, já havia sido trocado, enquanto eu ainda retinha o Lafer em uso – minha empresa sofreu sério baque financeiro e decidi vender o outro carro, ficando apenas com o conversível, já velho de uma dúzia de anos. Mas os ventos não estavam, de fato, a meu favor: pouco tempo depois, uma falha no sistema de lubrificação fundiu o motor do velho conversível e, durante um certo período, passei a andar de táxi. Esse foi o cenário em que desenvolvi o sintoma cuja natureza e tratamento passo a discutir.

A compulsão é um dos distúrbios que universalmente caracterizam a doença psicológica. Desejar ser rico, bonito, inteligente, culto ou famoso é bastante diverso de sofrer da compulsão de ser bonito, rico, famoso, inteligente ou culto. Do ponto de vista de sua natureza, a compulsão é um desejo que não otimiza custo-benefício: se a compulsão, por exemplo, é de trabalhar, sua vítima pode não conseguir parar de fazê-lo mesmo que isso não lhe traga qualquer maior vantagem financeira, de reconhecimento ou de prazer, e mesmo que isso prejudique sua saúde física, sua relação com a família, com os amigos etc. etc.. Já o desejo saudável otimiza custo-benefício: trabalho, por exemplo, até onde o ganho de trabalhar é maior do que os seus custos. O desejo saudável é primário; o compulsivo é secundário, nasce de uma fobia. A compulsão de enriquecer, mais do que uma atração primária que nos permite usufruir das vantagens que abundância financeira nos proporciona, é uma consequência disfuncional secundária do pânico de ser pobre. Por trás de toda a compulsão, repito, esconde-se uma fobia. E como não há dinheiro no mundo capaz de calar uma

²¹ Esse tipo de mecanismo – e a maneira de nos defendermos dele – está descrito em detalhe no caso “A Tosse” (p. 33), principalmente nos diálogos entre o protagonista e sua mulher.

²² Médico, cura-te a ti mesmo

fobia, a compulsão de ser rico leva-me a querer, interminavelmente, mais e mais dinheiro, ainda que o custo de obtê-lo esteja de longe superando as vantagens de o fazer. Uma compulsão pode ser gravíssima: faz cerca de quarenta anos havia, internado em uma de nossas instituições psiquiátricas, um paciente cujo sintoma mais flagrante era ser obrigado a lavar suas mãos centenas de vezes por dia, ficando impedido de se dedicar a qualquer outra atividade de forma minimamente continuada. Suas mãos, disseram-me, já tinham cor mais esbranquiçada do que a do restante de seu corpo. Mas evidentemente raras compulsões são tão graves. Há um sem-número de pessoas, por exemplo, que, ao sair de casa, são coagidas por pressões internas a voltar, pelo menos uma vez, à porta que acabaram de trancar, para constatar se realmente o fizeram. É chato, mas não é grave.

À época em que fiquei, durante um determinado período, sem nenhum automóvel, dei-me conta de haver desenvolvido uma pequena compulsão. Percebi-me compelido, toda vez que entrava em um táxi, a dizer para o motorista que eu tinha automóvel, embora, naquele momento, ele estivesse no conserto, que eu já tinha tido vários automóveis e que, naturalmente iria ter vários outros mais etc..

E como percebi que se tratava de uma compulsão? Quando peguei um táxi com um motorista compulsivamente tagarela. Sua verborragia era incontrollável e, a um determinado momento, veio-me o seguinte pensamento: “Estamos quase chegando e não vai dar tempo para eu dizer para ele que eu tenho automóvel!” Não poder executar a compulsão, começava a expor a fobia subjacente a ela. Ora diabos! À parte o fato de que não havia nenhuma razão prática para eu querer que um motorista – a quem eu não conhecia e o qual, ademais, eu provavelmente nunca mais veria – soubesse que eu tinha automóvel, distingui perfeitamente não sentir nenhuma compulsão em dizer a ele que eu tinha mulher, ou apartamento, ou título de Mestre, que era dono de uma clínica, ou que mais fosse...

Prato cheio para quem trabalha com disfunções psicológicas! Mais divertido do que preocupado, vista a pouca gravidade de meu sintoma, decidi tratar dele. E, simplesmente, segui a cartilha da técnica que desenvolvi, a Loganálise.

O primeiro passo da cartilha loganalítica é a descoberta do tema fóbico associado ao sintoma que se tem em mãos. O que se faz bloqueando – dosadamente! – o comportamento compulsivo cujo objetivo é impedir que o medo fóbico seja experimentado.

Passei a fazer repetidamente isso. Quando me dava conta, dentro de um táxi, que estava começando a me sentir internamente coagido a dizer ao motorista que eu tinha automóvel, não o fazia – pelo menos durante algum tempo – e ficava prestando atenção no que sentia.

E o que sentia? De início, senti que o motorista iria considerar-me uma pessoa inferior por, quem sabe?, não ter automóvel! Com o repetir-se da experiência, fui percebendo que essa inferioridade ficava de alguma forma associada com a idéia de eu ser um otário. Três pontos merecem ser assinalados. Estamos falando de Loganálise, portanto, de expressar meu pathos – minha emoção – no logos – em palavras. Ora, qual cabimento haveria em expressar verbalmente para um motorista de táxi desconhecido que eu estava fóbico de que ele pensasse que, por não ter automóvel, eu era um otário? Nenhum, certamente. Num caso como esse, em que a formulação externa – o logos exterior, como diziam os estóicos – é inadequada, devemos buscar auxílio no que esses mesmos filósofos chamavam de logos interior, formulando verbalmente a experiência em pauta para nós mesmos. “Eu estou morrendo de medo de que esse motorista de táxi ache que eu sou um otário porque não tenho automóvel” era o que eu, nessas ocasiões, com alguma variação, verbalizava para mim mesmo. Como afirma Zeldin: “as pessoas de boca fechada estão muitas vezes ocupadas em conversas tão importantes e estimulantes quanto quaisquer outras – conversas consigo mesmas ... A peculiaridade dos seres humanos é que ... possuem, por assim dizer, duas vozes interiores.”²³ A experiência com a técnica loganalítica sugere que poder externar verbalmente a experiência tem maior efeito terapêutico, mas, evidentemente, antes de decidirmos fazê-lo, é necessário avaliar o “custo social” disso. No caso, esse custo me pareceu suficientemente significativo para que eu mantivesse a conversa sobre essas minhas inesperadas vivências dentro dos limites de meu logos interior. Mas é necessário enfatizar: tal conversa deve conter uma frase equivalente a “Eu estou sentindo – ou desejando – X”. Esse é um dos pontos em que a eutonização loganalítica se diferencia da dessensibilização sistemática praticada pelos psicólogos comportamentais, em que não há exigências para que as emoções a que o sujeito se expõe sejam cuidadosa e detalhadamente verbalizadas.

O segundo desses passos: não devemos ficar tentando consciente e deliberadamente descobrir o “porquê” daquele X, daquele desejo, ou daquela emoção. Aqui, a Loganálise se distancia da ênfase interpretativa que caracteriza a Psicanálise: via de regra, a mera vivência associada a uma correta formulação verbal fará vir à nossa consciência, em seu devido tempo – muitas vezes por meio de sonhos – dados que, por si sós, esclarecem aquele “porquê”. A Loganálise não vai atrás de explicações, as explicações vêm atrás da Loganálise²⁴.

²³ Zeldin, T. *Conversação*. Rio: Record, 2001, p. 114-16. Mais de duas, eu diria. O autor, naturalmente, está-se referindo a nossa capacidade de INTRALocução.

²⁴ Ouçamos a opinião de Nicholas Hobbs, que coincide com a nossa, sobre o papel do *insight*, aquela situação em que, em suas próprias palavras, “pacientes se defrontam com explicações previamente insuspeitadas sobre determinados eventos de suas vidas”... “Sugiro que o ‘insight’ não é uma causa de mudança, mas um possível resultado da mudança. Não é uma fonte de ganho terapêutico, mas uma dentre as várias consequências desse ganho. Em uma só palavra, o ‘insight’ é um epifenômeno (“I suggest that insight is not a cause of change but a possible result of change. It is not a source of therapeutic gain but one amongst a number of possible consequences of gain ... It is not an agent of change; it is a by-product of change. In a word, insight is an epiphenomenon.”) (HOBBS, NICHOLAS. “Sources of Gain in Psychotherapy,” in: HAMMER, EMANUEL F. *The Use of Interpretation in Treatment*. New York: Grune & Stratton, 1968, pp. 14-15. Grifos meus.) Para os que já não o sabem “epifenômeno” é um fenômeno que ocorre subsidiariamente a outro sem ser causa dele.

O terceiro: nada de violências. Se você estiver se sentindo muito mal ao bloquear seu comportamento compulsivo, pare de bloqueá-lo! A idéia não é morrer da cura! Consoante esse último cuidado depois de, por algum tempo, durante parte de meu percurso no táxi, manter contida minha compulsão – enquanto simultaneamente verbalizava para mim mesmo as vivências que essa contenção me provocava – eu me permitia falar para o motorista sobre o carro que eu tinha, sobre todos os que havia tido e sobre todos que ainda pretendia ter.

Um dia, percebi que não seria grande violência comigo nada dizer, durante toda a corrida. E, de fato, não disse. Até hoje lembro-me de mim, já fora do táxi, apreensivo, enquanto o veículo se afastava, pensando: “Ele foi embora achando que eu não tenho automóvel!” E, enquanto uma de minhas vozes dizia isso, a outra ria de minha esdrúxula apreensão.

Então, por fim, aconteceu. Dentro de um táxi, indo para casa, durante um desses diálogos interiores, lembrei-me de algo de que me havia por completo esquecido. Quando tinha cerca de 5 anos, ganhei um carrinho daqueles em que a criança entrava, fazendo-os mover a pedaladas (naquela época, ainda não os havia motorizados). E com que se parecia esse carrinho? Com meu MP-Lafer! Conversível, como soem ser carrinhos de criança, tinha, como aquele, enorme capô dianteiro e traseira curta. Era o mais belo da praça onde eu brincava com outros meninos,.

Um problema, contudo, logo começou a insinuar-se. Enquanto meu corpo teimava em crescer, o carrinho insistia em manter-se de igual tamanho. E, a cada nova tentativa de andar nele, eu, apreensivo, percebia que meus joelhos mais e mais desgraciosamente se aproximavam de minhas orelhas. Frente ao crescente desconforto, passei a usar menos meu lindo automóvel. Na verdade, a usá-lo somente em situações de emergência psicológica.

Que emergências? Quando alguma ocorrência, em casa ou no colégio, feria minha auto-estima, fazendo sentir-me inferior. O mais belo carro da praça, se bem que agora desconfortável, continuava sendo o mais belo carro da praça, e andar nele ainda acariciava consoladoramente meu eu, quando ferido.

Um dia – tinha oito anos, talvez – tive uma dessas emergências. Senti-me humilhado por um comentário grosseiro de uma professora e voltei à casa decidido a lustrar meus brios com um passeio triunfal em meu carro – que já há algum tempo não usava – à volta da pracinha. Abri a despensa onde ele ficava habitualmente guardado e não o vi.

– Onde está meu carro? – perguntei a Duminência, a governanta.

– Ih, já faz tempo que sua avó deu esse carro para o filho daquele porteiro que foi embora! – respondeu ela, insinuando ser aquilo assunto de pouca monta.

Meu carro! Meu carro havia sido dado sem que ninguém me houvesse sequer comunicado a intenção de fazê-lo!? Outro menino estava usando meu carrinho, estava em sua posse, sem que eu sequer tivesse me despedido dele! Não há, até hoje, nenhum outro evento de minha vida que, revivido em minha memória, tão fortemente reative em mim a sensação de haver sido enganado, de haver feito papel de otário.

A lembrança desse episódio infantil trouxe-me à mente outros fatos, de data recente. Eu havia, dois ou três anos antes, trazido da Europa uma miniatura de um Duesenberg Spider, outro conversível semelhante a meu carrinho de infância. Até aí, nada de mais. Digno de nota foi que, em vez de despachar o trambolho – a miniatura tinha bons 30 cm. de comprimento por 12 de altura – trouxera-o desconfortavelmente em meu colo, no avião, como dizendo: “Viram, a despeito do incômodo, não me deixo separar dele!” E mais: quando meu filho, com cerca de 10 anos, perguntou-me, tempo depois, se eu não poderia lhe dar o Duesenberg, exorcizei tal possibilidade com o ânimo de quem defende o Santo Graal! Lembrei-me ainda de que meu consultório, o templo da saúde – Medice, cura te ipsum! – era, havia muito, enfeitado por símbolos de meu sintoma: miniaturas, miniaturas e miniaturas de carrinhos conversíveis, semelhantes ao Lafer.

Recuperadas essas lembranças, nunca mais me senti compelido a dizer a motoristas de táxi que tenho, tive ou terei automóveis. E dei a miniatura a meu filho, que, como esperável, a destruiu.

Quanto ao consultório, as outras miniaturas continuam atualmente lá. Servem, de vez em quando, para eu ilustrar meus pacientes sobre o tipo de trabalho terapêutico que podemos fazer sobre nós.

Técnica loganalítica (I): as origens

Sempre tive inclinações pedagógicas. Não via razão de não haver instrumentos, na técnica psicanalítica clássica, que repassassem didaticamente para o paciente as mais relevantes informações relativas ao processo que leva à cura dos sintomas neuróticos. Isso, pouco a pouco, levou-me a facilitar meus pacientes a levarem adiante, mesmo quando longe de mim, processos de auto-análise semelhantes ao que eu empregara ao tratar minha compulsão de falar de meus carros com motoristas de táxi que eu jamais anteriormente vira e, provavelmente, jamais voltaria a ver.

O caso que passo a relatar foi o primeiro em que essa abordagem pedagógica foi por mim regularmente aplicada. O resultado foi surpreendente e tornou-se o primeiro grande estímulo para o desenvolvimento do que hoje chamo de técnica loganalítica.

A Tosse

Quando Pedro, médico recém-formado, me procurou para tratamento, sua queixa principal eram freqüentes e intensos ataques de tosse. Já havia passado pelas mãos de vários pneumologistas e todos lhe haviam assegurado não haver qualquer base física para seus sintomas. O colega que por último consultou sugeriu-lhe que procurasse um psicólogo.

Em nosso primeiro contato, perguntou-me por que apresentava aquele sintoma. Disse-lhe que o porquê exato eu não teria condições de lhe avançar, mas que, como havia sido afastada base física para seu sintoma, era justo suspeitar ser ele, de fato, de origem psicológica, ou seja, fruto de haver algum tipo – ou tipos – de experiência interna sem adequada expressão verbal. Nosso trabalho, portanto, seria descobrir essa(s) experiência(s) e, em seguida, dar-lhe(s) a expressão verbal de que carecia(m). No caso de Pedro, havia indicações suficientes – mais adiante abordaremos que indicações são essas²⁵ – de que o déficit prioritário de sua comunicação verbal era relativo ao sentimento de culpa²⁶.

Pedro tinha cerca de 25 anos quando me procurou para tratamento psicológico. Nessa época, ministrava aulas em uma faculdade, era sócio do pai em uma clínica onde, juntos, davam consultas e realizavam pequenas cirurgias; namorava Neide, mais velha do que ele, desquitada, mãe de dois filhos, sendo a relação mais sexual e de amizade do que propriamente amorosa. Solicitei-lhe que me relatasse algumas situações em que se sentia assomado pelo sentimento de culpa e que escolhesse uma delas para exercitar sua capacidade de verbalmente expressá-la. Escolheu²⁷ um determinado aspecto de sua relação com essa namorada.

A questão era a seguinte: ele havia mencionado para ela certa vez que gostaria de, em algum momento não muito distante, fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos. A partir de então, Neide começou reiteradamente a acusá-lo de não amá-la o bastante, porque, caso contrário, jamais a abandonaria etc. etc.. Pedro, nessas ocasiões, sentia-se culpado, mas não expressava verbalmente isso, retrucando apenas que não tinha nenhum sentido ela ficar estragando os momentos bons atuais com alguma coisa que talvez nem fosse acontecer etc. etc..

²⁵ No caso de Pedro, esses indicadores eram por demais óbvios: passou toda sua primeira sessão me perguntando “entendeu?” ou “sabe?” apenas quando falava de algo direta ou indiretamente ligado a culpa.

²⁶ A demanda prioritária de escuta – lembrem-se de como Hércules conseguiu matar a Hidra de Lerna? Foi cortando a única das (7 ou 9, hesita a lenda) que, decepada, levaria à morte das demais, que, sem a morte daquela, cresciam novamente após serem cortadas. Note-se que, em alguns casos - como, veremos, no de Pedro – a satisfação da demanda prioritária de escuta ocupa a maior parte de uma análise, o restante sendo empregado com temas de prioridade secundária.

²⁷ Essa escolha, feita pelo paciente, permite que o paciente se aproxime, de maneira dosada, da emoção relativamente à qual não consegue sentir-se escutado.

Expus-lhe minha opinião de que essa maneira de ele se comunicar poderia servir a muitos propósitos, mas não, certamente, ao de auxiliar nosso trabalho terapêutico e indaguei se estava disposto a, nos momentos em que os comentários de Neide provocassem nele sensação de culpa, tentar uma nova maneira de reagir a isso em termos verbais. Respondeu que sim, e passei a instruí-lo²⁸. O paciente, munido de meus ensinamentos, desempenhou de forma inesperadamente brilhante a tarefa de modificar seus hábitos de comunicação verbal. Em uma das sessões seguintes – era atendido duas vezes por semana – trouxe-me o seguinte diálogo, travado entre ele e sua companheira, no qual demonstrava haver perfeitamente assimilado os princípios de comunicação propostos pela Loganálise:

- Quando você fala esse tipo de coisa eu me sinto superculpado – retrucou, após mais uma das invectivas de sua namorada, acusando-o de não amá-la.*
- Não é para você se sentir culpado que eu falo isso.*
- Eu não disse que você fala isso para eu me sentir culpado. Eu disse que, quando você fala esse tipo de coisa, eu me sinto assim!²⁹;*
- Ah, mas você também não tem razão para se sentir tão culpado!³⁰*
- Eu também não disse que tenho razão, nem sei o que significa “tão” culpado. Eu disse, simplesmente, que me sinto culpado...³¹*
- Bem, se você está pensando que eu vou deixar de falar nisso só porque você se sente culpado, você está muito enganado..*
- Neide, também não me lembro de lhe haver pedido que você pare de falar sobre esse assunto: lembro-me apenas de lhe haver dito que me sinto culpado quando você fala sobre ele. Se você continuar tendo vontade de falar, você fala; se eu continuar me sentindo culpado e tiver vontade de lhe dizer isso, eu digo! Simples assim!³²*

Neide – que, aliás, era psicóloga – percebera a mudança na maneira de Pedro comunicar-se depois que começara seu trabalho comigo e pôs fim à conversa com o seguinte comentário:

- Ih, que estranha essa sua terapia!...*

Note-se que eu havia dito a Pedro que, se Neide tentava continuamente lhe inculcar culpa, era provavelmente porque tampouco ela sabia lidar com esse sentimento e que, caso fracassasse em suas tentativas de fazê-lo calar a boca, também ela acabaria falando sobre as culpas que certamente abrigava.

²⁸ Vê-se aqui o elemento explicitamente pedagógico da psicoterapia loganalítica.

²⁹ Deixando claro que, num diálogo loganalítico, que visa apenas a redução da força excessiva, disfuncional, de uma determinada emoção, apenas importa que ela possa ser verbalmente expressa, de maneira incondicional, independentemente de quaisquer outras considerações. Logo veremos o resultado quase milagroso dessa abordagem.

³⁰ Incondicionalidade do direito à expressão verbal da emoção!

³¹ Idem.

³² Idem.

Minha expectativa foi logo preenchida. Após ser seguidamente defrontada, durante algum tempo, com o tipo de emoção que ela mesma induzia em meu paciente, Neide acabou expondo-se. Um belo dia, aproximou-se de Pedro e admitiu:

- Sabe de uma coisa? Eu também me sinto muito culpada...
- Ah, sim? De quê? – retrucou Pedro.
- Da maneira como eu abandonei meu ex-marido: acho que não joguei limpo com ele...

E saiu contando para Pedro sua própria história de culpa, o que se presta, além do mais, para demonstrar como os efeitos de uma terapia bem feita reverberam positivamente no meio em que o paciente está inserido, ampliando o discurso de muitos daqueles com quem ele se relaciona. Algumas “relações amorosas” têm como meta primordial permitir que seus protagonistas dêem forma verbal a alguma emoção ou desejo³³ insuficientemente verbalizado. Resolvido esse problema, algumas dessas relações se aprofundam, pois subsistem razões menos “artificiais” para que se mantenham; outras perdem sua única razão de ser e se dissolvem; outras têm, simplesmente, sua natureza transformada. A que existia entre Neide e Pedro transformou-se. Aparentemente, essa relação se havia estruturado como namoro mais para fornecer a ambos a oportunidade de dar forma ao problema da culpa do que porque de algum modo fossem eles companheiros amorosos adequados um para o outro. Era mais uma dessas inúmeras relações que, disfuncionais sob vários aspectos, buscam essencialmente, mas de forma lamentavelmente canhestra, uma ampliação da fala. Satisfeita, em Pedro e Neide, essa ampliação – tendo ambos se sentido escutados ao expressar verbalmente suas culpas – a relação entre eles corrigiu-se em suas demais dimensões: reconheceram-se como meros bons amigos, passando, inclusive, a bater grandes papos telefônicos sobre suas novas conquistas amorosas (Pedro, em pouco tempo, começou a namorar uma colega de trabalho, por quem de fato se apaixonou e com quem, ano e pouco mais tarde, terminaria por se casar). Mas, a despeito desses avanços, os acessos de tosse, ainda que algo atenuados, persistiam, indicando que a terapia ainda estava muito aquém de debelar o sintoma que lhe tinha dado razão de ser. Claramente, deveríamos trabalhar mais.

Foi Pedro quem sinalizou o caminho que iríamos percorrer ao fazê-lo. Na verdade, o sucesso na aplicação das sugestões loganalíticas na relação com sua ex-namorada, embora houvessem alterado muito pouco seu sintoma-queixa, criou em meu paciente uma espécie de euforia – ficou mais “animado” – o que lhe forneceu adicional estímulo para trabalhar outra relação em que se sentia fortemente acossado pela culpa: a relação com Fábio, seu pai.

³³ Na verdade, todo desejo nasce primariamente de uma emoção (palavra que, neste livro, é usada como sinônimo das palavras sentimento e afeto).

Esse último, com efeito, para induzir culpa, era um trator. Na clínica que possuíam, tinha o deplorável hábito de, durante as cirurgias que realizavam em conjunto, desancar o filho, chamando-o de incapaz etc., o que, além de, segundo Pedro, ser algo grandemente injusto, era, ao ser feito diante dos funcionários de ambos, de uma inadequação atroz. Entretanto, mesmo sabendo que as invectivas do pai eram injustas e inadequadas, Pedro não conseguia furtar-se a sentir culpa e, sentindo-a, ficar totalmente inerte, o que apontava para a natureza não só frustrante, mas disfuncional, dessa culpa...

Repassei com Pedro a estratégia e as técnicas da Loganálise. Repeti-lhe ser fundamental que, nas ocasiões em que ela era ativada, ele enunciasse verbalmente sua sensação de culpa – pelo menos, internamente, mas, sempre que possível, externamente – e, que, ainda uma vez, se se desse conta de que seu pai, por mais que lhe induzisse tal culpa, não iria, como ocorrera com Neide, sua ex-namorada, gostar de ver o efeito de seu comportamento explicitado e tentaria desviar o assunto para outro qualquer. Seria fundamental que ele, ao verbalizar seu sentimento, soubesse fincar pé sobre a necessidade de legitimar, frente a seu pai, seu pleno direito de fazê-lo.

A presteza e inteligência com que meu paciente executou sua tarefa, impressionou-me mais uma vez. Tento reproduzir o diálogo que se travou, segundo o relato de Pedro, quando, em nova ocasião, experimentou a culpa que lhe provocavam as invectivas de seu pai.

– Sinto muita culpa quando você fala assim – enunciou para o pai, como fizera com a ex-namorada, meu paciente.

Fábio, veterano em induzir culpa, fez bem diverso do que MESMO eu havia esperado, não fugindo ao repto:

– E era para sentir o quê? Era para sentir o quê? Era para sentir culpa mesmo! E há muito tempo!

Meu paciente foi brilhante:

– Puxa, então você deve estar supersatisfeito!

– Satisfeito com quê? Satisfeito com quê? – retrucou, nervoso, o pai.

– Ué! Você não queria que eu me sentisse culpado? Conseguiu. Mereço um abraço!³⁴

A resposta ainda foi imediata:

– Como, um abraço!?! Por que abraço? Quero saber que providências você vai tomar sobre isso!

³⁴ No diálogo loganáltico a verbalização das expressões emocionais de nossos interlocutores também são valorizadas. Pedro, de uma forma bastante original, estava legitimando a fala do pai.

– Nenhuma.

Pela primeira vez, Fábio hesitou:

– Nenhuma!? Providência nenhuma!? Mas você não está sentindo culpa? Como não vai tomar providência nenhuma?!

– Não vou tomar providência nenhuma porque, na verdade, embora você consiga me fazer sentir culpa, eu não sei se ela tem cabimento ou se – e, agora, meu paciente engrossou – você é um grande f.d.p., que vive enfiando culpa nos outros, para poder manipular e explorar todo mundo!³⁵

Desta vez, a resposta do pai foi um grande silêncio. A partir dali, Fábio nunca mais se sentiu à vontade para dar shows acusatórios durante as cirurgias que realizava com o filho. Mas, e a tosse? Persistia, pouco atingida pelo processo...

Algo diferente, contudo, começou a acontecer: Pedro passou a faltar, a chegar atrasado às sessões, a esquecer de fazer o pagamento no dia aprazado. Tornou-se evidente que, na própria relação comigo, ele estava procurando criar artificialmente oportunidades para sentir culpa³⁶. Na verdade, é impossível conversar com um santo, se ele não tem um terreiro em que possa baixar...A técnica psicanalítica clássica incentiva essa repetição da problemática do paciente na relação com o terapeuta por considerá-la um elemento primordial para o bom progresso do tratamento. A Loganálise, que entende não importar o terreno em que baixe o santo, contanto que baixe, não tenta provocar essa repetição na relação com o terapeuta, embora trabalhe de bom grado sobre ela, quando espontaneamente floresce ali. Com efeito, a reprodução das situações de culpa na relação de Pedro comigo iriam facilitar a investigação das razões pelas quais culpa era, para ele, um sentimento de tão difícil expressão. Já haviam transcorrido oito meses de tratamento quando ocorreu a sessão em que se travou o seguinte diálogo:

– Puxa vida! Esqueci de novo de trazer o pagamento! Estou me sentindo super mal! – explode Pedro, visivelmente constrangido.

– Bem, por tudo que temos visto, imagino que “super mal” signifique “super culpado”. É isso?

– Caramba! Claro que é isso!!

– Ou seja: mesmo aqui, onde temos incentivado a verbalização de seus sentimentos de culpa, não está sendo fácil usar a palavra³⁷. Ou não?

– É. De fato, não está.

– Você tem idéia de por quê?

³⁵ Completando a enunciação de como se sentia em relação a seu pai.

³⁶ Ótimo exemplo do que a técnica freudiana chama de “transferência”, algo de ocorrência muito mais raro na técnica loganalítica do que naquela outra técnica.

³⁷ Isso é o que a Psicanálise freudiana chama de “interpretação da resistência transferencial”.

Poucas coisas poderiam ter-me surpreendido mais do que a resposta de Pedro:

– Porque eu tenho medo de que você ria de mim!

A última coisa que me passara pela cabeça foi que Pedro temesse meu riso diante de sua culpa por estar repetidamente atrasando meu pagamento!

O que veio em seguida trouxe consigo a chave do mistério. Com efeito, logo após meu paciente explicitar o que temia, sua mente foi invadida por uma lembrança, até então oculta, de quando tinha quatro anos e ganhou de sua mãe um patinho recém-nascido, desses que se vendiam nas feiras. Não durou muito e, em suas brincadeiras, ele matou o patinho...

Ao lembrar-se disso em análise, reviveu nitidamente a culpa³⁸ que então sentira. Tão nitidamente que, de imediato, começou a chorar. A chorar de culpa e, curiosamente, também a rir, por estar, duas dezenas de anos após o acontecido, chorando de culpa por haver matado o patinho.. Num tom que misturava surpresa, indignação, alívio, divertimento e ternura, exclamou:

– Que absurdo! Como posso, tanto tempo depois, estar chorando por causa desse maldito pato!

E chorava e ria. E ria e chorava. Quando, então, recuperou a lembrança do episódio que veio tudo aclarar³⁹:

– Quando eu percebi que havia matado o patinho, fui até minha mãe e, invadido pela culpa, exclamei: “Mamãe, eu matei o patinho!”

– Sabe como ela reagiu? Ela riu de mim! Ela disse: “Deixa de ser ridículo, menino! Joga fora esse pato morto! Depois se compra outro!” Acho que, desde ali, quando sentia culpa, me sentia ridículo e com medo de que, caso a externasse, fossem fazer pouco de mim, como, de fato, esperei há pouco que você fizesse!

A partir da recuperação, carregada de afeto, de lembranças anteriormente inacessíveis, o processo de ampliação da fala adquire regularmente uma espontaneidade antes ausente. A partir dessa lembrança, Pedro e eu não precisamos mais procurar deliberadamente os “terreiros” onde, em sua vida, “baixara o “santo” da culpa: inúmeros episódios associados a esse sentimento

³⁸ “Lembranças sem afeto são quase sempre ineficazes” (“Affektlos Erinnerungen sind fast immer wirkungslos”). Breuer, J. & Freud, S., op. cit. (Cf. p. 2). Eu diria que sempre são ineficazes.

³⁹ Esse tipo de episódio ilustra de forma cristalina o fundamento da afirmação de Breuer & Freud (op. cit.) – anteriormente já sugerida, embora de forma menos enfática, por outros autores – de que “os histéricos sofrem principalmente de reminiscências” (“der Hysterische leiden grösstenteils an Reminiszenzen”), afirmação posteriormente generalizada para a muito mais abrangente de que todos os neuróticos sofrem de reminiscências.

passaram a vir espontaneamente à lembrança de meu paciente, inclusive sob forma de sonho, sobre os quais não me delongarei aqui..

Tal desenvolvimento é semelhante ao de uma respiração boca a boca: força-se o pulmão paralisado a movimentar-se até que, num determinado momento, ele recupera espontaneamente sua capacidade de respirar por si mesmo... Os exercícios loganalíticos, executados de maneira diligente e deliberada, recuperam o funcionamento espontâneo de um dos “processadores verbais de emoção” até então bloqueados e esses processadores, agora reativados, tomam, a partir daí, o tratamento em suas próprias mãos. Entre as dezenas de lembranças espontaneamente trazidas pelos processadores verbais de culpa liberados, uma teve particular relevância para revelar a origem do sintoma da tosse e, dessarte, dissolvê-lo.

Meu paciente lembrou-se da imagem do avô, Lauro, internado em um hospital, pedindo-lhe, e a Fábio, que não o deixassem dormir sozinho ali, porque, naquela noite, ele iria morrer. Ambos fizeram pouco caso das apreensões de Lauro, que, por lamentável erro de enfermagem, viria de fato a falecer naquela noite. Erro que teria por certo sido evitado, caso pelo menos Pedro, ou seu pai, ambos médicos, houvesse ficado no hospital... O episódio tinha tudo para provocar uma enorme quantidade de culpa e, se extremamente frustrante para qualquer pessoa, para alguém como Pedro, com a verbalização de suas vivências de culpa interdita, não foi apenas frustrante, produziu-lhe um sintoma neurótico: seus ataques de tosse.. Entende-se isso, quando se sabe que a imagem do avô, descrita por Pedro, pedindo que não o deixassem sozinho no hospital, tinha um detalhe essencial para a compreensão do sintoma que trouxera seu neto à psicoterapia: Lauro tossia incessantemente! A Loganálise havia chegado ao episódio que, projetado no tempo, formatara o sintoma de Pedro e, quando este, com forte emoção, relatou-o para mim, foram-se, como esperado, seus ataques de tosse...

Foram-se? Em termos. O sintoma, a partir dali, regrediu a níveis que o tornavam perfeitamente suportável, imperceptível para os que rodeavam meu paciente: já não era mais, por exemplo, um estorvo para o exercício de nenhuma de suas atividades profissionais. De vez em quando, contudo, Pedro ainda “dava umas tossidinhas” (sic) que ele dizia saber não terem qualquer base orgânica. Nessa época – estávamos no nono mês de tratamento – Pedro me afirmou, com curiosa precisão, que o sintoma se havia reduzido “em 70%” (sic). Continuamos nossos encontros, agora limitados a uma vez por semana, até dezembro daquele ano. Algumas outras consequências da culpa mal processada foram então trabalhadas. Dessas, duas merecem especial atenção.

Primeiro, veio à tona que sua opção pela Medicina, antes que resultado de livre escolha, era, principalmente, fruto da pressão do pai e de uma compulsão de curar por meio da qual Pedro tentava compensar a culpa – posteriormente agravada por outros episódios – pela morte do patinho. Ao lidarmos com isso,

tornou-se patente que sempre deixara de lado uma vontade que reconhecia sobremaneira mais autêntica: a de ser administrador de empresas. A solução era óbvia e foi incontinenti adotada: passou a dedicar-se mais à administração da clínica cuja propriedade dividia com o pai e, à parte sua satisfação aumentada, seus naturais dotes para a tarefa logo se revelaram sob forma de um substancial aumento do lucro da empresa.

Segundo, foi ficando claro como exercer medicina, além de uma compulsão, era um ato expiatório, mais que um prazer. Enquanto médico, era um trabalhador compulsivo, que trabalhava muito, ganhava pouco, e, desse pouco, nada gastava em lazer. Vivia para trabalhar. Na passagem para a atividade de administração, começou a trabalhar menos, ganhar mais e aproveitar os excedentes de tempo e de dinheiro para se divertir.

Ao longo dos últimos meses de terapia – o paciente interrompeu-a um ano após seu início – houve mais duas etapas na evolução do sintoma da tosse: em um determinado momento, o paciente me comunicou que as “tossidinhas” ocasionais – os supostos 30% restantes do sintoma – também haviam desaparecido; um pouco adiante, disse-me que pensara que o sintoma havia remitido por completo, mas só agora percebera que, durante algum tempo depois de não estar tossindo absolutamente mais, ainda ficara uma espécie de “coceirinha” na traqueia, que agora se fora também!

O paciente retornou cerca de dois anos após o término desse primeiro período de terapia para trabalhar comigo alguns aspectos da relação com sua esposa. Os ganhos da terapia anterior se mantinham. Não pudemos, contudo, dar continuidade a este segundo período analítico, pois o paciente comunicou-me haver decidido transferir-se para os EUA, onde entreviu uma oportunidade particularmente favorável para fazer sua pós-graduação. Não em medicina, naturalmente: em administração de clínicas médicas! Desejei-lhe boa sorte.

Pois bem, o caso de Pedro permitiu-me brindar-lhes com uma ilustração relativamente detalhada de como a técnica loganalítica opera para implementar a estratégia da ampliação da fala, não demonstrando muito mais do que: (1) há mais de uma maneira de fazê-lo e (2) que a dissolução de memórias hiperestésicas faz desaparecer sintomas neuróticos. Mas o que mais pretendo enfatizar aqui é o que aprendi de Pedro: ele me demonstrou que um paciente bem instruído sobre o tipo de linguagem capaz de patrocinar dissolução de sintomas neuróticos pode ser ensinada e há pacientes particularmente capazes de fazer uso disso.

Severino foi outro paciente que reforçou em mim essa aprendizagem.

Fuga:

Quando Severino me procurou, tinha acabado de cometer um ato que ele mesmo reconhecia absurdo. Quando sua mulher e seu filho, dias antes, foram

passar o fim-de-semana visitando parentes, ele encostou um caminhão fretado na porta de sua residência e, sem qualquer aviso prévio, mudou-se. Ao chegarem de volta, sua mulher não tinha mais marido, seu filho não tinha mais pai...

– Faz treze anos que eu queria me separar dessa mulher! Mas eu nunca sequer consegui falar sobre isso! Não estava agüentando mais e vi que o único jeito de escapar era fazer o que eu fiz⁴⁰. Agora estou morrendo de culpa, mas voltar vai me colocar de novo naquela situação insuportável. Estou entre a cruz e a caldeirinha! – desabafou.

Já em sua nova residência, Severino tinha, transido de medo, ligado para casa para tentar explicar o inexplicável e dizer que, logo que tivesse coragem, daria seus novos endereço e telefone. Quando chegou a mim, já o havia feito, mas a culpa e o medo não o deixavam. Pediu que eu o ajudasse a descobrir como se relacionar, agora, com o filho e com quem, oficialmente, ainda era sua esposa. Dada a flagrante incompetência de Severino para lidar com separação, pedi-lhe que, até a sessão seguinte, me trouxesse algumas situações de seu cotidiano em que essa dificuldade se mostrasse evidente, para que pudéssemos trabalhar detalhadamente sobre cada uma delas⁴¹.

Não me recordo de nenhum paciente que, até hoje, tenha preenchido com maior rapidez e eficácia semelhante pedido. E – acrescenta-se – se eu estava boquiaberto com a eficiência do paciente, mais estava ele, ao se dar conta de como o tema “separação” penetrava e obstruía seu cotidiano. Já em sua segunda sessão, listou-me as situações seguintes, em que a fobia de separar-se o paralisava.

- “Eu faço ginástica na última hora de uma academia. Cada pessoa que acaba a própria série de exercícios despede-se de todos e vai embora. Eu não consigo! Estico indefinidamente a execução da minha, de forma a ficar por último e poder sair sem ter que me despedir de ninguém.”
- “Ontem, um amigo que há muito eu não via encontrou-me na rua e começou a falar. Eram vinte para as quatro e eu tinha que depositar um cheque no banco antes que ele fechasse. Fiquei rezando para meu amigo calar a boca e se despedir a tempo. Não calou nem se despediu. Não consegui depositar o cheque.”
- “Trabalho, há mais de cinco anos, no centro da cidade e almoço sempre por lá. Freqüentemente, no restaurante, encontro alguns colegas. Na saída, costumamos parar em frente a um jornaleiro e ficar batendo um papo. Mesmo quando estou querendo voltar logo para a minha loja, não consigo. Tenho que ficar esperando que todos se despeçam e vão embora para eu poder sair também.”

⁴⁰ Aqui é óbvia a substituição de uma possível fala adequada por uma ação indiscutivelmente inadequada.

⁴¹ Pedagogia!

- “Essa é o máximo. E o que me dá raiva é que sempre fiz isso mais ou menos automaticamente, como que hipnotizado. Pensava, lá num canto de minha cabeça: “que coisa estranha eu estar agindo assim”. Mas continuava fazendo igual... Bem, o negócio é o seguinte – fico um pouco envergonhado de falar – há anos que almoço no mesmo restaurante. Há anos que, indo para esse restaurante, eu penso: se quisesse, poderia ir para outro. Mas não vou. Outro dia, um garçom, useiro e vezeiro em lá me atender, dirigiu-se a mim, antes mesmo de eu ordenar qualquer coisa, com uma coca, limão e gelo, o que comando sempre. Quando percebi isso, me deu uma raiva imensa dele e sabe o que eu pensei? Sabe o que eu pensei? “Seu f. d. p., você pensa que, se eu quiser, eu não posso ir a outro restaurante! Posso, sim, seu f. d. p.!” Pois é. Na verdade, eu posso, mas não vou! ”

Assim como fizera com Pedro, pedi a Severino que escolhesse uma dessas situações para, em sua vida real, nela enunciar seus sentimentos, segundo instruções. Severino escolheu o jornaleiro. Foi almoçar de coração trepidante, pensando “É hoje!”, temeroso da censura que viria de seus colegas quando insinuasse querer voltar antes deles para seu trabalho. Na hora, com o coração acelerado, enunciou-se bem como ensaiáramos:

– Pessoal, estou meio ansioso, porque tenho que fazer umas coisas lá no meu trab...⁴²

Não teve tempo de terminar.

– Ih, cara, eu também. Deixa eu me mandar! – disse um.

– Foi bom você ter falado, minha mulher vai passar lá no trabalho para falar comigo e talvez até já esteja lá. Tchau, tchau! – disse o outro.

– Eu também ‘tô zarpando! – acrescentou o terceiro.

E meu paciente ficou paralisado, em frente à banca, admirado com o fato de o ter pretendido separar-se não haver feito o céu desabar sobre sua cabeça... O resto do tratamento desenrolou-se dentro dos padrões esperados: o desafio que o paciente escolheu em seguida enfrentar foi a sessão de ginástica; o seguinte, o restaurante etc. etc..

Como de hábito, o processo acabou libertando memórias – que vieram atrás de nós, nós não fomos atrás delas – associadas a seus distúrbios atuais com separação. Dessas, o episódio-chave foi o seguinte:

Severino nascera no interior do nordeste. Era o caçula de 20 irmãos e, certamente, não experimentara essa posição como de nenhum privilégio. Relatava, como emblemática do desconforto associado a ela, a eternamente

⁴² Note-se a importância na presença da emoção de quem fala na enunciação empregada para enfrentar toda e qualquer fobia.

repetida cena de sua família sentada à mesa para o jantar: de uma grande travessa, o pai pegava o seu bife, a mãe pegava o seu bife, o primeiro irmão pegava o seu bife, o segundo irmão pegava o seu bife, o terceiro... Bem, quando a travessa chegava a Severino, lá estava o seu bife: o que ele não escolheu e, decerto, não o mais robusto, mas sim, o mais mirrado de todos...

Um dia, aos sete anos, amotinou-se. Fugiu de casa, disposto a marcar protesto. Foi para o pomar – era à tardinha – e subiu numa árvore, certo de que em pouco tempo – com pompa e circunstância – iriam buscá-lo, rogando que voltasse. Cinco horas, cinco e meia, seis horas, sete, oito, nove... Humilhado, desce da árvore e, meio à escuridão, volta para casa. Lá chegando, encontra alvoroço em que se lhe dá ainda menor atenção do que a com que era habitualmente brindado: sua mãe tinha tido um episódio cardíaco à tarde e, por fim, chegava a condução que iria levá-la, com o pai de Severino, para a capital, onde, na verdade, passariam um ano, deixando meu paciente, durante esse longo ínterim, sob a batuta dos dezenove irmãos-rivais. A partir daí, ele passou a associar qualquer manifestação sua no sentido de separar-se com o céu, de fato, caindo sobre sua cabeça! O tratamento mostrou que nem sempre caía e, em consequência, Severino libertou-se de suas dificuldades com separação, passando a manter uma relação cordial com a ex-mulher (divorciaram-se) e carinhosa com o filho.

Os tratamentos de Severino e de Pedro, transcorridos há cerca de três dezenas de anos, convenceram-me de que a capacidade de pelo menos alguns pacientes, caso bem instruídos, levarem adiante significativa parte do próprio tratamento estava sendo seriamente subestimada pelos profissionais de saúde mental. E resolvi ousar:

Quando Teresa, moça de seus trinta anos, procurou-me pedindo que eu atendesse sua filha e a curasse um incômodo sintoma, afirmei, arriscando:

– “Eu não preciso fazer isso. A senhora vai fazê-lo! Caso não consiga, eu aceito sua filha como paciente.”

E dei-lhe as instruções necessárias para que ela mesma assumisse o “caso”. Relato como isso se passou:

Pânico Noturno:

Carla, de nove anos, desde o berço apresentava ataques de pânico durante o sono. Ainda com poucos meses de nascida, Carla acordava ao meio da noite em agudo pranto, olhos esbugalhados, sem aparente razão para isso. Recentemente, o sintoma se agravara. Os ataques de pânico noturno tornaram-se quase cotidianos e requeriam delongada assistência dos pais antes que a menina voltasse a dormir. Como ambos trabalhavam jornada integral, encontravam-se exauridos, cronicamente insones e apresentando sensível queda

em seu rendimento profissional. Exames médicos haviam afastado a hipótese de haver causa física para o sintoma.

Há muito que, em minha prática, reservo um tempo das consultas iniciais para explicar, seja para o paciente, seja para seus responsáveis, qual o provável problema a ser enfrentado e como isso deverá ser feito. No caso de crianças e adolescentes é particularmente importante a colaboração adicional ao tratamento prestada pelos pais. Nesse caso, percebi que Teresa se mostrava equilibrada, inteligente e sensível, apresentando particular facilidade para compreender o funcionamento dos mecanismos mentais. Portanto, fui direto:

– Teresa – disse eu – embora eu não conheça sua filha e esteja vendo você pela primeira vez, vou permitir-me levantar uma hipótese. Tudo aponta para que sua filha tenha, constitucionalmente, uma tendência à angústia acima da média. Digo isso porque apresentava ataques de pânico já no berço, mesmo antes de haver passado por grandes influências ambientais. Ora, para que nos assenhoremos de qualquer emoção e possamos adequadamente administrá-la, precisamos dar forma a essa emoção e, em seguida, verbalmente expressá-la. Se Carla, até hoje, continua tendo ataques noturnos de pânico, você deve vir impedindo que sua filha encontre forma para seu medo e, a partir daí, o expresse. Você, por exemplo, ao contrário dela, pode ser uma pessoa que tenha pouca tendência pessoal a sentir medo e, com isso, pode ter ficado inclinada a desqualificar o dela. Não podendo dar formas a ele durante o dia, sua filha continuou a descarregá-lo por meio dos ataques noturnos de pânico.

A reação de Teresa a minhas colocações foi imediata:

– Ah, sem dúvida! – disse ela – Na minha família, sou mesmo descrita como uma pessoa que não sente medo. E, realmente, tendo a reagir ao medo dos outros achando que é bobagem.

Animado com a possibilidade de estar seguindo a pista certa, insisti:

– Pois bem. Se, ao contrário de você, Carla tem uma predisposição aumentada para sentir medo, ela precisa dar-lhe diferentes formas, para, a partir delas, aprender a manejá-lo. É um processo lúdico, uma espécie de brinquedo, que, se bem sucedido, leva à administração adequada do medo e de qualquer outra emoção. Por isso, o que lhe vou pedir é, primeiro, que você preste atenção para ver onde, no dia a dia, ela coloca esse medo e, segundo, que, em vez de desqualificá-lo quando ela o expressar, escute-a falar sobre ele, estimulando-a a estender-se o quanto puder sobre o assunto.

– Ah, mas eu já ridicularizei e desqualifiquei tantas vezes suas expressões verbais de medo, que, agora, ela nem fala mais... – retrucou Teresa.

– Pode ser – respondi – mas permita-me duvidar disso. Se prestar atenção, você vai ver que, em algum momento, ela ainda tenta verbalmente expressá-lo. Pelo que eu conheço de gente, até o derradeiro momento de nossas

vidas ainda temos esperança de que alguém escute o que sempre quisemos falar...

Dei-lhe ainda algumas pistas sobre como reagir caso detectasse alguma tentativa da filha no sentido de falar sobre medo e acrescentei que, se ela mesma conseguisse conduzir o processo, eu não precisaria atender a menina. Marcamos para uma semana depois e combinamos que, se Teresa não fosse ela mesma capaz de implementar com sucesso minhas instruções, deveria trazer Carla na próxima consulta. .

Na sessão seguinte, chegou sem a filha. Estava com uma expressão curiosa, entre perplexa e divertida.

– O senhor tinha razão – começou dizendo – ela não tinha desistido totalmente de falar sobre o medo. Outro dia, chegou-se a mim, e confessou: “Mamãe, eu tenho medo do filho da vizinha!” Eu já ia começar a, como o senhor diz, “desqualificar” o seu medo, dizendo que não havia razão para isso, que a vizinha e seu filho eram boas pessoas etc. etc., quando me lembrei de nossa conversa aqui, segurei minha boca e disse outra coisa.

– O quê? – perguntei.
 – Disse: Puxa, minha filha, que chato! Posso fazer alguma coisa?
 – Brilhante! E ela?
 – Bem, primeiro parou um pouco e ficou olhando para minha cara, com expressão de espanto...Acho que não estava me reconhecendo...
 – Não é pra menos. E depois?
 – Depois, segurou o meu braço e, como se me acalmasse, falou: “Não, mamãe, você não precisa fazer nada, eu só queria dizer!”

“Só queria dizer”!!! À sua maneira, a menina estava informando a sua mãe:

– Mamãe, não quero ações, quero ESCUTA!

Não conheci pessoalmente Carla. Estive com a mãe apenas mais uma vez. Ela, inteligente e, sendo apta, como Pedro e Severino, para agir de acordo com minhas instruções, passou a escutar a filha, quando esta última falava de medo. Os ataques noturnos de pânico – com duração de nove anos! – foram remitindo e, para meu próprio espanto, no curtíssimo período de dois meses, desapareceram de todo. Tenho follow-up⁴³ de cinco anos: o sintoma nunca mais retornou!

⁴³ Acompanhamento.

Óbvio que resultado tão promissor animou-me a empreender nova aventura e, mais uma vez, defrontei-me com um caso em que a emoção verbalmente bloqueada era o medo⁴⁴.

Enurese:

À época dos fatos que passo a relatar, Miguel tinha 11 anos e morava muito distante do Rio, numa fazenda próxima a uma minúscula cidade desprovida de quaisquer recursos de atendimento psicológico. Tendo, no Rio, encontrado socialmente seu pai, Eduardo, velho amigo, falávamos sobre terapia e mencionei quanto eu estava impressionado com a capacidade de pais bem informados para fazer cessarem sintomas neuróticos de seus filhos, referindo-me ao caso de Carla, que acabei de descrever. Eduardo, então, replicou:

- Bem. Eu tenho um filho com um sintoma que data de desde sempre...*
- Como assim? - perguntei.*
- Ele nunca conseguiu parar de urinar na cama. Faz isso, na verdade, praticamente toda noite. E o problema se está agravando porque, com essa idade, já recebe convites de amiguinhos para passar fins-de-semana em suas casas e ele está se tornando um retraído, recusando todos os convites, por medo da vergonha que seu sintoma poderia fazê-lo passar diante dos colegas.*
- Esse tipo de sintoma, por vezes, tem fundo neurológico, mas, nessa idade, já se deveria ter remitido. Foi feito um eletro?*
- Sim, mas nada se encontrou de relevante.*
- É provável, então, que a causa seja psicológica. Quem sabe posso ajudar?! Você disse que viaja hoje, mas Laura, sua mulher, fica ainda um pouco no Rio. Mande-a lá na clínica.*

Encontrei-me com Laura num mês de dezembro. Diversamente do que ocorrera com Carla, cujos ataques de pânico apontavam de forma bastante direta para a emoção a ser verbalizada, a referência, no caso de Miguel, era indireta – sugerida por expressões como “mijou-se de medo” – e tênue demais para fundamentar sozinha uma firme hipótese sobre a natureza da emoção a ser, como dizemos em psicoterapia loganalítica, “eutonizada”⁴⁵. As condições de vida de Miguel favoreciam, contudo, a suposição de que também aqui o medo era, de fato, a emoção implicada. Apontava particularmente nesse sentido a ênfase de Laura sobre que Eduardo, o pai de Miguel, havia adotado, no meio agreste em que viviam, uma linha pedagógica que entendia o enfrentar sem medo as agruras típicas de uma remota zona rural – escuridão, animais de diversos tipos etc. – como um ingrediente inseparável da condição masculina.

⁴⁴ Em minha prática clínica, nessa ordem, medo, culpa e vergonha são as emoções que mais frequentemente alimentam as disfuncionais memórias hiperestésicas

⁴⁵ Do grego “eu” (= excelente, perfeito) + tônus, do latim “tonus” (= tensão).

Laura só voltaria ao Rio em janeiro e não poderia estar comigo antes disso. Como não tinha nenhuma hipótese alternativa com que trabalhar, pedi-lhe que nada fizesse além de observar se o menino conseguia expressar verbalmente suas experiências de medo e qual a maneira de reagir dela mesma e do pai.

No início de janeiro, encontramos-nos novamente. Laura havia feito seu dever de casa. Suas conclusões: Miguel, frente a situações potencialmente geradoras de medo, ou nada expressava ou, isso muito mais raramente, fazia pálida referência a suas apreensões, quando a situação já de há muito se extinguiu. Acrescentou que, quando a verbalização de medo por parte do menino chegava a ocorrer, a reação do pai era de crítica e a dela a de minimizar o cabimento de se sentir medo. Expus as prováveis conseqüências dessas atitudes no sentido de produzir memórias hiperestésicas, com seu séquito de sintomas neuróticos. Laura disse que tentaria mudar, que explicaria o processo ao pai, mas que estava incerta relativamente à possibilidade de esse último mudar sua atitude. Esclareci que, caso estivesse correta nossa hipótese, a existência de uma única pessoa para quem Miguel pudesse expressar seu medo já poria em curso um processo de mudança. De qualquer forma, como a posição do pai parecia muito fortemente contrária a essa expressão e como o ambiente em que o menino vivia oferecia freqüente defrontamento com situações assustadoras, sugeri à mãe que, quando ela própria se sentisse amedrontada, verbalizasse isso para Miguel, à guisa de bom exemplo.

Vi mais três vezes Laura, na segunda semana de fevereiro, na segunda semana de março e na última semana de abril. Ela havia conseguido criar um espaço de comunicação entre ela e o filho, onde passou a legitimar as expressões verbais de medo, o que fez, inclusive, que ele retroagisse a situações passadas e que, no início timidamente, mas depois, de forma mais segura, relatasse o medo anteriormente vivido e até então inexpresso. Segundo seu relato, o sintoma começara a se tornar menos frequente já a partir de janeiro, ocorrendo, durante abril, apenas uma vez! O follow-up de um ano depois confirmou a regressão do sintoma de crônico para de raríssima ocorrência, agora aparecendo de forma sempre nitidamente associada a alguma situação externa compreensivelmente capaz de provocar medo. A mãe manteve um controle firme da situação, e o sintoma logo se remitiu por completo, mantendo-se assim quando de outro follow-up, realizado três anos depois.

Ora, se eu podia ensinar alguns indivíduos sem formação no tratamento da neurose a curarem certos sintomas dessa enfermidade, porque não poderia organizar, mediante uma literatura adequada, um imenso projeto psicossanitário que ensinasse um vastíssimo número de pessoas a fazê-lo?

A produção artificial de eventos

Mas, antes de passarmos da presença das memórias hiperestésicas em indivíduos para sua presença no coletivo, consideremos um sintoma neurótico

particularmente nocivo, produzido por essas memórias: a produção artificial de eventos⁴⁶, que, em Loganálise, assim definimos:

Produção Artificial de Evento ⇒ sintoma em que uma pessoa ou coletividade, contra sua vontade, é impelida a reproduzir, em sua realidade atual, experiências emocionais que não pôde, em seu passado, adequadamente verbalizar.

Exemplifico, por hora apenas na dimensão individual:

A Paciente das Duas e Dez:

Certa feita, após haver acabado de atender uma paciente, às duas horas, passei pela recepção de minha clínica e constatei que Rose, a paciente das duas e dez, já havia chegado. Cumprimentei-a e aproveitei os minutos de intervalo para dar dois telefonemas e tomar um cafezinho. Pontualmente às duas e dez, solicitei à recepcionista que fizesse a paciente subir para minha sala. Lá chegada, antes mesmo de acomodar-se, vociferou:

– Vocês, psicanalistas, não têm mesmo o menor respeito pelos outros, não é!?

Não entendi, não tugi e não mugi. Ela continuou:

– Você passa por mim, dá “bom dia”, sorrindo com essa cara de pastel, e sai para fazer suas coisas sem o menor cuidado de, pelo menos, dizer que vai me deixar esperando dez minutos!

Agora, eu entendi: Rose estava pensando que a sessão era às duas e, não, às duas e dez. Com efeito, aquela sua sessão já fora às duas horas, mas, havia duas ou três semanas, tinha sido transferida para dez minutos depois. E, nessas vezes a paciente já havia sido atendida em seu novo horário! Continuei a ouvir:

– Estou com o saco cheio de ser desrespeitada! Mas não vou mais permitir isso! Daqui por diante, quem me desrespeitar, leva!

E passou a me desancar com gosto e brio. De vez em quando, eu percebia que ela hesitava. Nesses casos, eu tecia um comentário qualquer, com intenção de liberar a sua fala. Do tipo:

⁴⁶ Este fenômeno é conhecido na literatura psicanalítica sob o nome de “compulsão à repetição”, mas vem associado a um tipo de explicação teórica da qual radicalmente discordo, de todo diversa da que ofereço aqui.

– Não está parecendo fácil falar sobre como eu não respeito você... Por quê? Você acha que eu não suporto ouvir isso?

Ela especulava sobre minha pergunta e prosseguia. Quando se cansou de falar mal de mim, partiu para o namorado, para a mãe e para quem mais entendia não tratá-la com o desejado respeito. Quarenta minutos depois estava claramente aliviada e parou, descansando – como vimos fazer Mônica – do esforço que lhe custara o desabafo. Subitamente, saiu de seu silêncio e exclamou, olhando pra mim com cara de indiscutível espanto:

– A sessão era às duas e dez!

Prosseguimos, a partir dali, à cata das memórias bloqueadas que a tinham levado a cometer tal distorção.

O ponto essencial aqui é que Rose distorcera inadvertidamente o horário da sessão para poder dar forma ao sentimento de ser desrespeitada, provindo de memórias hiperestésicas que, antes desse trecho de sua análise, ela não conseguia acessar. Acabou acessando essas memórias e parando de, em sua vida cotidiana, criar, concreta ou fantasiosamente, situações que lhe davam oportunidade de “conversar” com o fantasma do desrespeito. Outro exemplo de produção artificial de evento

Falência

Raquel tinha sido uma menina muito pobre. Sua personalidade combativa e circunstâncias favoráveis de vida, todavia, permitiram-lhe um nível de ascensão que poucos teriam previsto. Montara um comércio extremamente bem sucedido e, a partir daí, acumulara um patrimônio pessoal significativo, dispondo de grande conforto material. Procurou a análise por haver-se dado conta de que, chegada ao topo de sua trajetória profissional, começara a agir de forma a por em risco tudo o que havia construído. Na verdade, quando chegou a mim, já estava à beira de uma falência ou concordata e tinha clara consciência de ser ela mesma, mediante comportamentos que não conseguia controlar e por razões com que não atinava, a artífice da própria ruína. Os sonhos de Raquel e outros dados sobre que não me estenderei apontavam claramente para o fato de que ela não tinha tido, ao longo de sua vida, oportunidade de expressar verbalmente os sofrimentos experimentados nas condições de pobreza que enfrentara em sua infância, tendo ficado carregada de memórias hiperestésicas relativas a esse período. Ela queria desesperadamente falar da dor de ser pobre e, entendendo sua riqueza como obstáculo para isso, estava, “sem querer, querendo”, operando de forma a livrar-se dela...

Felizmente, consegui convencê-la de que tinha direito de falar sobre sensações de pobreza, “eutonizando”⁴⁷ as memórias hiperestésicas de sua infância, sem que para isso tivesse que produzir uma falência. Na medida em que essa eutonização foi ocorrendo, sua compulsão para criar artificialmente sua própria ruína financeira foi-se gradualmente esvaziando, confirmando minha hipótese de que seu comportamento não passava de uma tentativa inadvertida de criar as únicas condições que, em seu estreitado entender, lhe dariam o direito de falar das carências materiais que em seu passado enfrentara.

Quanto dos sofrimentos atuais da humanidade é mero resultado de tentativas artificiais de dar forma, no presente, a emoções vividas no passado e não suficientemente verbalizadas? Certamente uma quantidade de sofrimentos desnecessários que assusta imaginar...

Mas, antes de passarmos à segunda parte deste livro, vale lembrar que, em certo número de casos, a memória hiperestésica pertence a uma época tão remota de nossas vidas que não podem ser relembradas em sua forma original, só podendo ser emocionalmente revividas quando estimuladas por eventos pertencentes a um período mais avançado da vida de seu portador.

Claustrofobia:

Certa vez fui solicitado a fazer um atendimento de emergência a Oscar, empresário de outro estado que estava de passagem pelo Rio e que, segundo me disseram, estava sob impacto de forte angústia. No entanto, quando de nosso primeiro encontro, seu estado, mais do que de angústia, era de revolta.

– Doutor, não agüento mais! Desde que me conheço por gente, tenho pânico de lugares fechados, mas a coisa está chegando a um ponto insuportável! Acabei de fazer um papel, não só ridículo, mas que, provavelmente, me trará grave prejuízo financeiro. Vim ao Rio para fechar um negócio de grande valor financeiro para mim. Na reunião em que o contrato correspondente deveria ser assinado, começaram, de repente, a fechar todas as portas e janelas e logo se desencadeou em mim aquele infernal estado de pânico. Não tive coragem, na frente de todos os outros empresários – com quem negocio, mas que, na verdade, também são meus rivais – de dizer que eu estava me borrando de medo só porque estavam fechando portas e janelas! Reagi de forma totalmente desequilibrada: inventei – imagine! – que tinha esquecido meu filho na porta da escola e que tinha que sair imediatamente para resgatá-lo! E, frente ao espanto de todos, saí como um louco, sem dar ouvido aos protestos e impedindo que o negócio fosse fechado. Que vergonha! Mais cinco minutos e tudo teria sido resolvido. Não sei nem com que cara vou retomar as conversações, ou, mesmo, se vou conseguir retomá-las. E a coisa não fica só por aí. Para que o senhor veja o nível a que isso chegou,

⁴⁷ Cf. nota 37.

vou-lhe contar a mais surrealista de todas. Tem um anúncio de relógio na televisão em que um cara, num veleiro, em alto mar, todo preparado para mergulho, com aqueles tubos de oxigênio e o diabo mais, olha para o relógio – a idéia é mostrar que ele é à prova d’água – e mergulha de costas no oceano. Eu tenho que mudar de canal porque sou tomado pela sensação de que ele vai ficar sem ar! Estou ficando louco! Não agüento mais!

Esse relato e outros detalhes me fizeram suspeitar de uma causa não rara em casos como o dele:

- Você teve anóxia perinatal?*
- Que é isso?*
- Sofreu excesso de falta de ar no momento do parto? – indaguei.*
- Sei lá – retrucou – minha mãe nunca me falou sobre isso. Ela está no norte, mas é viva. Posso ligar para ela e saber.*
- Bem, pacientes que passaram por isso muitas vezes reagem com pânico a situações que, mesmo longinquamente, remetam à idéia de falta de ar. E é claro que ambientes fechados ativam esse tipo de idéia.*

Na sessão seguinte, Oscar já havia contatado sua mãe.

- Falei com minha mãe, doutor. Sabe o que ela disse? – e, frente à minha negativa, continuou – “É verdade, sim, meu filho. Você teve circular de cordão, nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço, roxinho, roxinho!” Pode?*

Pôde. E, embora o paciente tivesse que voltar para o seu Estado e assim não tivesse podido dar continuidade comigo a seu tratamento, todos os dados que me forneceu nas sessões em que ainda o atendi convenceram-me de que, realmente, a explicação de seus ataques de pânico estava em sua particular experiência de nascimento. Experiência cuja excessiva carga emocional só pode ser esvaziada em uma terapia que leve o paciente a reencontrar-se de maneira cuidadosamente dosada com a sensação de sufocação que o marcou fortemente quando de seu nascimento.

Acrescente-se o que todos já terão suspeitado: termos conseguido descobrir – leia-se, “interpretar” – corretamente a causa original da claustrofobia de Oscar em nada alterou sua frequência ou intensidade. E isso pelo simples e redondo fato de que explicação não cura!

Essas considerações nos permitem passar à segunda parte deste nosso livro.

SEGUNDA PARTE

O COLETIVO

Sintomas neuróticos coletivos

Se um sujeito está sob o disfuncional domínio de uma memória hiperestésica, dizemos que ele está “fixado” a essa memória. Também coletividades poderiam sofrer desse tipo de “fixação”?

Vejamos:

A estória do banquinho:

Este saboroso episódio foi-me relatado pelo pai de um amigo – acontecera com um amigo dele – e não tenho razão para supor que não seja verídico.

Um general à paisana passeia, numa bela tarde de domingo, pela orla do Rio. Passando por diante de não me lembra qual forte, resolve sentar-se em um banquinho, externo às muralhas daquele. E assim o faz. Decorridos poucos instantes, um sentinela deixa sua guarita e se aproxima, advertindo-o:

– O senhor não pode se sentar nesse banquinho!

Surpreso, o general se identifica e pergunta:

– Por quê?

– Não sei, general, mas o senhor não pode sentar nesse banquinho! – responde o soldado, prestando continência.

– Quem é o oficial-de-dia? – retruca o general. Quero falar com ele!

Incontinenti, o soldado foi chamá-lo. Chegado o oficial, repete-se a indagação.

– Gostaria de saber por que não posso me sentar nesse banquinho.

A resposta não se altera:

– Não sei – continência – general, mas nem o senhor nem ninguém podem sentar nesse banquinho!

– Quem é o comandante do forte? – desespera o general.

O comandante do forte era um ex-colega. O recém-chegado general vai até ele. Trocam cumprimentos:

– Fulano, há quanto tempo! O que tem havido de você? Blá, blá, blá, blá, blá, blá...

– É verdade! E de você, cara!? Blá, blá, blá, blá, blá, blá...

– Fulano, me explica uma coisa, pede o recém-chegado ao comandante..

– Diga.

– Por que não se pode sentar naquele banquinho em frente ao forte, logo perto da guarita.

– Não se pode?

– Não, não se pode. Achei estranho. Fora do forte. Domingo. Sem qualquer razão visível para existência de esquema especial de segurança...

– Ordenança! – brada o comandante – Traga-me o responsável pela ordem de que não se pode sentar no banquinho de fora do forte, próximo à guarita!

– Pois não, general!

Cinco minutos. Mais um cafezinho. Blá, blá, blá, blá... Chega o responsável, um sargento. Troca de continências.

– Sargento – brada o comandante – por que não se pode sentar naquele banquinho?!

A resposta merece participar de antologia:

– Desculpe, comandante, isso foi há três meses, quando eu mandei pintar o banquinho!...

A memória de uma ordem oculta para a vasta maioria dos membros daquela comunidade estava comandando um de seus comportamentos, um verdadeiro “sintoma neurótico coletivo”. Quando tempo duraria esse sintoma, não tivesse um general decidido contestá-lo? Anos, décadas, séculos? É o que acontece com comportamentos coletivos que já perderam seu sentido sem que se saiba que isso ocorreu.

Mui lamentavelmente, os efeitos de “fixações coletivas” são – e frequentemente – bem mais deletérios do que o descrito no exemplo acima. E, convenhamos, é tão impossível para os sujeitos lembrarem-se da origem do sintoma de que são vítimas quanto era para Oscar – e, nesse caso, será para sempre⁴⁸ – evocar em sua memória o momento em que nasceu.

A creche:

Após implementação de medidas inovadoras por um governo modernizante da Índia, certo repórter norte-americano deslocou-se para ali com intenção de avaliar in loco as consequências de tais medidas.

Uma delas era a de que todas as fábricas com mais do que certo número de funcionários ficavam obrigadas a incluir uma creche entre suas instalações. Inicialmente impressionado pela qualidade da creche que, na fábrica de uma

⁴⁸ Quem sabe a hipnose fosse capaz de trazer pelo menos parte dessa memória à tona? Uma abordagem loganalítica bem sucedida poderia até curar ou atenuar significativamente o sintoma, não trazer uma tal memória à tona.

pequena cidade, lhe apresentaram, nosso repórter deu-se subitamente conta de que algo estava errado: e as crianças?! Com efeito, na creche enorme, limpa, luzente, na verdade impecável, havia apenas duas crianças!

– Por quê? – pergunta a seu guia.

– Bem – foi a resposta constrangida – na verdade, embora haja falta de empregos, após a instalação dessas creches, quando grávidas, a maioria das operárias abandona o emprego.

– Mas por quê? – insiste o repórter.

– Bem – segue o guia, ainda constrangido – acontece que o povo daqui é muito fiel a costumes e tradições. E diz a tradição que, durante o primeiro ano de vida, a criança deve ficar vestida com restos da roupa mais velha e esfarrapada do pai e não tomar nenhum banho. Isso para protegê-la contra a inveja dos deuses, que, se vêem uma criança limpa, bonita e bem vestida, podem querer levá-la para si. Por isso, depois da instalação das creches, onde as crianças são forçadas a tomar banho e trocar de roupa, a maior parte das mulheres, mesmo antes de parir, abandona o trabalho.

Sem se dar conta de que estava fazendo uso do conceito de fixação, o repórter, em seu artigo, atribui a origem desse comportamento a épocas remotas, em que os membros da nobreza local, ao atravessar aldeias, vendo crianças vigorosas e bonitas, arrogavam-se o direito de as sequestrar. Manter as crianças sujas e maltrapilhas, em algum tempo do passado, tivera sentido: era, então, uma das maneiras empregadas para evitar tal sequestro. Uma fixação a esse fato, entretanto, após sofrer uma “redefinição” em termos religiosos – o medo dos nobres travestiu-se em medo dos deuses – fazia as operárias hindus, em pleno século XX, abandonarem preciosos empregos, para impedir que, em creches de uso obrigatório, seus filhos ficassem asseados e bem vestidos.

E as crianças, devidamente protegidas contra a ambição dos deuses, continuavam cruelmente entregues à impiedosa sanha dos micróbios...

Há pior. Há muito pior. Escapa-me agora a fonte, mas li algures que o cruel hábito da ablação do clitóris nas meninas de algumas tribos africanas tem sua origem remota também para evitar sequestros: sem clitóris elas deixavam de ser objeto de desejo para algumas tribos árabes que regularmente raptavam meninas africanas para recheiar seus haréns.

Pois bem, há sintomas neuróticos coletivos gerados por memórias hiperestésicas, essas, como fartamente vimos, produzidas pela ausência da expressão verbal de temas grandemente carregados de emoção.

Analisemos um exemplar desses sintomas neuróticos de natureza coletiva ocorrido nos primórdios da revolução comunista que explodiu na Rússia, no início do século XX.

O caso de Zarial Haliliva:

Que a Revolução Russa, após derrubar o czarismo, acabou por gestar uma das maiores e mais opressivas ditaduras de todos os tempos é de conhecimento geral. Entretanto – coisa por muitos desconhecida – as primeiras horas dessa revolução foram embaladas por concretas tentativas de implantação dos ideais de descentralização política, de respeito pelo individualismo, pela liberdade amorosa, pela independência da mulher etc..

Acompanhemos o relato que Reich⁴⁹ faz desse processo e vejamos como fixações coletivas, deixadas por séculos de ditadura czarista, ativamente contribuíram para o fracasso dessas tentativas.

Deposto Nicolau II, as leis implantadas pelos líderes revolucionários comunistas caracterizaram, num primeiro momento, enorme avanço cultural. No que diz respeito ao casamento, por exemplo:

“A dissolução do casamento compulsório, de acordo com a tendência geral do sistema soviético de simplificação da vida, ficou extremamente facilitada. Uma ligação sexual que ainda se chamava de “matrimonial” podia ser desfeita tão facilmente como tinha sido costurada. O que importava era o “livre arbítrio” dos parceiros. Nenhum podia obrigar o outro a uma relação que contradizia sua “espontânea vontade”. Assim pois, não era mais o Estado que decidia sobre a relação entre os parceiros, mas a livre deliberação de qualquer um deles. Tornava-se sem sentido exigir motivos para o divórcio. Quando um parceiro queria sair de uma comunhão sexual, não tinha que fundamentar isso. Matrimônio e divórcio tornaram-se assuntos inteiramente particulares e um “princípio de culpa” ou de “deterioração” tornava-se “completamente estranho” à lei soviética.”⁵⁰

As novas leis viam da seguinte forma a relação financeira pós-divórcio, agora passível de ser unilateralmente declarado, sem que, para isso, fosse necessária a anuência de qualquer autoridade externa aos cônjuges:

“A obrigação de pagar alimentos era, originalmente, considerada apenas “medida de transição”. Tal obrigação durava apenas seis meses depois da separação e valia somente no caso de o parceiro ser incapaz de trabalhar ou estar desempregado. ... Nos primeiros anos da revolução, essa obrigação apenas tinha a função de ajudar a superar as primeiras dificuldades, que estavam no caminho dos reais propósitos da ordem social em direção à independência pessoal e econômica completa.”⁵¹

Além do indivíduo em geral, o feminino, como assinalamos, foi também valorizado: permitia-se agora à mulher almejar a um nível de liberdade dantes

⁴⁹ Reich, W. A Revolução Sexual. Rio: Zahar, 1968, 185-311, **passim**.

⁵⁰ *Ib.*, p. 199.

⁵¹ *Ib.* p. 199

sequer sonhado... Vejamos as imensas alterações trazidas, em seu início, pela revolução:

“Bacu pertencia a uma das fortalezas mais reacionárias e tenebrosas do império russo. ... É verdade que as leis tinham sido modificadas pela revolução, a base econômica tinha sido reconstruída, a religião tinha-se tornado assunto particular de cada um, mas ‘sob os tetos erigidos de novo, perdurava a velha disciplina cruel do harém’ ... As meninas eram enviadas a instituições religiosas; era-lhes proibido aprender a ler e a escrever: uma não-analfabeta poderia, por meio de cartas, comunicar-se com o mundo exterior, fugir de casa e trazer desonra para a família. As moças eram servas do pai. Na maturidade sexual, tornavam-se servas do marido, que elas mesmas não podiam escolher e que antes do casamento jamais haviam visto. Mulheres e moças não podiam mostrar o rosto a homem algum. Cobertas de véu e envoltas em vestes, olhavam a rua pelas janelas e só podiam ir a qualquer lugar fortemente vigiadas; não podiam realizar qualquer trabalho, tampouco ler um livro ou um jornal; se bem que tivessem o direito de se divorciar, praticamente, não o podiam fazer; se bem que a chibata tivesse desaparecido das penitenciárias, no harém, as mulheres eram flageladas. Essas mulheres tinham que realizar o parto sozinhas, pois não existiam parteiras e médicas e elas eram proibidas pela religião de se mostrar a um médico do sexo masculino.”(grifo meu)⁵²

Então, ao abrigo das novas leis trazidas pela Revolução:

“em meados da década de 1920, as mulheres russas fundaram um clube feminino central, que organizou a educação. Pouco a pouco, a instrução se alastrou: as salas de aula se enchiam cada vez mais e as moças escutavam os professores encanecidos ... O movimento sexual-político se espalhava.”⁵³

Entretanto, o banho inicial de liberdade em que as novas leis mergulharam o povo em geral e a mulher em particular chocou-se desastrosamente com fixações coletivas reinantes, dispostas a, em nome de uma ordem dispensável, destruir uma liberdade já legalmente possível:

“Os pais de família, os irmãos e maridos se sentiam ameaçados em seus interesses quando escutavam o que estava sendo propalado no clube feminino. Espalharam o boato de que ... era um prostíbulo; tornou-se por conseguinte perigoso para as mulheres visitá-lo. ... acontecia que se jogava água fervente sobre as moças que iam para o clube, ataçavam-se cachorros contra elas e ainda mais: em 1923, a moça era ameaçada de morte se aparecesse em público ou usasse um traje esportivo que deixasse à mostra pernas e braços; dessa forma, é

⁵² *Ib.* p. 250. O recente domínio talibã no Afeganistão deu sólida demonstração de que, quase um século depois, esse modelo ainda sobrevive.

⁵³ *Ib.* p. 250.

compreensível que o pensamento de uma união amorosa sem casamento estava longe mesmo das mulheres mais corajosas.”⁵⁴

O caso de Zarial Haliliva, em particular, mostra os extremos a que essas fixações de natureza coletiva são capazes de levar:

“No ano de 1928, Zarial Haliliva, de vinte anos, fugiu da casa dos pais e começou a convocar reuniões a fim de conseguir a emancipação sexual das mulheres; ia ao teatro sem véu e, em jornais murais dos clubes, apelava para as mulheres; ia à praia em traje de banho e a campos esportivos.

Seu pai e seus irmãos realizaram um julgamento sobre ela e condenaram-na à morte. Foi cortada em pedaços viva. Isso foi em 1928, onze anos depois do início da revolução social na Rússia.”(grifo meu)⁵⁵

Assim, os avançados ideais de liberdade que inspiraram as primeiras horas da Revolução Bolchevique foram aos poucos sendo substituídos por uma das mais cruéis ditaduras de que se têm notícia: fixado ao espírito autoritário com que o czarismo o cevara, o povo russo mais facilmente absorveria Stalin, grotesca reencarnação do czar, do que Haliliva e a nova ordem que ela representava.

O sintoma neurótico coletivo seguinte, mais próximo de nós, não será apenas relatado, será comentado. É sintoma de repetida e assustadora ocorrência nos EUA e tornou-se razão de assombro para todo nosso planeta. Nesses comentários, vou enfocar não só os efeitos extremamente destrutivos de uma determinada memória hiperestésica, como também a forma por meio da qual ela é cotidianamente realimentada no ambiente cultural daquele país.

Eric e Dylan

Dylan Klebold e Eric Harris, de 17 e 18 anos respectivamente, pertenciam a famílias americanas de classe média alta. Moravam em típicos casarões americanos (a família de Dylan tinha sete carros) e estudavam em uma das melhores escolas do Estado do Colorado, na pequena cidade de Littleton, lugar pacato a poucos quilômetros de Denver, cidade grande com todas as facilidades que as grandes cidades podem oferecer. Não usavam drogas. Eram filhos de casais estáveis, tendo irmãos sem registro de problemas. O pai de um era geólogo, o de outro, piloto condecorado da Força Aérea. Na escola, Eric e Dylan não apresentavam grau de beleza física e de desempenho atlético ou acadêmico que os destacasse de uma maioria mediana e sem cor. Vez ou outra, eram brindados por colegas com a ofensa tipicamente americana de “losers” (perdedores), que os deixava, sem dúvida, ressentidos. Certo dia, armados de pistola, fuzil automático, espingardas de caça e bombas de feitura caseira,

⁵⁴ *Ib.* p. 250-1.

⁵⁵ *Ib.* p. 251.

assassinaram treze das dezenas de pessoas que se sitiaram na biblioteca da escola em que estudavam, suicidando-se depois.

Dentre as inúmeras reportagens publicadas sobre a matéria, nossos comentários alimentam-se basicamente de uma, que tem por título “Como é possível?”⁵⁶ e que começa com as seguintes palavras:

“Alguma coisa muito errada, maligna, se esconde nas entranhas da sociedade americana. Quando vem à tona, todo o mundo se pergunta como é possível que horrores assim ocorram num país democrático, rico e poderoso como os Estados Unidos.”

Esse país, segue a reportagem, assombra o mundo com seu infundável

“rol de explosões periódicas de insanidade... Volta e meia, malucos saem atirando contra multidões ... Não se encontra, em outros países ... nada similar em termos de explosão gratuita de violência assassina.”

Muito bem, aqui está o sintoma neurótico cultural que pretendemos analisar: as repetidas “explosões periódicas de insanidade” em que “malucos saem atirando contra multidões”, tingindo o paraíso americano, de maneira lamentavelmente freqüente, com tristes poças de sangue.

Note-se que os autores desse gênero de homicídio não visam a qualquer tipo de ganho objetivo e, mais do que isso, nem sequer tentam escapar incólumes após cometê-los. Via de regra, agem à luz do dia e, cumprido o feito, regularmente se entregam às autoridades ou, como Eric e Dylan, cometem suicídio. Tais massacres, além disso, são por demais indiscriminados para que possam ser entendidos como vendetas estritamente pessoais. Frequentes vezes, o assassino simplesmente adentra uma loja ou sobe em uma torre e, feito isso, atira a esmo sobre vítimas que nem sequer conhece. Mesmo em um caso como o de Eric e Dylan, embora cometida contra os membros de uma comunidade a que pertenciam e onde sofriam seus males, a chacina foi por demais inespecífica para poder ser considerada como tendo sido levada a cabo contra pessoas determinadas. Acrescente-se, finalmente, que tais crimes são habitualmente cometidos por um grupo que, do ponto de vista material, têm muito a perder: 71% das ocorrências desse tipo são obra de brancos de classe média, enquanto, em crimes comuns, apenas 36% dos autores – a metade! – pertencem a esse grupo.

“Todo o mundo se pergunta como é possível que horrores assim ocorram num país democrático, rico e poderoso como os Estados Unidos. ... Dylan Klebold e Eric Harris ... pertenciam a famílias americanas de classe média alta. Moravam em típicos casarões americanos ... e estudavam em uma das melhores escolas do

⁵⁶ VEJA, ano 32, número 17, 28 de abril de 1999. O episódio também foi objeto do documentário “Tiros em Columbine” (“Bowling for Columbine”), dirigido por Michel Moore.

Estado de Colorado ... Não usavam drogas. Eram filhos de casais estáveis, tendo irmãos sem registro de problemas. ... Como é possível?”⁵⁷

O senso-comum, “compreende” um comportamento quando nele reconhece um pragmatismo, uma funcionalidade. Qual o pragmatismo ou funcionalidade dos sintomas neuróticos dos pacientes – como, por exemplo, Pedro⁵⁸ e Severino⁵⁹ – cujos casos relatamos acima? Eram todos *flagrantemente disfuncionais*. Eram meros derivados de palavras que não puderam ser ditas e que “falavam” por meio de seus sintomas. E, pois bem, qual a grande fobia verbal do cidadão dos EUA? Já o sugerimos: é considerar-se ou ser considerado um “*loser*”, um perdedor.

Repassemos: Eric e Dylan não apresentavam grau de beleza física e de desempenho atlético ou acadêmico que os destacasse dentre seus pares, o que, sem dúvida, os ressentia. Ouçamos o comentário que, defrontado com o episódio, fez o então presidente Clinton.

“Há um grande número de outros garotos por aí que estão acumulando ressentimentos dentro de si e fora de nosso alcance.”⁶⁰

Comentário a que um articulista replicou “*Ou seja, vai ocorrer de novo!*”. E, com efeito, pouco depois, noticiou-se similar massacre⁶¹. A reportagem começa assim: “*Ocorreu de novo...*”

Mas, um momento! “*Sentir ressentimento*” é algo bastante diverso de “*acumular ressentimentos*”. Experiências desagradáveis, por maiores que sejam, se possuem adequado acesso ao nível da palavra, não se transformam em memórias hiperestésicas, dando origem a sintomas neuróticos. Com esse livre acesso à palavra dificultado, quaisquer experiências, por menores que sejam, passam por um processo de acumulação, formando um enorme reservatório daquelas memórias, com a plethora de sintomas neuróticos que lhes faz séquito. Uma memória, seja agradável ou desagradável, associada a uma dose palatável de emoção orienta o sujeito, tornando-o capaz de, quando essa memória é ativada, manter seu comportamento suficientemente racional e organizado para poder agir de forma a otimizar a relação entre os custos e benefícios da situação com que se defronta; memórias hiperestésicas, ao serem ativadas, paralisam o sujeito ou nele provocam tal desorganização psicológica que ele não só se mostra incapaz de minimizar os custos de suas ações, como, muita vez, age de forma a aumentá-los. Isso sem contar com a produção de sintomas como ataques de tosse, enurese noturna etc.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Pág. 33.

⁵⁹ Pág. 40.

⁶⁰ VEJA, ano 32, número 17, 28 de abril de 1999.

⁶¹ O último episódio dessa natureza, depois de inúmeros outros que se seguiram ao massacre de Columbine, ocorreu em 08/11/2018,: “*Um veterano dos fuzileiros navais vestido de preto e armado com uma pistola Glock calibre 45 disparou para um bar lotado de estudantes universitários em Thousand Oaks, Califórnia, ... antes de voltar a arma contra si próprio*”, disseram autoridades na quinta-feira. Quando acabou, outras 12 pessoas, incluindo um policial que tentou impedir a carnificina, também estavam mortas e muitas outras ficaram feridas”. (NBC News Alert). Mais uma vez, ninguém entendeu nada...

Embora Eric e Dylan tivessem, em sua escola, razões para ressentimento – já referi que, vez ou outra, eram chamados de losers – fica evidente, frente ao nível de perturbação e de irracionalidade do comportamento de ambos, que tais ressentimentos não se estabilizaram como memórias meramente desagradáveis. Ultrapassaram esse nível, acumulando-se sob forma de memórias hiperestésicas. E, para isso, é necessário que ambos tenham sido vítimas de interdição da expressão verbal de seus sentimentos de “perdedores”.⁶²

Tentemos entender um pouco melhor a ação das memórias hiperestésicas de ressentimento na mente de Eric e Dylan:

Podem estar presentes, em meu organismo, bacilos de Koch – causa específica da tuberculose – sem que eu fique tuberculoso, mas é impossível eu ficar tuberculoso sem que, em meu organismo, haja bacilos de Koch. Uma pessoa leiga pode perfeitamente dizer que alguém ficou tuberculoso porque passou frio e fome na prisão. Um profissional competente não fará isso. Dirá que o frio e a fome que ela passou na prisão são meros desencadeantes, baixaram sua imunidade e, a partir daí, abriu-se espaço para ação daqueles bacilos, sem os quais, o frio ou a fome podem matar uma pessoa de frio, ou de fome, ou de pneumonia, ou de gripe, ou do que mais seja, mas não, de tuberculose.

Um leigo pode dizer que o ressentimento de Eric e Dylan levou-os a assassinar treze pessoas. Um psicólogo competente não faria isso. Diria que, para que um efeito dessa ordem se produza, além do ressentimento, cumpre estar presente maciça fobia da expressão verbal de tal emoção; cumpre que, além de haverem experimentado ressentimento, esses meninos se tenham sentido profundamente rejeitados quando tentaram falar sobre essa emoção, ficando progressivamente mais e mais vulneráveis a serem por ela perturbados.

Desejar ser rico é algo bastante diverso da compulsão de o ser. Tal compulsão não meramente revela uma natural atração pela riqueza, revela fobia de ser pobre. Analogamente, a compulsão pelo sucesso não indica natural atração por ele: revela fobia de fracasso. A fobia do fracasso – não a banalidade de que ele é menos desejável do que o sucesso – é um traço típico da cultura estadunidense que, conseqüentemente, coage seus membros a serem bem sucedidos⁶³. E, entendendo essa cultura que ser infeliz é o maior de todos os fracassos, tal processo deságua, na prática cotidiana, na obrigação generalizada de se estar permanentemente bem. Isso produz, entre os americanos, amplíssimo bloqueio – orquestrado pela ali difundidíssima, dentro e fora dos contextos

⁶² Sou brasileiro e a maior fobia, sem evidentemente merecer tanta atenção na mídia como a dos estadunidenses, que reconheço em meus compatriotas é a de serem considerados “otários”, o que os leva a comportamentos totalmente disfuncionais tentando provar que são espertos. Suspeito que essa “neurose coletiva” tenha origem no fato de que, até onde sei, é o único país colonizado, para o qual se deslocou a sede da metrópole portuguesa: nós fomos “enrolados” e “corrompidos”, em vez de dominados pela força.

⁶³ Análise similar merece a cultura japonesa. A fobia de fracasso está ali tão presente quanto na cultura americana, mas, enquanto a extroversão característica dessa última faz aquela fobia desembocar em mass murdering, a introversão japonesa interage com ela produzindo uma assustadora incidência de suicídios, mormente entre adolescentes e crianças. Mas, afinal, o mote “*Why get an ulcer, if you can give them?*” (“Por que contrair uma úlcera, se você pode provocá-la nos outros?”) tem origem nos EUA, não no Japão, certo?

profissionais, *Psicologia do Pensamento Positivo, uma verdadeira Psicologia do Faz-de-Conta* – da indispensável representação verbal dos sentimentos penosos, que passam a ser acumulados sob a forma de memórias hiperestésicas, com sua macabra capacidade de produzir sintomas neuróticos. Esse ambiente de todo refratário a um adequado processamento do desprazer fica linda e tristemente ilustrado por uma canção perenizada pela voz de Cole:

*“Pretend you’re happy when you’re blue:
It isn’t very hard to do.”*

*(“Finja que você está alegre, quando você está triste.
Não é muito difícil fazê-lo”)*

Realmente, não é difícil. É estúpido. A denúncia dessa transcendental estupidez tem momentos culminantes, na literatura ocidental. No século XVIII, foi sarcasticamente vituperada por Voltaire, em seu *“Candide”*.

Um século depois, Nietzsche tonitroou virulentamente contra ela:

*“Considerar estados emocionais penosos como algo a ser abolido é o ápice da tolice.”*⁶⁴

Menos de cem anos depois, o descalabro da obrigação de estar o tempo todo feliz foi, como anteriormente lembrei, contundentemente descrito em *“O Admirável Mundo Novo”*, de Aldous Huxley, e replicado no *“1984”*, de George Orwell.

Mas os cidadãos dos EUA não parecem ter lido – ou, se o fizeram, não os levaram a sério – Orwell, Huxley, Nietzsche, Freud, Terêncio⁶⁵ ou Voltaire. Leram e tomaram a peito o lamentável Napoleon Hill.

Com efeito, em 1937, Hill, um fracassado crônico que só conseguiu escapular de seus fracassos aconselhando os outros a fingir que estavam bem, publicou seu *“Pense e Enriqueça”*, inaugurando – para aproveitar uma expressão de Mainardi⁶⁶ – a “picaretagem macroscópica” da *Pretending Psychology*, a *Psicologia do Faz-de-Conta*!

Propõe ali, como fórmula infalível do bem-estar, do sucesso e do crescimento pessoal, que bloqueemos acesso à nossa consciência de estados como a tristeza, o desânimo, a angústia etc., considerados “negativos”, e que, simultaneamente, façamos um trabalho de auto-indução de estados como o otimismo, a alegria, a confiança etc., considerados “positivos”. Em resumo, propõe a seu público que se transforme em uma imensa legião de *Candides*, parvos discípulos de Pangloss, o filósofo do otimismo

⁶⁴ NIETZSCHE, F.. **Op. cit.**, p. 129.

⁶⁵ Autor da máxima “sou humano, nada do que é humano me é alheio” (“Homo sum, humani nihil alienum a me puto”, *Heauton Timorumenos*, a. I, sc. I, v. 25).

⁶⁶ MAINARDI, D.. “Império do Plágio”, in: *Veja*, 20 de novembro de 1996.

incondicional ridicularizado por Voltaire. Em outras palavras, que se transformem em uma multidão de “bobos alegres”!⁶⁷

E quando um desses *Candides*, cansado de dizer todo o tempo que tudo está “ok”, empunha uma arma e sai indiscriminadamente matando pessoas que mal conhecem ou totalmente desconhecem, expressando mediante ações os ressentimentos que não pode expressar por meio de palavras, a *Pretending Psychology*, a *Psicologia do Faz-de-Conta*, obviamente, não entende nada!.

Com o bloqueio da verbalização da dor permeando o dia-a-dia de toda a sociedade estadunidense, em nada admira a quem conhece os efeitos desses bloqueios que mesmo minúsculas frustrações, quando acumuladas, se transformem em montanhas de ressentimento e que essas, com triste frequência, desemboquem em explosões de ódio totalmente irracionais.

Se, como diz Nietzsche, considerar estados emocionais penosos como algo a ser abolido é o ápice da tolice, os EUA emprestaram a essa tolice dimensões macroscópicas!

Theodore Zeldin⁶⁸ tinha provavelmente, nos bastidores de seu pensamento, o temor de que essa característica, tipicamente estadunidense, se transformasse em uma doença global, quando sagazmente assinalou:

*“Hoje, a revolução de que precisamos está no modo como falamos do fracasso.”*⁶⁹

Na verdade, o comentário de Clinton –

“Há um grande número de outros garotos por aí que estão acumulando ressentimentos dentro de si e fora de nosso alcance.”

– ao lado de seu acerto, ao apontar o acúmulo de ressentimentos, contém um grande erro: afirmar que esse “grande número de outros garotos” está “fora de nosso alcance”.

Com efeito, não são esses garotos que estão fora do alcance da cultura dos EUA, é a cultura dos EUA que está fora do alcance desses garotos, que, repetidas vezes, devem ter tentado inutilmente fazer-se escutar por ela. Quantas vezes terão Eric e Dylan tentado dizer que havia algo errado? Quantas vezes terão tentado dizer que sofriam por ser considerados *losers* e tiveram tal sentimento considerado inaceitável? Quantas vezes tiveram seu desejo de falar frustrado, defrontados pelo estúpido comentário de que, sendo eles membros da alta classe média do país mais poderoso do mundo, tudo estava

⁶⁷ O que torna os cidadãos dos EUA freqüentes vítimas de maldosa chacota universal. Os londrinos, por exemplo, quando o Reino Unido decidiu-se a melhor selecionar a entrada de imigrantes no país, fizeram correr a piada de que os estadunidenses não seriam submetidos a nenhum tipo de filtragem migratória, contanto que só saíssem à rua acompanhados de um adulto!

⁶⁸ O fino pensador de origem israelita, radicado na Inglaterra, professor em Oxford.

⁶⁹ Zeldin, T.. **Op. cit.**, p. 111.

necessariamente “ok”? Quantos, como Eric e Dylan, munem-se de armas e saem atirando a esmo, tentando, simplesmente, dizer com atos o que se lhes não permite dizer com palavras: que há algo errado, que nem tudo está “ok”, que, a despeito de toda a riqueza e abundância, as pessoas têm o direito de verbalizar seus sofrimentos, de não se mostrar o tempo todo felizes, de incondicionalmente expressar em palavras não importa que dor os aflija?!

Que tais explosões de violência não passam de desesperadas e veementes expressões não verbais de protesto contra toda uma coletividade que, com uma mão, dá coisas e, com outra, tira palavras, é mais do que evidente: ao atirarem a esmo, esses criminosos não têm o propósito de matar pessoas – que, o mais das vezes, nem conhecem – têm o propósito de matar a surdez que assola a cultura em que vivem. Como sinalizamos, são brancos de classe média, não os menos privilegiados, que perpetram crimes como os de Eric e Dylan. Para a Loganálise, a maior parte dos cidadãos estadunidenses está starving in the plenty, morrendo de fome em meio à abundância. Rica em coisas, está faminta de palavras!

A *Psicologia do Pensamento Positivo* é uma das principais responsáveis por outro sintoma de que gravemente padece a cultura americana: **a drogadição**. Como fazer de conta, mesmo sendo cidadão privilegiado da mais rica nação do mundo, que, durante todo o tempo, tudo está “ok”? A partir do momento em que o primarismo auto e hetero-hipnótico da *Psicologia do Faz-de-Conta* começa a falhar – o que, cedo ou tarde, sempre acaba por acontecer – a etapa seguinte é o consumismo compulsivo de, não necessariamente nessa ordem, mercadorias em geral, de comida (a taxa de obesidade dos americanos, como se sabe, já se tornou alarmante), de álcool, de maconha, de *crack*, de psicotrópicos legais (como o Prozac⁷⁰) e, certamente, de cocaína, que tem mais de 40% de sua produção devorada pelos americanos, que perfazem menos de 5% da população mundial! Qual o remédio para isso?

A maneira mais eficaz de combate a um vírus é a vacinação. As memórias hiperestésicas são o agente viral da neurose. A população dos EUA precisa ser imunizada contra sua enorme vulnerabilidade ao sentimento de fracasso, algo precioso em tempos de guerra e catastrófico em tempos de paz, podendo mesmo provocar o retorno daquela. Centrar o combate à drogadição e aos assassinatos em massa na destruição da máfia dos produtores de drogas e na redução da venda de armamentos é estratégia impotente e ingênua. Cada dólar empregado na redução dessa incapacidade de lidar com a sensação de fracasso teria um retorno incomensuravelmente maior do que os empregados no combate aos que vendem armas ou *crack*. E a única maneira de reduzir essa incapacidade é fazer que os estadunidenses não mais se sintam coagidos pela jurássica *Psicologia do Faz-de-Conta* a estar artificial e permanentemente “ok”, nisso guiados pela mão de psicoterapeutas (os *shrinks*, que encolhem a fala em vez de ampliá-la), de seus cantores, de seus cineastas e de uma literatura de auto-ajuda acriticamente inspirada em Napoleon Hill.

⁷⁰ Clone do Soma, pílula que, em *O Admirável Mundo Novo*, o Estado distribui gratuitamente para manter a população crônica e estupidamente feliz.

O quadro descrito traz consigo um problema adicional: neurose pega. Os Estados Unidos exportam maciçamente cultura. Se encontrarem mercado, como já encontram, para seus péssimos hábitos verbais, vão exportar juntamente com eles “explosões periódicas de insanidade assassina” e drogadição. Tal exportação já está em curso: dezesseis crianças mortas em uma escola da Escócia, em 1996; 35 turistas, na Austrália, no mesmo ano; oito vítimas (três mortos e cinco feridos) de um fuzilamento em um shopping de São Paulo, em 1999, e apenas oito porque o atirador, estudante de medicina de 24 anos, não soube passar sua submetralhadora Cobray M-11/9, capaz de disparar 960 balas por minuto, do modo intermitente para o modo automático!

Fica, então, a pergunta: há cura para sintomas neuróticos coletivos como vimos fartamente haver para sintomas neuróticos individuais? Sem dúvida e isso é assunto para a Terceira Parte deste nosso livro.

TERCEIRA PARTE

A NOVA CONVERSA

Exequibilidade

Todo desaparecimento ou significativa redução de sintomas relatados nas duas partes anteriores deste livro ocorreram em virtude da aplicação do que chamamos de estratégia de ampliação da fala, implementada pela técnica loganalítica, desenvolvida por mim. O grande avanço proporcionado por essa técnica foi descobrir ser ela suficientemente simples para que uma espantosa quantidade de pessoas sem formação profissional no campo da saúde mental seja capaz de, em seu cotidiano, fazer uso dela para, sem interferência direta de um especialista, fazer desaparecer sintomas neuróticos nelas mesmas e em pessoas de sua relações.

Mas, até aqui, apenas ilustramos, ilustramos, ilustramos... Não sistematizamos nada. Mas fica a pergunta: a mera divulgação, por meio de um livro, de uma mera sistematização, é capaz de levar não profissionais a aplicar essa técnica de forma eficaz? Como disse, este livro é uma versão mais acessível de meu livro *A NOVA CONVERSA*, publicado em 2004. Vejam a reação (que chegou a mim via e-mail) de uma leitora desse livro anterior:

"MENSAGEM: OBRIGADA!

Muito, muito obrigada mesmo.

O seu livro mudou nossas vidas.

A sensação é como a de quando se pensa que se enxerga bem e alguém lhe dá um par de óculos perfeito para você.

E eu nunca havia imaginado o quanto melhor poderia ser!

Já me tinha feito bem apenas eu mesma ler o seu livro, mas, daí, emprestei-o para meu marido e... que dádiva!

Sempre fomos muito íntimos, muito ligados, mas hoje a conexão que vivenciamos é ainda mais cúmplice e deliciosa. Nos reapaixonamos!

E nossos torcicolos crônicos misteriosamente (ou não) desapareceram. Mágica!

Meu marido pediu que eu o incluísse neste agradecimento.

Então..., mais uma vez, obrigada!

Estamos fazendo o possível para "spread the word".

Um grande abraço,

Letícia.⁷¹

Tive vários outros retornos confirmando a eficácia da letra escrita para transformar leigos em agentes de saúde mental. Obviamente, a mera compreensão da técnica, como ocorre com qualquer outra *expertise* não implica perícia em aplicá-la, portanto, quando organizo grupos para ensinar o uso da técnica, faço-o em módulos, quais sejam:

(I) Módulo Expositivo

(II) Módulo Ilustrativo

⁷¹ Embora tenha sido autorizado a fazê-lo, preferi declinar apenas o primeiro nome da autora.

(III) Módulos Interativos

(A) Verbal

(B) Global

Nenhum módulo obriga à participação no módulo seguinte, mas, a partir do segundo, todo o módulo tem o anterior – de que se pode participar mais de uma vez – como pré-requisito.

O módulo expositivo é ministrado sob forma de palestras, seguidas de debates. O número de participantes não importa. Já ministrei este módulo a cinco pessoas e a mais de cem. Nele são definidos e ilustrados – num período organizado sob a forma de maratona ou distribuído ao longo de vários dias – os conceitos e princípios essenciais da uma nova maneira de dialogar, que chamei de Nova Conversa.

No segundo módulo ilustrativo, não trabalhei, até hoje, com mais de quinze participantes. Este módulo consta de, pelo menos, oito encontros de uma hora e meia distribuídos ao longo de um período cuja duração é variável. Consiste basicamente em os participantes trazerem para consideração do grupo episódios de sua vida cotidiana em que experimentam dificuldades de comunicação, para avaliarmos o quanto o aprendido no módulo anterior poderia contribuir para a solução dessas dificuldades.

Não me parece que o terceiro módulo, interativo-verbal, possa ser realizado com proveito com mais de oito, talvez dez, participantes. Mais uma vez, consta de, pelo menos, oito encontros de uma hora e meia distribuídos de maneira variável. Consiste na proposição de temas – sexo, preconceito, morte, casamento, filhos, aborto, eutanásia, etc. – para, em torno deles, os participantes exercitarem entre si a Nova Conversa. O objetivo, naturalmente, não é chegar a conclusões sobre esses temas, mas, simplesmente, o de usá-los para testar o quanto cada um dos participantes está conseguindo sucesso no emprego das regras de comunicação expostas e aprendidas nos módulos anteriores.

Ao último módulo, interativo-global, só são admitidos os que já demonstraram, em sua participação nos módulos anteriores, razoável competência no emprego da Nova Conversa. Neste módulo, um grupo – nunca até hoje com mais de vinte participantes – passa um período de até uma semana, convivendo, em lugar isolado, segundo regras de convívio idealizadas para favorecer o exercício da própria individualidade e o respeito pela da dos demais. Ao fim de cada dia, realizam-se encontros grupais – à maneira dos realizados no módulo anterior, interativo-verbal – em que os participantes verbalizam como estão experimentando o impacto daquelas novas regras de convívio sobre sua maneira de ser. Problemas requerendo maior elaboração são encaminhados para trabalho individual.

Obviamente, nestas páginas, só podemos tentar transmitir o que há de essencial no módulo expositivo.

Vamos a isso.

A Lei

Eis, sumariada, a lei empírica descoberta por Breuer e desenvolvida por Freud, lei que, em mais de cinquenta anos de prática clínica, já vi deixar de cumprir-se (as “distímias” mencionadas no quadro abaixo são, essencialmente, ansiedade, irritabilidade e depressão),

**DETALHADA AMPLIAÇÃO DA FALA EMOCIONAL => AMPLIAÇÃO DA
RESPIRAÇÃO => REDUÇÃO DO NÍVEL DE DISTÍMIAS
=> DISSOLUÇÃO DE OUTROS SINTOMAS
NEURÓTICOS.**

A qualquer linguagem que, como a loganalítica, promova a ampliação da fala emocional, com conseqüente dissolução de sintomas neuróticos, chamarei eventualmente de linguagem de reparação e ela nada faz além de aplicar na prática a lei empírica acima enunciada. Mas há, evidentemente, detalhes a serem considerados.

Verbalização Emocional Detalhadamente Referenciada

Comparemos estas duas falas:

“Você nunca me amou!”

E

“Eu fiquei muito ressentido quando, ontem, naquele coquetel, você não me apresentou a seu ex-marido!”

A frase “Você nunca me amou” pode ser proferida em tom grandemente carregado de emoção, aos berros até, mas nenhuma emoção da pessoa que fala está nela enunciada. Anote-se que:

Esse tipo de fala pode servir para tudo, menos para dissolver memórias hiperestésicas e os sintomas neuróticos delas derivados.

Já a segunda forma de falar, tenha ou não relevantes efeitos sobre o comportamento dos demais, tem o efeito de, com seu uso cotidiano, ir gradualmente dissolvendo memórias emocionais hiperestésicas⁷². As diferenças fundamentais entre ambas? Na segunda forma de falar,

(1) o “eu” de quem fala

(2) a emoção por ele experimentada e

⁷² Em nosso exemplo, de ressentimento, embora seja aplicável a quaisquer outras, agradáveis ou desagradáveis.

(3) as circunstâncias associadas a tal emoção

Estão claramente enunciados; na primeira forma – “*Você nunca me amou!*” – nenhum desses três elementos é explicitado.

Respiração, Distímias e Inteligência

Basta darmos atenção ao fato de que “ventilar um assunto” significa trocar ideias, em palavras, sobre ele; que uma pessoa de mente “arejada” é pessoa que permite que as mais variadas ideias tenham lugar em sua fala; que alguém “inspirado” consegue dar forma a conteúdos mentais de qualidade superior; e que “aventar” uma hipótese e “inventar” uma solução é resultado termos posto um pouco mais de “vento”, de ar, dentro das nossas cabeças, para suspeitarmos que existe uma profunda relação entre a inteligência e o nível de oxigenação da mente.⁷³

Com efeito, logo no início de minha prática terapêutica, intrigou-me a questão de por que o *insight*⁷⁴ trazia consigo inevitável sensação de alívio. Não custei a descobrir. Àquela época, eu atendia meus pacientes deitados no divã, ficando eu sentado atrás deles, posição particularmente privilegiada para perceber que, a despeito de ter um conteúdo agradável ou desagradável, todo o *insight* era invariavelmente seguido de uma alteração do ritmo respiratório, que, de apressado, superficial e curto, tornava-se lento, longo e profundo, com consequente sensação de alívio, de serenidade e de paz. Isso, sem contar, naturalmente, com a gradual dissolução de uma variedade de outros sintomas.

Muito bem. Então, se “ventilamos” devidamente o que sentimos, falando ampla, detalhada e livremente sobre nossas emoções, nos tornamos menos distímicos e mais inteligentes e se, ao contrário, nos dedicamos regularmente a impedir que os demais e nós mesmos expressemos nossas emoções (especialmente aquelas consideradas a priori “negativas” pela, esta sim, maligna *Psicologia do Pensamento Positivo*), estamos plantando as sementes de uma humanidade emocionalmente perturbada e intelectualmente estúpida.

A esse respeito, o seguinte episódio é imperdível:

Quando eu ficar adulta...

Foi-me relatado que a filha – de três anos! – de uma amiga, extremamente inteligente e por todos assim considerada, chamou a mãe e, com uma expressão algo apreensiva, iniciou o seguinte diálogo:

⁷³ Aliás, algumas formas de retardo mental são devidas à insuficiência de oxigenação do cérebro quando do nascimento e há experimentos que reduzem o nível de retardo empregando técnicas de hiperventilação.

⁷⁴ A súbita percepção, anteriormente negada, da relação entre fenômenos; a forma portuguesa “insite” não “pegou”.

FILHA: – *Mamãe, preciso lhe dizer uma coisa!*

MÃE: – *Diga, minha filha.*

FILHA: – *Quero lhe avisar que, quando eu crescer, eu vou ficar burra.*

MÃE (chocada): – *Não, minha filha, o que é isso! Você nunca vai ficar burra! (e sai apressadamente do aposento em o diálogo se travara).*

A filha leva algum tempo concentrada, pensando, e, inconformada, chama de novo a mãe.

MÃE: – *.Que é, minha filha?*

FILHA: – *.Mãe, deixa eu lhe explicar porque eu disse aquilo.*

MÃE: – *.Diz, filha.*

FILHA: – *.Porque criança é inteligente, gente grande é burra. Como eu vou crescer, também vou ficar burra e quero que você saiba logo disso.*

Bem, certamente ainda não tinha ficado, porque ainda se dava conta do indiscutível processo de “burrificação” das crianças e dos adolescentes, por meio da tentativa de encolher seus vocabulários. Nada fora do comum se uma criança diz, por exemplo, “*Tenho ódio do meu irmão*”, vemos seu pai, sua mãe, ou outro adulto qualquer, rebatendo incontinenti: “*Que é isso, menino(a), ter ódio dos outros é feio! Nunca mais diga essa palavra!*” Pronto: menos palavras, respiração mais dificultada, mais distímias, menos inteligência!

A menina já tinha começado a perceber que era mais uma candidata a ser vítima desse processo burrificante e, por constrangimento ou caridade, chamou a mãe para alertá-la de que, muito provavelmente, não continuaria para sempre tão brilhante quanto fora até então.

Contextos

Muito bem, então a linguagem de reparação expande a fala, amplia e aprofunda a respiração, reduz distímias e incontáveis sintomas neuróticos, turbina a inteligência. Mas pode ser usada em quaisquer circunstâncias? Óbvio que não! Um exemplo caricato vai ilustrar isso. Imagine-se um grupo de pracinhas perfilado diante de um sargento, que brada a plenos pulmões:

Ordem unida

SARGENTO: – *.Direita, volver!*

Não parece que caberia, nessas circunstâncias, que um pracinha retrucasse, perfeitamente alinhado com a linguagem de reparação:

PRACINHA: – *.Puxa, sargento, quando o senhor grita assim, eu fico super magoado, lembro-me de quando eu era pequenino e morava em Barbacena e meu pai blá, blá, blá, blá, blá, blá...*

Claro que um tal diálogo teria conseqüências externas catastróficas e, na verdade, custa crer que, em tais circunstâncias, jamais fosse ocorrer. Mas não é de usar a *linguagem de reparação* em contextos em que ela não cabe de que sofre a humanidade. É do tropeço oposto, o de NÃO USAR a *linguagem de reparação* quando seria a hora de fazê-lo, permitindo vasto acúmulo de memórias hiperestésicas com todas as lamentáveis conseqüências que já fartamente expostas.

Digamos que, numa *happy hour*, o supramencionado pracinha esteja tomando com um colega de regimento umas saborosas cervejinhas em um pacato bar e que a esse colega dirija o seguinte “desabafo” (tentando recuperar seu “bafo”, seu ar)::

Pracinhas (I)

PRACINHA 1: – *Caramba, aquele nosso sargento é grosso demais para meu gosto. Ele me perturba. Já passei por outros sargentos capazes de dar ordens de maneira muito mais normal.*

Seria exatamente a boa hora de seu ouvinte responder usando a *linguagem de reparação*, ajudando o colega a dissolver a emoção que ficou armazenada a partir do impacto que a berrada ordem do sargento lhe provocara. E é isso que costuma acontecer? Não, nove entre dez vezes, seu ouvinte irá reagir tentando bloquear o “desabafo” do colega, com comentários do seguinte tipo:

PRACINHA 2: – *É, cara! Prepare-se! Não só ele deve continuar sendo nosso sargento durante um bom tempo, como você acha que está onde? ‘Tá no mundo da Lua? ‘Cê ‘tá no exército, cara! Prepare-se porque ainda vem coisa pior pela frente!*

Estivesse a humanidade um pouco mais afeita ao uso de uma *linguagem de reparação*, o diálogo poder-se-ia ter transcorrido da seguinte forma:

Pracinhas (II)

PRACINHA 1: – *Caramba, aquele nosso sargento é grosso demais, para meu gosto. Ele me perturba. Já passei por outros sargentos capazes de dar ordens de maneira muito mais normal.*

PRACINHA 2: – *Interessante! A mim ele não perturba. Tenho até um pouco de pena dele, por ser tão ranzinha. Fico pensando: a vida pessoal desse cara deve ser uma merda!*

PRACINHA 1: – *É. Eu não consigo ter esse distanciamento que você tem. Talvez porque meu pai, além de ser super grosso comigo, também era com minha mãe e com meus irmãos e irmãs, todos mais novos do que eu. Eram sete.*

PRACINHA 2: – *Como você se sentia?*

PRACINHA 1: – *Impotente. Queria defendê-los e não me sentia com condições para isso. Quando fiz 18 anos, saí de casa e me alistei no Exército.*

Agora me sinto um covarde por haver abandonado meus irmãos, irmãs e minha mãe nas mãos daquele animal. Mas também, o que eu podia fazer? E, pra completar, tenho que suportar a mula desse sargento, que me faz diariamente lembrar do grosso do meu pai.

PRACINHA 2: – *Caramba, agora dá para entender porque nosso sargento perturba tanto você.*

PRACINHA 1: – *É, mas foi bom falar. Já estou me sentindo um pouco melhor. Saúde, irmão! E obrigado por me haver escutado!*

PRACINHA 2: – *É pra isso que servem os amigos, cara! Saúde!*

Se a expressão verbal de nossas emoções é inadequada em contextos formais ou em que a concentração no cumprimento de uma tarefa é fundamental, deixar de expressá-las em contextos sem compromissos e informais patrocina um enorme acúmulo de memórias hiperestésicas com todos os sintomas neuróticos a que elas dão origem, o que, espero, já terá ficado fartamente demonstrado.

Mas, na verdade, aprender a distinguir os contextos em que cabe usar cada uma dessas linguagens, é o maior desafio para quem quiser fazer bom uso delas. Descobri um dos melhores contextos para se fazer essa aprendizagem: uma corrida de táxi, onde você esteja sozinho com o motorista, sentado na cadeira do carona.

Com efeito, essa circunstância em muito se assemelha àquela em que se encontram paciente e psicoterapeuta, em tratamento individual: duas pessoas sozinhas, num ambiente fechado, com pouquíssima possibilidade de, caso comecem a conversar, serem interrompidos pela interferência de terceiros. A propósito, sempre solicito ao motorista que desligue o rádio, caso ele esteja ligado, no que sou invariavelmente acatado.

Como, numa situação dessas, vou saber se cabe ou não levar adiante uma conversa tipo reparadora?

Fácil:

(1) há motoristas que se mantêm calados, deixando claro que não querem conversa;

(2) há outros que falam, por vezes até copiosamente, sobre assuntos totalmente impessoais e, por fim,

(3) há outros claramente inclinados a falar sobre a própria vida. Salta à vista, que apenas o terceiro grupo irá tirar proveito dos benefícios de um papo loganalítico.

No caso que passo a relatar, o diálogo reparador ocorreu de forma tão absolutamente espantosa, que muitos terão dificuldade – até eu tenho – de acreditar que ele, de fato, ocorreu:

O Motorista Ansioso

Não me lembro de jamais haver entrado em um táxi – como sempre, sento-me no lugar do carona – e me haver defrontado com um motorista tão absolutamente perturbado. Suas mãos tremiam, mesmo segurando o volante, sua respiração estava visivelmente dificultada e, mal declinei o lugar de meu destino, começou espontaneamente a falar:

MOTORISTA: – *Quem é que aquele cara pensa que é?*

EU: – *Quem?*

MOTORISTA: – *O passageiro que acabou de saltar!*

EU: – *O que houve com ele?*

MOTORISTA: – *Falava comigo, não como se fosse um simples passageiro, mas como se fosse meu patrão. Queria dizer até quando eu devia passar essa ou aquela marcha, quando eu devia ficar mais à esquerda ou à direita da rua! E com voz de general! Minha vontade era dar-lhe umas bordoadas e mandá-lo para a p.q.p.! Mas eu não posso fazer isso, preciso deste emprego, e ainda pago diária para o maldito dono deste carro!*

A maior parte dos passageiros, imagino, não iria dizer nada ou iria dizer coisas do tipo

PASSAGEIRO: – *Cara, mas você não pode ficar assim! Vai acabar tendo um infarto! Ou você acha que só vai pegar pacientes educados e gentis? Talvez seja melhor você procurar outra profissão etc., etc., etc.*

Usei a Nova Conversa que, no fim das contas, não é mais do que ajudar a pessoa a falar.

EU: – *Esse tipo de coisa já aconteceu outras vezes com você?*

MOTORISTA: – *Acontece toda a hora! Outro dia, foi uma velha, toda metida! Tava com pressa e queria que eu ultrapassasse o limite de velocidade do Aterro! Tá cheio de “pardais”! Depois, quem ia pagar as multas? Ela? Claro que não! Não ultrapassei o limite e ela foi me infernizando até o fim da corrida! Minha vontade era matá-la, ou pôr ela para fora do carro, bem ali no meio da pista. Claro que não fiz nada disso, mas estragou o meu dia!*

EU: – *Você já trabalha com táxis há muito tempo?*

MOTORISTA: – *Há três meses, depois de que fui despedido do banco em que eu trabalhava.*

EU: – *Trabalhava lá há muito tempo?*

MOTORISTA: – *Há dezoito anos! E gostava de trabalhar lá! Tinha muitos amigos!*

Bem, fui fazendo perguntas que lhe permitiam falar das agruras e prazeres que vivera em seus demais empregos, das que vivia no táxi, em sua vida familiar etc., sem acrescentar conselho, consolo ou crítica⁷⁵. Aos poucos, parou de tremer, sua respiração começou a normalizar-se, começou a falar num tom mais tranqüilo, o humor raivoso desapareceu e estava visivelmente mais relaxado.

A corrida foi curta, durou pouco mais de 20 minutos. Agora vem o que, até para mim, foi difícil de acreditar. Quando chegamos a meu destino, perguntei:

EU: – Quanto foi a corrida?

MOTORISTA: – É ruim de o senhor pagar esta corrida!

EU: – ‘Cê ‘tá maluco, cara?!

MOTORISTA: – Não. Maluco eu estava quando o senhor me pegou em Ipanema. Agora eu estou pianinho, pianinho...

EU (tentando me refazer da surpresa): – ‘Ta bom! Muito obrigado!

MOTORISTA: – Tem mais: sua consulta (não me lembro como saiu, em nossa conversa, que eu era psicólogo) deve ser pelo menos umas trezentas pratas, a corrida foi vinte. Fiquei lhe devendo duzentos e oitenta. Se entrar de novo neste táxi, não paga nada até compensar o que lhe devo.

Despedi-me, saí do táxi e até hoje tenho dificuldade de acreditar no que aconteceu. Se quiserem, acreditem vocês. Melhor, tentem apenas facilitar a fala de quem está precisando falar, sem poluir a conversa com conselhos, consolo e críticas não solicitados. Quem sabe também não ganham uma corrida de graça?

O episódio ilustra, de qualquer forma, como a *Nova Conversa* estabelece um tipo de diálogo, altamente terapêutico, que não tem lugar apenas dentro de consultórios psicoterápicos, embora seja necessário aprender a distinguir em que contextos cabe empregá-la.

O “bem intencionado” cala a boca

Um problema, não dos menores: apenas terapeutas competentes não vão tentar calar sua boca. Os *shrinks* invariavelmente tentarão fazê-lo, com palavras, ou com psicofármacos ou com ambos. Se conseguirem vão, no máximo, *mudar a forma* de sua neurose, jamais curá-la. Pelo que chega a mim, o “cala a boca” mais frequente na terapia com um *shrink* é dizerem para um paciente que está expressando sentimento de culpa que ele objetivamente, não tem culpa e, que, portanto, não deveria senti-la.

⁷⁵ Acréscimos que, se não solicitados, são particularmente afeitos a poluir qualquer relação psicológica. Batizei esse conjunto de “A Poluição dos Três Cs”.

Culpa

Os “sintomas de simetria” são um tipo quase que invariavelmente presentes nos quadros de neurose – hoje “transtorno” (Argh!) – obsessivo-compulsiva. Maurício, por exemplo, se batia com a mão direita no braço direito da poltrona em que, durante suas sessões, se acomodava, era irresistivelmente compelido a fazer o mesmo com a mão esquerda no outro braço da poltrona. Em minha longa experiência clínica, esses sintomas de simetria são rituais cujo objetivo é exorcizar a sensação de ser injusto (culpa) por tratar um braço da poltrona de uma forma e outro de outra.

Neuróticos obsessivo-compulsivos são – salvo raras e pouco honrosas exceções – extremamente inteligentes e disciplinados. Expliquei a Maurício como memórias hiperestésicas de culpa eram a provável raiz de suas ideias obsessivas e de seus comportamentos compulsivos e que tais sintomas iriam desaparecer quando nós fôssemos, de maneira devidamente dosada, dando espaço para o sentimento de culpa ser devidamente verbalizado. Fomos fazendo isso e recolhendo os sonhos e lembranças que necessariamente vêm à tona com o desenrolar do processo, quando, numa sessão, Maurício, bateu com a mão direita no braço correspondente da poltrona e, nitidamente surpreso, com a mão esquerda levantada sobre o braço esquerdo da poltrona, exclamou:

– Ei, não me estou sentindo compelido a bater com a mão esquerda no outro braço da poltrona! Isso é absolutamente incrível! Eu jamais, desde que me lembro por gente, deixei de ter essa compulsão.

E revelou-me algo que ainda não me havia dito:

– Depois da última sessão, fui tomado de uma espécie de euforia e saí à rua, pouco me importando com os transeuntes e rodando em torno de mim mesmo, como que em uma dança, repetindo, com especial sabor de prazer: “Culpado! Culpado! Culpado!” Depois disso, já em casa, vi que vários de meus sintomas de simetria haviam desaparecido! Simplesmente sumiram! Sumiram!

Desde pequeno que Maurício tinha sido impedido de expressar culpa em palavras, pois sua mãe dizia que culpa não existia, que culpa era uma invenção da Igreja católica para dominar as pessoas, que ele podia dizer que era responsável, nunca culpado por alguma coisa. Claro que ela, que, em sua infância, se ressentira fortemente das tentativas de a manipularem por meio de induzir-lhe culpa, não estava mais do que tentando proteger o filho do mesmo sofrimento por que passara. Como se vê, de boas intenções o inferno está cheio...

Muito bem, se sabemos que é saudável poder, em contextos íntimos e informais, expressar verbalmente nossas emoções, é bom sabermos que, com os hábitos

lingüísticos de nossa cultura, muito provavelmente nossos ouvintes irão tentar, não obstante cheios de boas intenções, calar nossas bocas. Como nos defendermos deles?

Pois é, mesmo em condições íntimas e informais, se expressamos verbalmente estar sentindo alguma emoção dentre as consideradas “negativas” pela dominante *Psicologia do Faz-de-Conta* – medo, culpa, ódio, tristeza, desânimo, vergonha estão entre as mais execradas – logo algum interlocutor tentará fazer que deixemos de falar sobre elas. Repito: mesmo em condições íntimas e informais. Até em situações em que a expressão dessas emoções “negativas” é mais do que cabível, são mesmo aconselháveis, alguém muito provavelmente irá tentar calar nossa boca, com algum “Esquece isso”, “Bola pra frente!” etc., etc.

Vejamos um berrante exemplo, tirado do filme de Tom McLoughlin “No Limite do Silêncio”, de como a pressão cultural para dizermos que “*tudo está bem*” falseia as relações humanas, impelindo-nos a desenvolver falsos “eus”.

It's “ok”!

Michael (Andy Garcia), psicólogo, perdeu seu filho adolescente, Kyle, de forma particularmente trágica, capaz de jogar qualquer um em severa depressão. À dor da perda, acrescentava-se, em Michael, a dor da culpa. Kyle suicidara-se em virtude da vergonha que sentia por se haver deixado induzir a manter relações homossexuais com seu terapeuta, a quem recorrera por indicação de seu pai, que dele fora aluno. Arrasado pelo sofrimento, Michael abandona a atividade clínica, dedicando-se apenas a dar conferências e a escrever.

Algun tempo após a morte de seu filho, encontra-se com Bárbara (Terri Polo), uma ex-aluna, e trava-se o seguinte diálogo:

BÁRBARA: – Você fez terapia depois que seu filho morreu?

MICHAEL: – Não.

BÁRBARA: – Imagino o que você passou...

MICHAEL: – Está tudo bem! [= Well... It's ok!]

BÁRBARA: – Por que você está fazendo isso?

MICHAEL: – O quê?

BÁRBARA: – Mencionei duas vezes seu filho e você respondeu “It's ok!”, como se nada de importante houvesse acontecido!

MICHAEL: – Você não deixa passar nada, não é?

BÁRBARA: – O que você teme que aconteça, se me expuser a dor por que deve estar passando?

MICHAEL: – Tenho medo de que você diga que meu filho foi para um lugar melhor ou que pelo menos ainda tenho minha filha ou qualquer uma dessas baboseiras que todo mundo diz, tentando amortecer a dor por que estou passando, o que não faz mais do que aumentá-la.

BÁRBARA: – As pessoas dizem isso para você?

MICHAEL: – Diziam. Todas.

BÁRBARA: – Não dizem mais?

MICHAEL: – Não. Não porque eu aprendi a dizer para todos que “está tudo Ok”, como disse para você!

Estamos nos dedicando a criar uma humanidade constituída por “falsos eus”! Isso pode dar certo?

Consideremos o seguinte diálogo, radicalmente alienante, extraído de outro filme, esse intitulado “*Até que a Vida nos Separe*”, dirigido por Alan Alda, para depois o compararmos como ele poder-se-ia ter-se desenvolvido, se orientado por uma conversa de fato reparadora.

Divórcio (I)

Jackie (Veronica Hamel), a protagonista, imediatamente após haver assinado seu divórcio, que obteve contra a vontade do marido, encontra-se em um restaurante com uma amiga.

AMIGA: – Como foi?

JACKIE: – Poderia ter sido pior! Ele não mordeu ninguém!

AMIGA: – Vamos comemorar. À sua nova vida!

Jackie ensaia uma expressão chorosa.

AMIGA: – Que foi?

JACKIE: – E se eu tiver cometido um terrível erro?! E se eu estiver arruinando minha vida e a de minha filha?!

AMIGA: – Sua filha já está crescida! E você também!

JACKIE: – Eu nunca vivi sozinha! Nunca! Saí direto da faculdade para o casamento!

AMIGA: – Não é tão ruim assim! Pode ser divertido! E penso que vai ser bom para você! É importante saber como viver sozinha! Oh, por favor, dê algum tempo para você mesma! Você vai conhecer alguém! Você vai se apaixonar!

JACKIE: – Interessante você dizer isso, pois já se divorciou há dois anos, e tudo que tenho ouvido de você são estórias horripilantes!

AMIGA: – Não seja tão negativa! Veja, você tem que lidar cientificamente com isso!

Cientificamente! Cientificamente! Certamente segundo a *Ciência do Faz-de-Conta* e dos *shrinks*, dos *encolhedores de cabeça*, é claro! Do ponto de vista da estratégia breueriano-freudiana de ampliação da fala, Jackie, com tal amiga, não precisa de inimigos. Durante todo o diálogo, essa “amiga” ocupa-se em tentar impedir que Jackie ponha sua emoção – seu pathos – na palavra – no logos – e – cúmulo dos cúmulos! – termina por descrever sua posição como “científica”. A tirar por Hollywood, Terêncio, Voltaire, Nietzsche, Breuer, Freud e vivem a se revirar em seus túmulos!

Como poderia ter-se desenvolvido esse diálogo se orientado por princípios de ampliação da fala? Quem sabe, assim:

Divórcio (II)

Como vimos, Jackie (Veronica Hamel), a protagonista, imediatamente após haver assinado seu divórcio, que obteve contra a vontade do marido, encontra-se em um restaurante com uma amiga..

AMIGA: – Como foi?

JACKIE: – Poderia ter sido pior! Ele não mordeu ninguém!

AMIGA: – Vamos comemorar. À sua nova vida!

Jackie ensaia uma expressão chorosa.

AMIGA: – Que foi?

JACKIE: – E se eu tiver cometido um terrível erro?! E se eu estiver arruinando minha vida e a de minha filha?!

AMIGA: – Bem. É uma possibilidade. Difícil, na verdade, podemos sempre saber com certeza se estamos agindo certo ou errado e essa dúvida dói muito quando há coisas tão importantes postas em questão.

JACKIE: – Eu nunca vivi sozinha! Nunca! Saí direto da faculdade para o casamento!

AMIGA: – Quando você fazia faculdade, ainda morava com seus pais? Ou no próprio campus?

JACKIE: – No campus.

AMIGA: – E agora, onde está pretendendo morar?

JACKIE: – No apartamento em que eu e Steve morávamos. O apartamento ficou para mim.

AMIGA: – Bem, pelo menos você não terá que deslocar-se para um ambiente estranho. Sua filha, que eu saiba, já está casada e não morava com vocês.

JACKIE: – É verdade. Mora com o marido, em Denver, mas vem sempre nos visitar.

AMIGA: – Como ela reagiu à notícia do divórcio?

JACKIE: – Bem, lamentou que o pai dela e eu não tenhamos conseguido nos acertar, mas respeitou o fato de eu querer tentar alguma coisa sozinha e disse estar à disposição para o que qualquer um de nós dois precisar. Mas, sabe de uma coisa? Algo que também me assusta diz respeito a você: você já está divorciada há dois anos e as histórias que você me conta são terríveis.

AMIGA: – É verdade, tenho passado por alguns maus pedaços, mas, sabe de uma coisa? Se me lembro de como era minha relação com meu ex-marido, prefiro assim. De qualquer forma, se você tiver de enfrentar algum desses maus pedaços, conte comigo. Quem sabe tenho alguma coisa para ensinar?

JACKIE: – Caramba, muito obrigada. Talvez, nessas horas, os ouvidos de nossos amigos sejam, mesmo, nosso melhor apoio.

Bem melhor, não? Mais uma vez, esperemos que, um dia, esse tipo de diálogo possa se disseminar sobre a face deste convulsionado planeta. Mas, como disse Zeldin, precisamos:

“aprender a falar do próprio ato de conversar.”⁷⁶

Então, vamos treinar mais um pouco. Comparando o resultado de três diferentes maneiras de lidar com um mesmo fato, qual seja: Rogério e Susana pretendem morar juntos e Rogério fala para Susana que está com medo de comunicar isso aos pais dela. No primeiro diálogo, nem Rogério nem Susana empregam uma abordagem reparadora; no segundo, apenas ele; na terceira, ambos.

Rogério e Susana (I)

ROGÉRIO: – *Susana!*

SUSANA:– *Oi!*

ROGÉRIO: – *É hoje, né?*

SUSANA: – *É, é hoje.*

ROGÉRIO: – *Estou um pouco ansioso!*

SUSANA:– *Se você tá ansioso ou não tá ansioso, não tem a menor importância, contanto que você fale com eles..*

ROGÉRIO: – *Não, meu bem, pode ficar tranqüila, vou falar, sim.*

SUSANA:– *Além disso, não há nenhuma razão de você estar ansioso. Eles não mordem! E a gente, objetivamente, não depende deles. Cada um de nós tem seu emprego, somos maiores, podemos viver sem precisar deles para nada.*

ROGÉRIO: – *Você tem toda razão, amor.*

SUSANA:– *É, além do mais, não acho nada agradável ouvir você dizer que está ansioso. Afinal, você me ama ou não? Eu me sinto desprotegida com um homem que fica ansioso com uma bobagem como a de comunicar a meus pais que vamos morar juntos!*

ROGÉRIO: – *Desculpe, fofinha. Eu amo você, sim. Vou acabar com essa ansiedade.*

Aparentemente, tudo bem; na verdade, tudo mal. O diálogo pressiona Rogério a bloquear a expressão verbal de sua ansiedade. Se esse bloqueio, vindo de fora, se transformar em bloqueio operando de dentro, dará origem a memórias hiperestésicas, que acabarão por gerar sintomas neuróticos de variada ordem, entre os quais alguns capazes de solapar a inicialmente boa qualidade da relação do casal. Chamo isso de *Velha Conversa*. Do ponto de vista da promoção da saúde mental, uma verdadeira catástrofe!

Na versão seguinte, Susana tenta impor a Rogério o paradigma dessa *Velha Conversa*, mas ele não permite que isso ocorra.

⁷⁶ Zeldin, T. **Op. cit.**, p. 10.

Rogério e Susana (II)

ROGÉRIO: – Susana!

SUSANA: – Oi!

ROGÉRIO: – É hoje, né?

SUSANA: – É, é hoje.

ROGÉRIO: – Estou um pouco ansioso!

SUSANA: – Se você tá ansioso ou não, não tem a menor importância, contanto que você fale.

ROGÉRIO: – Bem. Se tem importância ou não eu estar ansioso, não tenho a menor idéia, mas que tem importância, eu estando ansioso, poder falar sobre isso com você, sei muito bem!

SUSANA: – Além disso, não há nenhuma razão de você estar ansioso. Eles não mordem! E a gente, objetivamente, não depende deles. Cada um de nós tem seu emprego, somos maiores, podemos viver sem precisar deles para nada.

ROGÉRIO: – Eu não me lembro de ter dito que “tinha razão”⁷⁷ de estar ansioso. Lembro-me de dizer que estou ansioso. Se bem que, na verdade, a ansiedade está diminuindo e eu estou ficando é irritado com você.

SUSANA: – Irritado, é? Pois saiba de uma coisa, eu também não gostei⁷⁸ nada de saber que você estava com medo. Afinal, você me ama ou não? Eu me sinto desprotegida com um homem que tem medo de uma bobagem como comunicar a meus pais que vamos morar juntos!

ROGÉRIO: – Susana, se eu sentir ansiedade deixa você se sentindo desprotegida, é bom que, como estamos pensando em morar juntos, você saiba desde já que para mim sentir ansiedade é algo tão natural como respirar ou fazer pipi! E que não tenho a menor pretensão de, quando estiver ansioso, esconder isso de você!

Muito bem. Aqui, Rogério conseguiu defender-se dos obstáculos que Susana estava opondo à ampliação da fala de seu namorado, mas ele foi capaz de defender, frente a cada um dos argumentos que tentavam encolher (*to shrink!*) a sua fala, seu direito de formular verbalmente o que se estava passando em seu mundo interior. Caso ele aja sempre assim, não irá produzir memórias hiperestésicas, nem, a partir disso, desenvolver sintomas neuróticos. Passemos a uma terceira versão dessa estorinha, em que tanto Rogério quanto Susana são capazes de entabular uma Nova Conversa:

Rogério e Susana (III)

ROGÉRIO: – Susana!

SUSANA: – Oi!

ROGÉRIO: – É hoje, né?

SUSANA: – É, é hoje.

ROGÉRIO: – Estou um pouco ansioso!

⁷⁷ Lembram-se de Pedro e de como soube defender-se dos “cala a boca” de sua mulher?

⁷⁸ Nada melhor do que o bom exemplo!

SUSANA: – *Engraçado, eu também. Você tem idéia do que está provocando ansiedade em você?*

ROGÉRIO: – *Sei lá. É meio estranho. Na verdade, estamos indo lá por uma questão de gentileza e educação e temo sermos recebidos com patadas. Nós, objetivamente, não precisamos deles para nada. Temos nossos empregos, somos perfeitamente capazes de nos sustentarmos. Mas gostaria que eles pudessem ver as coisas também de nosso ponto de vista. Sabe de uma coisa? Por um lado, eu sinto pena, porque eu gosto deles e sei que eles ficam esperando que nossos valores sejam iguais aos deles, que a gente quisesse casar na igreja, você com véu e grinalda. Mas não são! E temo que eles se arroguem o direito de nos agredir por causa disso. Na verdade, acho eles bem egoístas. Querem que a gente preencha o ideal deles, não os nossos. Mas, mesmo achando eles egoístas, gosto deles e me desagrada pensar no momento em que vou – imagino! – fazê-los sofrer. Por outro lado, me dá raiva. Me dá raiva dessa postura deles de pensar que podem decidir por nós e de imaginar que seu pai pode agir de maneira desrespeitosa em relação a mim ou a você, o que me põe na encruzilhada de ou engolir calado – o que não vai me fazer bem – ou agredir de volta – o que não vai me fazer bem da mesma forma.*

SUSANA: – *É, engraçado, né? Objetivamente, eles não têm nenhum poder sobre nós, mas a gente fica querendo dar uma satisfação a quem, provavelmente, não vai ficar nada satisfeito. Já me passou na cabeça, sinceramente, de, em vez de irmos lá comunicar de maneira formalmente educada que vamos morar juntos, falar simplesmente pelo telefone: – “Mamãe, papai, eu e o Rogério estamos nos mudando para XYZ, o telefone é ZXY! Apareçam!”*

ROGÉRIO: – *É... Não sei, amor! Em certos momentos me passa na cabeça que eles talvez não sejam tão rígidos assim e vão até curtir nossa decisão. Bem. De qualquer forma estamos falando de seus pais e eu topo fazer o que você achar melhor. Tô com você e não abro!*

– *Eu também, amor! Pra sempre.*

Melhor, não? A forma mais freqüente por meio da qual um tenta obstaculizar a colocação de nossos pathe em seu apropriado lugar no logos, é exigir que nossa fala preencha uma, ou mais de uma, das seguintes quatro condições, com ênfase sobre a primeira: ser *racional*, ser *importante*, ser *útil*, ser *agradável*. É fundamental para a implementação da Nova Conversa que não nos submetamos a essas descabidas exigências, reconhecendo a legitimidade incondicional de nossa fala “patológica”⁷⁹. Mas, para isso, repetindo Zeldin, precisamos:

*“aprender a falar do próprio ato de conversar.”*⁸⁰

Vamos sistematizar um pouco mais essa conversa sobre a conversa

⁷⁹ O uso da palavra “patologia” (do grego “*pathos*” = sofrimento + *logos* = conhecimento verbal, estudo) para representar “estudo das doenças” *já é em si, um sintoma da doença que considera todo sofrimento como doentio*, mais ainda quando temos à nossa disposição o termo “nosologia” (do grego “*nosos*” = doença + *logos* = conhecimento verbal, estudo), muito mais apropriado para esse uso.

⁸⁰ Zeldin, T. **Op. cit.**, p. 10.

As Armadilhas Clássicas

Segundo minha experiência, a técnica mais comum empregada para se evitar a escuta é, simplesmente, mudar-se de assunto, das formas mais óbvias às mais sutis. Haveria uma técnica particularmente eficaz para quem quer ser escutado defender-se desse desvio? Sim. Usar a técnica do “João Teimoso”, bonequinho que, apostado, a maior parte de meus leitores conhece. É aquele bojudinho na base e que vai afinando na direção da cabeça, bem diminuta, de forma que, se o inclinamos, tirando-o da posição ereta, ele volta espontaneamente para ela. Ser um João Teimoso da fala é, simplesmente, voltar para a fala que nos interessa enunciar, desconsiderando os “convites” ao desvio. Um exemplo:

A Fuga para o Macro

MARIDO (sentado à mesa do jantar): – *Mulher, esta sopa está fria!*

ESPOSA (em tom dramático): – *Eu sei que eu nunca faço nada certo!*

MARIDO (serenamente, aparentemente treinado em Loganálise): – *Meu bem, se você nunca faz nada certo, eu não sei, mas de que essa sopa está fria, eu tenho certeza.*

“Sempre” e “nunca” tem usos decentes e indecentes, melhor diria, honestos e desonestos. O uso acima é claramente desonesto, a mulher está usando o “sempre” para desviar o assunto do fato imediato de que o marido está achando a sopa fria. Mas há, evidentemente, usos decentes dessas palavras. Vejamos:

INTERLOCUTOR 1 – *Você já foi a Londres?*

INTERLOCUTOR 2 – *Não, nunca fui, mas sempre tive vontade de ir!*

Nada de errado, concordam? Mas vamos reaproveitar um trecho da vinheta clínica “A Tosse”, em que Marcos, já bem treinado, não dá espaço para que Neide, sua esposa, consiga impedi-lo de falar de seu sentimento de culpa.

Neide tentando colocar-se no lugar de quem está sendo acusada:

– *Quando você fala esse tipo de coisa eu me sinto superculpado – retrucou, após mais uma das invectivas de sua namorada, acusando-o de não amá-la.*

– *Não é para você se sentir culpado que eu falo isso.*

– *Eu não disse que você fala isso para eu me sentir culpado, eu disse que, quando você fala esse tipo de coisa, eu me sinto assim!⁸¹*

⁸¹ Deixando claro que, num diálogo loganalítico, que visa apenas a redução da força excessiva, disfuncional, de uma determinada emoção, apenas importa que essa emoção possa ser verbalmente expressa, de maneira incondicional, independentemente de quaisquer outras considerações. Logo veremos o resultado quase milagroso dessa abordagem.

Neide tentando desviar para se Marcos tem ou não “razão” de sentir culpa:

- Ah, mas você também não tem razão para se sentir tão culpado!⁸²
- Eu também não disse que tenho razão, nem sei o que significa “tão” culpado. Eu disse, simplesmente, que me sinto culpado...⁸³

Neide tentando desviar para se Marcos está pedindo que ela mude:

- Bem, se você está pensando que eu vou deixar de falar nisso só porque você se sente culpado, você está muito enganado..
- Neide, também não me lembro de lhe haver pedido que você pare de falar sobre esse assunto: lembro-me apenas de lhe haver dito que me sinto culpado quando você fala sobre ele. Se você continuar tendo vontade de falar, você fala; se eu continuar me sentindo culpado e tiver vontade de lhe dizer isso, vou fazê-lo! Simples assim!⁸⁴

Dentre as práticas culturais apontadas como tentativas de calar a expressão das emoções está, como já deixamos subentendido, a de se ter ou não razão para expressá-las. Primeiro, ambientes íntimos e informais são os lugares em que deveríamos ter direito incondicional de expressarmos nossas emoções, independentemente de terem manifestas razões que as justifiquem, de serem prazerosas ou desprazerosas, de serem úteis ou inúteis para o cumprimento de alguma tarefa etc., etc.. Ah, cumpre acrescentar que um enorme número de pessoas quer saber a razão de você estar mal para contestar a razão que for apresentada.. Vejamos

Tornando ilegítimo o sofrimento⁸⁵ (I)

Lugar: Osasco.

Cenário: escombros da explosão que havia matado e ferido vários transeuntes de um shopping da cidade.

Cena (transmitida pela TV): O PM que, sozinho, havia por primeiro prestado socorro aos atingidos afastara-se um pouco, após a chegada de ajuda, do local da tragédia e descarregava, em prantos, as emoções que enfrentara. Um passante não identificado se aproxima e começa a insistir com o PM:

- Não fica assim não, cara! Não fica assim! ‘Tá tudo bem! ‘Tá tudo bem!

‘Tá tudo bem!!!!!! Pela mãe do guarda (literalmente)!!!

⁸² Incondicionalidade do direito à expressão verbal da emoção!

⁸³ Idem.

⁸⁴ Idem.

⁸⁵ Mais exatamente, ilegitimando a linguagem “pato(= sofrimento)/lógica(verbalizado)”. É, de fato, assombroso como a ideia profundamente doentia de que verbalizar sofrimento é algo por princípio indesejável entranhou-se em nossa cultura!

Tornando ilegítimo o sofrimento (II)

Um mês depois de minha mãe haver falecido devido a um câncer no fígado, um de meus irmãos tentou suicídio. Eu estava como? Bem? Não, evidentemente estava mal, muito mal. Mas logo um “amigo” resolve “ajudar”:

– Não fica assim, cara!

– E para eu ter direito de ficar assim – retruquei – o que mais seria necessário? Que, por exemplo, meu filho fosse atropelado ou eu também tivesse um câncer? Larga de ser idiota, fulano!

Não sei se largou de ser idiota, mas foi cantar em outra freguesia!

Mas, em matéria de ilegitimar sofrimento, esta, das que conheço, é a melhor:

Tornando ilegítimo o sofrimento (III)

Foi a tia de Bernardo – um menino, à época, com dezessete anos – quem o enviou para consultar-se comigo, logo no início de minha prática clínica, quando eu ainda aceitava esse tipo de indicação por telefone, sem ter o cuidado de, antes, marcar uma entrevista com própria pessoa responsável pelo menor.

Assim, atendi Bernardo, sem ter solicitado maiores informações da tia que o encaminhara. Por telefone, ela se queixou de que havia algo de errado com o menino, pois ele estava “estranhamente desligado” e, quando se comunicava, só falava de ansiedade e de tristeza, em vez de estar curtindo sua adolescência. Quando recebi o rapaz, indaguei de pronto:

– “Foi sua tia que me pediu que eu lhe atendesse. Concluí, talvez apressadamente, que você não mora com seus pais. Isso é fato?”

– “É.” – retrucou, lacônico.

– “E mora com quem?” – insisti.

– “Com minha avó.” – retrucou, lacônico.

– “E por quê?” – insisti.

– “Porque meu pai foi assassinado.”

– “Há quanto tempo foi isso?” – continuei, tocado pela situação do rapaz.

– “Dez meses atrás.”

– “E por que você não ficou com sua mãe?”

– “Porque ela também morreu.” – continuei.

– “E há quanto tempo?”

– “Há três meses.”

– “E morreu de quê?”

– “Se suicidou, na penitenciária.”

– “Penitenciária!? Ela estava presa?”

– “Estava. Foi ela quem matou meu pai.”

E a tia do menino me dissera por telefone que havia algo de errado com ele (!!!), porque parecia desligado e só falava de ansiedade e de tristeza, em vez de curtir os prazeres de sua adolescência! Não admira que, vista essa prática de nossa cultura de, mesmo em contextos íntimos e informais, impedir as expressões de dor, bilhões – sim, eu disse bilhões – de pessoas que poderiam estar recebendo ajuda por não profissionais treinados em uma conversa acolhedora, tenham como único recurso psicoterapeutas profissionais – se derem sorte de não cair na mão de *shrinks*! – para poder externalizar seus sofrimentos.

Mas jamais me esqueci de uma única consulta de uma velhinha de 82 anos que não caiu nessa maligna armadilha.

Essa não caiu

Quando Sabina, com oitenta e dois anos de idade, me procurou, estava deprimida, revoltada e, para meu gosto, extremamente lúcida. Seu marido, único homem com quem se relacionara amorosa e sexualmente durante toda sua longa vida, com quem se casara virgem, aos dezenove anos de idade e com quem vivera em rara harmonia durante mais de seis décadas, morrera recentemente de um ataque cardíaco fulminante; pouco após, seu único filho, ao saber que sofria de câncer do cérebro, haver cometido suicídio.

Sua revolta, na verdade, não dizia respeito às suas recentes perdas. Em relação a essas demonstrava, muito saudavelmente, uma coerente dor. Estava, isto sim, relacionada à postura de sua única irmã e de suas duas maiores amigas, que a pressionavam para “não ficar assim”, ou seja, para que não atravessasse, durante o tempo que se fizesse necessário, o luto de suas perdas. E me procurara como profissional para saber se era ela que “estava louca” em estar triste ou sua irmã e suas amigas em querer que ela não sentisse a sua dor. Sabina, numa admirável demonstração de inteligência e de saúde psicológica, esbravejava na única – e suficiente – sessão que teve comigo:

– “E como deveria eu ficar? Satisfeita? Essas pessoas ficaram idiotas? Quando eu tinha seis anos e, pela primeira vez, alguém de minha família morreu, vi meus parentes vestidos de preto e os demais pareciam ter algum tipo de respeito e de distância em relação àqueles que, para sinalizar sua tristeza, estavam vestidos de luto. O próximo falecimento em minha família ocorreu quando eu tinha uns dezesseis anos e chamou-me atenção o fato de que as pessoas não mais se vestiam de preto. Tenho clara lembrança de haver notado que, já então, os homens apenas traziam uma tarja preta na lapela de seus ternos... Quando fiz vinte e cinco, morreu minha mãe, e constatei que até as tarjas pretas se foram! Agora, depois de eu haver perdido, num espaço absurdamente curto de tempo, meu único filho e minha alma irmã, meu companheiro de toda a vida, com quem vivi feliz por mais de meio século, nem ternos nem tarjas pretas: as pessoas querem, simplesmente, que eu “não fique

assim” e dizem que eu preciso é “sair de casa e me distrair”! O que houve com o mundo? Todo o mundo ficou idiota?

Alegra-me o fato de que Sabina encontrou a mim, que, após escutá-la, reforcei o que ela já sabia: que é estúpido e doentio não ficar triste, quando coisas tristes nos ocorrem.. Encontrou a mim e não algum “shrink”, que lhe houvesse enchido a cabeça de Prozac, para que ela superasse “alegremente” a perda do seu único filho e de seu único amor!

Tenho a mesma impressão de Sabina, alguma coisa aconteceu e as pessoas ficaram totalmente idiotas!

O protagonista do episódio que passo a relatar também não caiu. A conversa transcorreu em um dos grupos de treinamento em Loganálise.

Não estou mais com medo da Nilze...

Gilberto era um participante “avançado” dos grupos de Loganálise:

*– A Nilze me dá medo... – afirma, referindo-se a outro membro do grupo.
– Que é isso, cara! A fulana é legal! – intervém Ana.
– É mesmo! Ela tem esse jeito exuberante assim, mas, na verdade, não agride ninguém! – acrescenta Jorge.*

E os vários membros do grupo começaram a decantar as razões pelas quais Gilberto não precisava nem deveria sentir medo da Nilze, até que Gilberto confessou:

– É... Não estou mais com medo da Nilze!

Satisfação geral. Mas a satisfação não durou muito, pois Gilberto completou:

– É... Agora estou com medo de todos vocês: me assusta perceber que vocês ainda não entenderam que estamos aqui para ter o direito de dizer o que estamos sentindo, tendo ou não razão...

Dois outros episódios ocorridos em grupos de Loganálise, que objetivam treinar seus participantes na maneira loganalítica de entabular a Nova Conversa, também merecem menção. O que passo a relatar ocorreu num grupo de 8 pessoas, a metade composta por atores e atrizes, com sua habitual tendência a dramatizar.

A gente

– A verdade é que quando a gente entra no palco, dá sempre um medinho! – afirma Dulce.

– Não acho, não. O que a gente sente, na verdade, é uma excitação gostosa porque chegou a hora de a gente poder mostrar pra todo mundo do que a gente é capaz! – retruca Priscila.

Acirram-se os ânimos. O grupo é superexpansivo e seus participantes mergulham, ato contínuo, em intenso debate. Trinta minutos depois, quando ninguém mais consegue chegar a acordo nenhum sobre coisa alguma, Dulce retoma a palavra:

– Sabe de uma coisa? O que a gente sente quando entra no palco eu não tenho a menor idéia. Mas o que eu sinto quando entro no palco eu sei muito bem: sinto um medinho que me sobe bem por aqui pelo centro da barriga.

O fato de Dulce haver restringido sua fala à sua própria e pessoal emoção, anteriormente encoberta sob um generalizado “a gente”, teve efeito mágico. De acirrados, os ânimos acalmaram-se. Priscila falou o mesmo que já dissera, mas em tom completamente diverso:

– Ah, é? Interessante! Pois eu sinto uma excitação gostosa, aliás quando eu... – acrescentou Priscila, passando também a falar apenas de si mesma.

E continuaram, em clima ameno, a declinar cada um a própria experiência de entrar no palco, diante da respeitosa curiosidade dos demais. O que era disputa tornou-se escuta.

Note-se também que, por detrás do emprego de termos como nós e a gente – quando, na verdade, eu seria o sujeito indicado – esconde-se uma forma sutil de tentar impor padrões e normas aos demais, sendo o entrevero entre Dulce e Priscila uma disputa disfarçada sobre quem iria estabelecer a maneira de pensar e sentir a ser acatada pelo grupo. Ao empregar o pronome “eu”, Dulce parou de tentar impor normas sobre o que acontece “em geral” quando se pisa no palco e resolveu limitar-se a transmitir aos demais sua experiência pessoal, que, aliás, tornou-se tão mais única quanto mais se tornava clara e unicamente referida a si mesma⁸⁶.

Outro exemplo retirado dessas reuniões grupais:

Eu é que...

Júlia, no diálogo que segue, mostrou como já havia internalizado de maneira bastante eficaz os princípios loganalíticos:

⁸⁶ O episódio me trouxe à memória Nerso da Capitinga, personagem de Chico Anísio, que vez ou outra, na famosa Escolinha do Professor Raimundo, saía-se com esta: “ieu é ieu, u sinhor é u sinhor!”

– Sabe de uma coisa, Bruna? Fiquei muito magoada com aquilo que você falou..

– Eu é que fiquei magoada, porque... – retruca Bruna.

– Bruna, há mágoa bastante para todos... Não dá é pra nós duas falarmos ao mesmo tempo: se você quiser falar primeiro da sua, eu espero. Depois, gostaria de falar desimpedidamente da minha!

Esse diálogo levou o grupo a discutir por que existem hábitos lingüísticos em nossa cultura que revelam uma espécie de luta pela reserva de mercado no que diz respeito a determinadas frases, que alguém quer tomar só para si (fulano “é que”, os demais, não...). Um dos participantes, por exemplo, disse que, em sua família, sua mãe tinha essa “reserva de mercado” relativamente ao direito de expressar o papel de vítima. Por exemplo, se um dos filhos se sentia prejudicado em alguma coisa e tentava falar isso, imediatamente era defrontado com um comentário do pai ou da própria mãe afirmando que ela é que deveria estar reclamando, pois ela é que etc. etc. etc.” Esse tipo de monopólio no emprego de certas palavras produz, evidentemente, o bloqueio da fala dos demais, com as conseqüências que já conhecemos.

Outro exemplo, tirado de uma supervisão em grupo, coordenada por mim:

O “tem que”

Terapeuta: – Eu disse ao paciente que ele tinha que dar uma olhada mais profunda na relação que tinha com sua mãe..

Eu: – Não faz isso com o paciente, cara!

Terapeuta: – Mas por quê? É claro que ele tem que examinar um pouco melhor a relação que tem com a sua mãe!

Eu: – Fulano, quando um paciente nos procura, já vem com uma montanha de “tem quês” pesando sobre seus ombros, não me parece adequado que seu terapeuta lhe acrescente mais um!

Terapeuta: – Como, então, abordar o assunto, que, certamente, merecia ser abordado?

Eu: – Que tal assim: “Acho que se nós déssemos uma olhada mais cuidadosa na relação que você tem com sua mãe, teríamos grandes ganhos em nosso trabalho terapêutico!

Terapeuta: – Caramba, você tem razão! Iria ficar muito mais leve!

É impressionante o número de vezes que, no dia a dia de nossa cultura, as pessoas usam o “ter que”, onde bem melhor caberia “gostar de”. Por exemplo, em vez de dizer, “Eu gostaria de reservar uma maior parte de meu tempo para o lazer”, dizem “Eu tenho que reservar uma maior parte de meu tempo para o lazer”. O “ter que” está tão entranhado em nossa psique coletiva que, certa feita, eu estava falando para uma amiga sobre esse vício cultural e ela retrucou, pensativa “É verdade, cara! Eu tenho que parar com esse negócio de ter quês!” Certo ou errado, optei por deixá-la em paz com os seu “ter quês”. E, convenhamos, há pessoas que chegam exaustas de suas férias, agradecendo terem elas terminado, porque estando pela primeira vez, por exemplo, em Paris “tinham

que” visitar a catedral de Notre Dame, o Louvre, o Museu d’Orsay, a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, a Place Vendôme, o Palácio de Versalhes... Ufa! Trabalhar pode cansar menos!

Bem, frente a tudo que falamos da escravidão verbal a que nos tenta nos manter presos a cultura, imagino que meu leitores vão saborear especialmente um trecho do filme “*Don Juan de Marco*”, em que fica magistralmente representada a diferença entre a estratégia terapêutica que encolhe e a que amplia a nossa fala.

Don Juan de Marco

Quem acompanhou os diálogos dessa película apenas através de sua tradução legendada perdeu um essencial e saboroso detalhe, intimamente relacionado com a questão em torno da qual se desenvolve toda a trama. O Dr. Jack Mickler – personagem representada por Marlon Brando – é, no idioma original do filme, o inglês, ora chamado de *psychiatrist*, ora de *shrink*. Na tradução para o português, todavia, tanto *psychiatrist* quanto *shrink* são igualmente traduzidos por “psiquiatra”. A perda, na tradução para o português, da especificidade semântica de *shrink* (“to shrink” = encolher) é inestimável.

Com efeito, a partir dos anos sessenta, nos Estados Unidos, a gíria *headshrinker*, gradualmente simplificada para *shrinker* e, depois, para *shrink*, passou a ser usada para nomear os psiquiatras e, logo, por ampliação, psicanalistas e psicoterapeutas em geral. Ora, *headshrinkers* – encolhedores de cabeça – é expressão classicamente aplicada a silvícolas que, ao vencer seus inimigos, cortam-lhes as cabeças e diligentemente as encolhem, pondo-as em seguida a decorar a entrada de suas tendas. Se devidamente compreendida, a metáfora proposta por essa gíria é assustadora: psiquiatras, psicólogos, psicanalistas etc. – os “psicocoisas”, segundo um meu paciente – seriam inimigos de seus pacientes e, ao derrotá-los, estreitando suas falas, encolhem suas cabeças, separando-as de seus corpos – legítima origem de suas emoções e desejos..

Armados dessas considerações, voltemo-nos sobre o enredo do filme. O Dr. Jack Mickler é chamado para resgatar um jovem de seus vinte anos que, dizendo-se Don Juan e desiludido com nossos tempos, ameaça jogar-se do alto de um prédio. Mickler é bem sucedido, mas à custa de se dizer “Caballero”, um tal Don Octavio de Flores, e de convidar nosso Don Juan suicida para sua *quinta*, que, evidentemente, nada mais era do que um hospital psiquiátrico.

Lá chegados, tenta medicar o rapaz, mas esse propõe um trato. Não quer ser medicado antes de contar sua história. Se, ao terminar de fazê-lo, Don Octavio – Mickler, naturalmente – entender que ele ainda precisa ser medicado, dá sua palavra de que tomará sem resistência os remédios. Jack resolve aceitar o acordo, isso para o profundo desagrado do restante da equipe, que passa a pressioná-lo no sentido de medicar o paciente, queira esse ou não. Ou seja, a

pressionar Jack para agir como um verdadeiro *shrink*, abortando o delírio de seu paciente, encolhendo sua cabeça de forma a colocá-la dentro dos limites do considerado “normal”.

Mas, como dizia a expressão latina, ***necandus necavit necaturum*** (“quem devia morrer matou quem devia matar”). O delírio de Don Juan é absolutamente fascinante, fala de histórias em que os prazeres do amor e do sexo atingem supina expressão... E é Jack que, em vez de encolher a mente de seu paciente, começa a expandir a sua. Contaminado pelo delírio a que se dispôs a dar ouvidos, Jack começa a colorir o cinzento que, ao longo dos anos, tomara sub-repticiamente posse de sua vida. Começa a recuperar o amante que tinha dentro de si. Para o agradável espanto de sua mulher, passa a levar-lhe flores, dar-lhe jóias e convidá-la para jantar sob a luz de velas...

Há um momento em que o dilema “encolher ou expandir a mente” é focado de maneira extremamente jocosa. Jack Mickler, embora hesitante, decide contestar frontalmente o delírio de seu paciente:

– E se eu lhe dissesse que eu não sou Dom Octavio de Flores, mas, sim, um psiquiatra, e que esta não é minha quinta, mas o hospital onde eu trabalho, o que você me diria?"

– Que você tem uma visão extremamente estreita da realidade! – devolveu Don Juan.

Mas, quase que “em *off*”, Don Juan consola Jack. Diz-lhe, algo não muito convincente para um paciente francamente delirante, saber perfeitamente que Jack é um psiquiatra e que estavam em um hospital, não numa quinta, mas que, sendo tudo isso transcendentemente chato, quer continuar contando sua história, sem dúvida mais saborosa e digna de atenção. E Jack, aprofundando o desespero de seus colegas de equipe, continua a escutá-lo, em vez de medicá-lo. E, enquanto o escuta, segue recuperando a cor de sua vida. ***Necandus necavit necaturum!*** Tendo terminado o relato de sua história – tendo satisfeito seu desejo de falar – Don Juan se mostra capaz de abrir mão de seu delírio e deixar vir à tona tudo o que anteriormente eclipsara, revelando que sua extrema idealização da mulher era uma tentativa de compensar a dolorosa realidade da vida de sua mãe. Analogamente ao que ocorreu com Rose, minha paciente das duas e dez, que recuperou sua razão quando eu lhe permiti, durante quarenta minutos, percorrer os meandros da fantasia de que eu havia atrasado sua sessão, a liberdade de discurso que Jack Mickler deu a Don Juan foi o necessário e o suficiente na película para que esse último, recuperando dados que se havia apartado, voltasse a fazer uso de sua razão. Após haver injetado em seu psiquiatra uma nova alegria de viver...

A trama de *Don Juan de Marco* é uma bela alegoria um fato pungentemente real: não existe consenso, entre os profissionais da saúde mental, sobre se devem ser *shrinkers* ou *expanders*, sobre se devem encolher ou expandir a fala de seus pacientes...

E como fica você? Caso queira contar com a ajuda de algum desses profissionais, irá preferir um que pretenda encolher ou expandir a sua fala e, conseqüentemente, sua cabeça?

Bem, seja qual for sua escolha, espero que este livro (e, para quem o leu, o anterior, *A NOVA CONVERSA*) tenha sido capaz de fazê-lo distinguir a que tipo de tratamento pretende submeter a sua mente.

O “bem intencionado” abre a boca

No início de minha prática clínica eu não tinha muita noção da diferença entre “ajudar” e “pressionar” alguém a falar. Regina mostrou-me de maneira impactante os riscos de não saber fazer tal distinção.

Eu faço!:

Logo no início de sua sessão, minha paciente sinalizou, preocupada:

Regina: – Estão vindo uns pensamentos agressivos em relação a meu pai...

Eu: – Ué, deixa vir!

R.: – Não deixo, não!

Eu.: – Por quê?

R.: – Porque se eu deixar, eu faço!

Percebi, de imediato, a gravidade do erro que eu estava a ponto de cometer. Embora estivesse sendo atendida em minha clínica, onde, regularmente, não trato pacientes particularmente perturbados, essa paciente era uma exceção. Ela havia sido internada em uma de nossas instituições públicas psiquiátricas por soldados da PM, que a haviam encontrado nua, à noite, perambulando por uma das vias mais movimentadas de Copacabana.

Referindo-se a sua façanha, Regina esclareceu o que a levou a perpetrá-la. Ela ouvia vozes. Na noite em que fora internada, as vozes lhe haviam dito que pegasse uma enorme faca do aparador da cozinha e que fosse até o quarto em que seus pais dormiam para com ela assassiná-los. A paciente relutou em obedecer à ordem e as vozes lhe determinaram que ou ela fazia isso ou, então, deveria tirar toda a roupa e, despida, sair pela cidade. A paciente preferiu a segunda opção.

Portanto, um conselho: ouçam, mas não pressionem os demais – nem a si mesmos! – a falar, quando algo, por mais impreciso que seja, está pedindo com veemência para que não falem. Vocês já ouviram falar de “vitória de Pirro”? Pois bem, Pirro foi um rei da Antigüidade que, em 279 a.C., obteve significativa vitória, em Asculum, sobre os romanos. Saiu-lhe, no entanto, tão cara essa vitória que, vindo seus generais cumprimentá-lo, retrucou:

“Mais uma vitória dessas contra os romanos e eu estarei arruinado para sempre!”.

É desse episódio que provém a expressão “vitória de Pirro”, empregada para caracterizar vitórias tão custosas que talvez mais valesse não as obter.

Pois bem, “resistência” é o termo psicanalítico classicamente empregado para nomear os bloqueios de uma pessoa contra o acesso a uma determinada memória hiperestésica. Violentar uma resistência é uma “vitória de Pirro”: o preço pago por isso é alto demais. Resistências devem ser dissolvidas, não, violentadas.

Para que isso ocorra, quando a resistência é excessiva, cumpre, antes de qualquer coisa, falar sobre ela. Fazendo isso, você chegará com maior segurança, proveito e conforto, ao ponto a que, no fim das contas, vale a pena chegar. O seguinte episódio irá ajudar-nos no entendimento disso:

Eu falo!

Fernando irrompeu intempestivamente em minha sala, anunciando:

– Hoje eu falo!

Minha resposta foi imediata:

– Não sei se eu quero ouvir!

– O que!?! – estancou Fernando, surpreso.

– Fernando – continuei – já estamos trabalhando juntos há algum tempo.

De repente, você me chega aqui, aos brados, parecendo um camicase psicológico, em tudo sugerindo que vai cometer o ato heróico de contar algo que o apavora. Já vi esse filme. Seu resultado é, depois da façanha, você ficar olhando abobado para a minha cara, sem conseguir tirar qualquer proveito do que falou, a não ser o fato de se haver sentido momentaneamente corajoso. Não é preciso ser um gênio para desconfiar de que essa disposição toda significa que você está há algum tempo querendo falar sobre esse tal assunto e se sentindo covarde por não conseguir.

– É verdade – retrucou.

– Tudo bem. Então, vamos falar, antes, sobre covardia, sobre qual o papel que ela desempenhou em sua vida, sobre desde quando você se tem sentido covarde por não falar certas coisas aqui etc.. Estou certo de que, assim, iremos ampliar nosso diálogo de maneira mais produtiva e menos penosa.

De fato, fizemos isso, e, por havê-lo feito, acabamos por chegar de maneira extremamente proveitosa ao assunto que Fernando quisera inicialmente enfrentar de uma forma que, certamente, iria trazer muito calor, mas pouca luz.

Mas como lidar com as resistências que operam, o que extremamente comum, em nossos diálogos cotidianos? Vejamos:

O manejo cotidiano das resistências

– André, estou querendo lhe falar sobre uma coisa que você fez e que me deixou chateado, mas estou com dificuldade...

– Dificuldade de quê, cara? Pode falar!

– Calma, homem! Prefiro antes falar um pouco sobre por que estou com essa dificuldade, depois lhe digo o que quero realmente dizer. Na verdade, o que me vem à cabeça é que, na última vez que tentei lhe dizer que estava chateado com você, você ficou super irritado e, simplesmente, cortou o papo, abandonando o serviço que estávamos fazendo juntos. Não estou com a menor vontade de que isso se repita. Se você bem se lembra, estou-me referindo àquela vez em que, blá, blá, blá ...

– Tá bom! Tá bom! Prometo que não vou repetir o “ataque de pelanca”...

– Bem, pelo que conheço de você, posso acreditar em sua palavra e, se é assim, sinto-me mais seguro para falar. Eu fiquei chateado quando você, blá, blá, blá ...

Se esse “pré-operatório” for bem sucedido, a probabilidade de se chegar à verdadeira meta da conversa, de maneira serena e proveitosa, é incomparavelmente maior. Aprender a lidar de forma adequada com os limites que as resistências impõem à nossa fala é um dos requisitos essenciais para que possamos falar bem.

Mas, antes de seguir adiante, quero expor minha admiração e agradecimento àquele a quem devo o título de meu primeiro livro.

O título

Quando me deparei com o livro “Conversação”, de Theodore Zeldin⁸⁷, eu já havia terminado os originais de meu primeiro livro, mas ainda não havia escolhido um título para ele. Foi desse livro de Zeldin que o título, *A NOVA CONVERSA*, surgiu.

Acompanhemos algumas das propostas que vi ali enunciadas, todas consoantes com o espírito e, por vezes, até com a letra, do que defendo nos dois livros que até agora publiquei. Diz ele:

“Conversar é ... uma das grandes necessidades humanas. Privados disso, nós morremos”.

⁸⁷ Zeldin, T. Op. Cit., p. 54.

O autor tem consciência de que atingir essa Nova Conversa não depende de um mero *laissez faire*. Ele discorda, como eu, da

“opinião de que a conversa ‘vem naturalmente’ ”⁸⁸:

Insistindo em que precisamos:

“aprender a falar do próprio ato de conversar.”⁸⁹

Tem também clara noção do poder transformador da fala, não apenas como instrumento de profissionais:

“as leis não podem mudar mentalidades, as conversas sim.”⁹⁰ ... “a conversa é o único caminho, pois essa, ao contrário das leis, pode mudar as pessoas.”⁹¹ ... “Certas revoluções da conversação tiveram um efeito tão importante quanto muitas guerras, rebeliões e graves crises de escassez.”⁹²

Deixando transparecer sua esperança de que a conversa se torne

“o tipo mais importante de interação humana e o principal agente de mudanças na vida das pessoas”.⁹³

Com efeito, sustenta que cada momento antropológico-cultural exige um tipo próprio de conversa:

“Foram mudanças na maneira de conversar que produziram a Renascença, o Iluminismo, a modernidade e a pós-modernidade”⁹⁴

E completa:

“... é chegada a hora de uma Nova Conversa.”⁹⁵ ... “precisamos inventar um novo tipo de conversa”⁹⁶ ... “Nosso desafio atual é desenvolver um novo tom e um novo tipo de conversa”⁹⁷ (grifo meu)

Frente a essas falas de Zeldin, achei o título de meu primeiro livro, já completado com a sensação de que o escrevera respondendo a uma demanda recebida de além-mar. Na quarta e última parte deste livro, arrisco uma tese sobre as condições antropológicas que deram origem à necessidade de uma *Nova Conversa*..

⁸⁸ Zeldin, T. **Op. cit.**, p. 50.

⁸⁹ Zeldin, T. **Op. cit.**, p. 10.

⁹⁰ Zeldin, T. **Op. cit.**, p. 45.

⁹¹ Zeldin, T. **Op. cit.**, 1ª orelha.

⁹² Zeldin, T. **Op. cit.**, p. 20.

⁹³ Zeldin, T. **Op. cit.**, p. 30-31.

⁹⁴ Zeldin, T. **Op. cit.**, p. 20.

⁹⁵ Zeldin, T. **Op. cit.**, p. 20.

⁹⁶ Zeldin, T. **Op. cit.**, p. 57.

⁹⁷ Zeldin, T. **Op. cit.**, p. 107.

QUARTA PARTE

UM OLHAR ANTROPOLÓGICO

O império do medo

*“Provisoriamente não cantaremos o amor,
que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos.
Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços.
Não cantaremos o ódio, porque esse não existe,
existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro,
o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos,
o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das
igrejas,
cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos
democratas,
cantaremos o medo da morte e o medo de depois da
morte,
depois, morreremos todos, de medo.
E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e
medrosas.”*

(Carlos Drummond de Andrade⁹⁸)

Causa espécie, mas existe um fato candidato à posição de o mais significativo, dentre todos, para a antropologia cultural do *homo sapiens*. O fato a que me refiro é a assombrosa aceleração da expectativa de vida ocorrida nos últimos duzentos anos.

Se causa espécie podermos apontar um único fato como o mais importante, dentre todos, para o humano, mais espécie causa o quão pouco esse fato tem sido aproveitado para a compreensão das viscerais transformações ocorridas, por conta dele, na natureza de nossa cultura.

Com o fito de preencher tal lacuna, lancemos mão de uma lei psicológica, tão inescapável quanto qualquer lei da Física, qual seja: “Redução de ameaça gera descentralização dos processos decisórios”. Um dos melhores exemplos dessa lei é o fato de que certas coletividades primitivas só elegem um chefe e a ele obedecem, em situações de guerra,

Ora, o salto, em duzentos anos, nos países chamados desenvolvidos, de uma expectativa de vida de trinta e cinco anos (século XVIII) para uma de mais de setenta (século XX), e, no mesmo período, de uma população global de 1 bilhão para uma de 6 bilhões de pessoas⁹⁹, queiram ou não os profetas do caos, implica, de forma inescapavelmente concreta, uma redução radical e inédita do nível de ameaça a que está concretamente sujeito o indivíduo humano, o que, segundo a lei psicológica supra referida, nos levaria a prever a ocorrência de uma inescapável e maciça descentralização dos processos políticos ao longo desses duzentos anos, que medeiam aproximadamente entre duas datas de inegável carga simbólica – 1789, Queda da Bastilha, e 1989, Queda

⁹⁸ Andrade, Carlos Drummond de. *Reunião – Dez Livros de Poesia*. Rio: José Olympio, 1973, p. 49.

⁹⁹ Hoje, em 2018, já de 7 bilhões.

do Muro – período que, por representar um verdadeiro “*tipping-point*”, *ponto de inversão*, antropológico, chamarei de “*Os Grandes Duzentos*”. Antes deles, eram regra as autocracias, hereditárias ou ideológicas, e, depois deles, as democracias, republicanas ou não.

A relação diretamente proporcional entre nível de medo e centralização decisória é – de forma ora mais, ora menos, consciente – parte do conhecimento psicológico de todos nós. Qualquer ditador sabe como seus propósitos centralizadores são favorecidos pelo perigo e, se esse último cai por demais, ocupa-se imediatamente de tentar reintroduzi-lo, real ou fantasiosamente, como recurso para se perpetuar no poder. Episódios da história universal – em que sobressai a dos comunistas demonizando os capitalistas e vice-versa – demonstram sobejamente isso e até os “inocentes” papai e mamãe que acenam ao filho com o “bicho-papão” para torná-los mais submissos não estão mais do que operando a partir desse princípio.

Ocorre, no entanto, que, à parte as tentativas dos autocratas de manter um nível de perigo que os sustente no poder, a própria descentralização, operada sem obediência a certas condições que evitem o caos, é capaz de reintroduzir o perigo, provocando novo ciclo centralizador. Alegres “porres” democráticos são, frequentemente, patrocinadores de tristes “ressacas” reacionárias e o exemplo mais próximo e exuberante disso foi o período de conservadorismo político-ideológico que se fez seguir ao clímax libertário de 68. De forma lamentavelmente irônica, os Charles De Gaulle e os Richard Nixon são eternos beneficiários dos Jimmie Hendrix e das Jane Joplin...

Mas retornemos à linha básica de minha argumentação. Se nenhum cataclismo planetário nos remeter globalmente de volta a níveis de expectativa de vida anteriores ao dos *Grandes Duzentos*, podemos, amparados na lei psicológica supramencionada, afirmar que o processo descentralizador

(1) veio para ficar e

(2) está longe de se haver completado.

Isso posto, seria de indiscutível bom alvitre que

(3) tivéssemos clareza sobre quais são as condições necessárias para que essa transição possa ocorrer da maneira a mais azeitada possível e que

(4) algum conhecimento nos ensinasse o que deve ser feito para que essas condições sejam preenchidas.

Quanto às condições necessárias para que o inevitável processo de descentralização apresente uma boa relação custo-benefício, elas, na verdade, resumem-se a uma só:

(1) se parcelas anteriormente centralizadas de poder decisório estão e continuarão sendo, cada vez mais, distribuídas pela massa dos indivíduos que compõem cada sociedade, a condição de sucesso dessa descentralização é a elevação da capacidade decisória desses indivíduos, que se tornarão irremediavelmente mais poderosos..

Que fazer para patrocinar tal elevação? O que vimos até agora: patrocinar a elaboração e divulgação de uma *Nova Conversa*, o que meus livros vêm tentando fazer até aqui.

Mas a mera divulgação, por escrito, da *Nova Conversa*, será suficiente para que pelo menos uma parte significativa dos cidadãos comuns possam implementá-la? O email que nos foi enviado por Leticia¹⁰⁰ e várias outras mensagens similares, vindas por esse e por outros tipos de veículos de comunicação sugerem que sim, mas, embora a experiência demonstre que nem todos são tão capazes quanto Leticia e seu esposo de fazer bom uso da comunicação loganalítica a partir do mero contato com ela sob forma escrita, essa mesma experiência demonstra haver um número suficientemente grande dessas pessoas para que valha a pena divulgar por escrito tal linguagem, que se resume, repito, a “*dar, da maneira mais detalhada possível, palavras às emoções*”¹⁰¹. A essas pessoas caberá construir um imenso projeto psicossanitário, levado adiante por organizações governamentais e não governamentais, profissionais de saúde e população em geral.

Modo Sobrevivência, Modo Bem-Estar

Os Grandes Duzentos começaram a patrocinar um processo, ainda em curso, de passagem de uma cultura organizada segundo o Modo Sobrevivência, para uma cultura organizada segundo o Modo Bem-Estar, que podem, respectivamente, ser assim descritos:

Modo Sobrevivência – Modo de funcionar típico de coletividades ou indivíduos submetidos a altos níveis de medo. É um **modus operandi** politicamente centralizado, que valoriza a uniformidade de conduta, de ânimo hostil, e que, dominado pelo macho, despreza o fraco e a mulher, exaltando, no aqui e agora, a capacidade de suportar a dor, enquanto desvaloriza o usufruto do prazer, tendendo, simultaneamente, à fugadição¹⁰² – comportamental, química ou ideológica – e ao bloqueio da livre transmissão das informações, sendo visceralmente avessa à *Nova Conversa*.

Modo Bem-Estar – Modo de funcionar típico de situações em que a coletividade ou o indivíduo apresentam baixo nível de medo. É um **modus operandi** politicamente descentralizado, que respeita a diversidade de conduta, de caráter amistoso, e que, imparcial no reconhecimento dos valores específicos do homem e da mulher, protege o

¹⁰⁰ Cf. pág. ...

¹⁰¹ Breuer, J. & Freud, S., op. cit..

¹⁰² Modo de aplacar a dor mediante todo tipo de vício, especialmente o associado ao uso de drogas, legalizadas ou não.

fraco, valorizando, no aqui e agora, o usufruto do prazer, sem, entretanto, permitir que ele seja empregado como elemento de alienação, não se opondo, por fim, ao livre trânsito das informações, sendo visceralmente afinado com a *Nova Conversa*. Na verdade, só podendo, de fato, sobreviver, se dela fizer uso.

O remédio

O próximo milênio deverá dedicar-se a um aprofundado processo de saneamento psico-ambiental. Um tal processo que, mediante a disseminação de uma *Nova Conversa*, se dedique a dissolver em nível planetário as memórias hiperestésicas de ameaças primevas que nos mantêm fixados a níveis não mais cabíveis de medo, curando assim a *Neurose Global* que nos vitima e permitindo uma transição mais indolor da *Cultura de Sobrevivência* para a *Cultura do Bem-Estar*, usufrutuária de uma forma de diálogo que ultrapasse o exíguo espaço dos consultórios, sendo posta ao alcance de todos nós.

Poderemos, então, quem sabe, concretizar as esperanças de Arnold:

*“Daqui a algum tempo, talvez, nascerá uma era”,
Mais feliz – ai! – do que nós,
Que, sem rispidez, será sábia
E alegre, sem frivolidade.”¹⁰³*

Afrouxem os cintos e boa viagem!

Rio de Janeiro, 30/01/2019.

¹⁰³ “Years hence, perhaps, may dawn an age, / Happier, alas, than we, / That without hardness will be sage, / And gay, without frivolity.” (Mathew Arnold, poeta e crítico inglês, 1822-1888.)